



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

AMIEL MODESTO VIEIRA

UMA AUTOETNOGRAFIA BIOÉTICA: há cuidado em saúde para a pessoa
Intersexo com genital atípico?

Rio de Janeiro

2024

AMIEL MODESTO VIEIRA

**UMA AUTOETNOGRAFIA BIOÉTICA: há cuidado em saúde para a pessoa
Intersexo com genital atípico?**

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, de instituições de ensino superior associadas, como requisito parcial à obtenção do Título de Doutor em Bioética orientado pelo Professor Doutor Alexandre da Silva Costa.

Rio de Janeiro

2024

V658 Vieira, Amiel Modesto.

Uma autoetnografia bioética: há cuidado em saúde para a pessoa Intersexo com genital atípico? / Amiel Modesto Vieira. – Rio de Janeiro, 2024.

106 f.; 30 cm.

Orientador: Alexandre da Silva Costa.

Tese (Doutorado) - UFRJ/UFF/UERJ/FIOCRUZ. Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, 2024.

Referências: f. 87-93.

1. Intersexualidade. 2. Bioética. 3. Genitália. 4. Cuidado em saúde. I. Costa, Alexandre da Silva. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro. III. Título.

CDD 171.7

FOLHA DE APROVAÇÃO

AMIEL MODESTO VIEIRA

UMA AUTOETNOGRAFIA BIOÉTICA: há cuidado em saúde para a pessoa
Intersexo com genital atípico?

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, em associação UFRJ-FIOCRUZ-UERJ-UFF, como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Bioética Aplicada e Saúde Coletiva.

Aprovada em: 07 de fevereiro de 2024.

Prof. Dr. Alexandre da Silva Costa (Orientador)
UFRJ

Prof^a. Dra. Maria Clara Marques Dias
UFRJ

Prof. Dr. Nelson Fillice de Barros
UNICAMP

Prof^a. Dra. Paula Sandrine Machado
UFRGS

Prof. Dr. Gustavo Antonio Raimondi
UFU

A David e Brian Reimer, Camila Gadelha e Yummi (*in memoriam*). Além de todas as crianças e adultos Intersexualizados que não puderam escrever suas reais histórias por terem sido vitimados pelo poder médico.

AGRADECIMENTOS

Quando fiz esse trabalho, nunca o fiz sozinho. Apesar de a escrita nesta jornada, muitas vezes, ser solitária, várias mãos contribuem durante o trajeto para torná-la realidade. Nesse sentido, posso dizer que sem o auxílio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a realização deste trabalho não seria possível.

Não há palavras suficientes para expressar o amor, o carinho, a mão amiga que foi minha esposa Daniela Ferraz nesse processo. Ao cuidar do meu corpo e alma durante a escrita deste trabalho, ao ler o texto, dar sugestões e zelar por uma saúde que passou por poucas e boas nesses anos. Você é a graça, a leveza, o sorriso e o amor que mesmo nos momentos mais terríveis acreditou em mim e foi o fôlego para seguir esta jornada.

Nesse caminho, partilhei e tive discussões enriquecedoras com muitas pessoas. Destaco duas em especial: Sara York e Fabio Oliveira. Agradeço a possibilidade de ter um diálogo capaz de fazer brotar sementes de conhecimento e, mais do que isso, acreditar nesse trabalho. Espero que nas linhas do texto e dos artigos vocês vejam a inspiração que motivou este produto que é o primeiro de muitos outros trabalhos acadêmicos.

Agradeço aos Orientadores que passaram por esta construção. A Alexandre Costa, meu atual orientador, e a Maria Clara Dias. Clara comprou a ideia desta tese desde o começo – por contingências da vida, teve que passar a orientação para Alexandre. Nesse processo difícil de escrita, eles sempre estiveram presentes e prontos a responder minhas dúvidas.

O PPGBIOS foi uma boa surpresa que conheci por meio da Dani. No PPGBIOS, conheci ótimos professores. Não vou citar nomes, porque posso esquecer algum, porém, àqueles com quem tive aulas e estiverem lendo esse texto, agradeço o tijolinho de conhecimento colocado na minha formação, vocês fazem parte desta história.

Não posso deixar de mencionar a turma de 2017. Sou grato pela oportunidade de fazer parte dessa turma, conhecê-los, ter boas conversas nas aulas e nos intervalos, a partir das quais fiz ótimas amizades, e boa parte delas vou levar para a vida. Minha querida amiga Verônica, foi muito bom partilhar os ótimos momentos entre aulas e na vida com você, espero que continuemos assim. Adianto que, como sou

esquecido, não vou mencionar mais outros nomes porque posso errar, mas sempre que lembrar de vocês espero mencionar meu carinho e gratidão.

Agradeço também a turma de 2015, criadores do PPGBEER, espaço de pessoas e trocas muito especiais, Mabel, Maristela, Lucas, Gabi, Cesar e Carlos, que me aceitaram como intruso do bem e me deram alívio com conversas, boas comidas e muitas risadas que me ajudaram a chegar no texto que leem hoje. Lucas e Mabel têm um lugar muito especial nessa trajetória, obrigado por me ouvir e de alguma forma me impulsionar a escrever.

O mundo virtual também tem que ser citado aqui, pois através dele conheci muitas pessoas que caminham comigo até hoje, como, por exemplo, as pessoas Intersexo no Brasil. Com meus iguais, percebi que não estou só nesta jornada que não é só de uma luta incessante, mas também de afeto e possibilidades. Acredito que vocês não só são uma inspiração para este trabalho, vocês também são o motivo de minha incessante luta pessoal de divulgação da intersexualidade para sairmos da invisibilidade em busca por um mundo mais justo e de direitos.

Anos atrás participei de um grupo no facebook e dele levei amizades muito especiais. Uma em especial quero fazer menção Tomas Eon barreiros, jornalista, poeta, ator e o revisor textual da tese. Um amigo paranaense que do chegar a aquele grupo e sair do virtual para a vida, sempre foi a mão amiga e uma ajuda sempre sincera. Por essa e por outras histórias na jornada da nossa amizade, meu carinho e gratidão são sinceros e afetuosos.

Dois outros nomes a citar e agradecer são os de Verônica Cabral e o de Sueli Feliziani. Duas mulheres negras fortes que para mim são exemplos de inteligência, coragem, carinho e muito afeto. As conheci também através do mundo virtual, não me lembro mais das circunstâncias, mas estão comigo desde os primeiros relatos da minha real e verdadeira transição. São minhas parceiras de vida real e vida acadêmica. Devo ressaltar que desde o primeiro momento que compartilhei as ideias e escritas foram as primeiras a me apoiar nesse projeto de doutoramento que agora se finaliza.

Tenho muito orgulho da luta conjunta em prol da intersexualidade que num esforço conjunto ajudei a instaurar no Brasil, seja com a Abrai ou agora com o coletivo Intersexo Brasil. Danilo, Liah, Alex Ballestrin, Carolina Iara e Vidda, nós somos poucos ainda, mas temos dado grandes passos, como a criação do GT Intersexo no Ministério dos Direitos Humanos, por meio da Secretaria Nacional LGBTIQAPN+,

para discutir questões caras a nós que antes nem éramos vistos pela estrutura do governo brasileiro. Num advocacy contra a mutilação genital Intersexo e toda Intersexofobia que ocorre em nosso país.

Agradeço o contato por e-mail para trocas enriquecedoras, discussões, pedidos de material para Norman Denzin (*in memoriam*), Georgiann Davis, Iain Morland, Jenifer Germon e Lucas Soneghet. E duas menções especiais ao grupo Rede Amiel de Amigos Impertencíveis que com seu apoio e encorajamento, muito me ajudou a finalizar este trabalho, e ao grupo Queer pelas ótimas discussões em gênero e sexualidade que muito me iluminaram no processo.

Ao Universo, registro o meu coração alegre por ter me dado mais uma chance de continuar a viver. Também agradeço o reencontro com minha família e a possibilidade de escrevermos novas histórias para contar e viver. Viva a reescrita de novas histórias e de novos sonhos!

Todas as pessoas, Intersexo ou não, merecem a autonomia para determinar e viver no gênero com que se identificam. A medicina deve apoiar as nossas identidades, não tentar impor-nos identidades.

Cary Gabriel Costello

RESUMO

VIEIRA, Amiel Modesto. **Uma autoetnografia bioética**: há cuidado em saúde para a pessoa Intersexo com genital atípico? Tese (Doutorado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) – Núcleo de Bioética e Ética Aplicada em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

A discussão sobre Intersexualidade é sempre um desafio, ainda mais na bioética, pelo ponto de vista de uma pessoa Intersexo. Busca-se nesta Tese, a partir da metodologia da Autoetnografia e de uma revisão narrativa, abordar o cuidado em saúde para uma pessoa Intersexo de genital atípico. O objetivo da tese é, além de trazer luz à questão, trazer também a bioética sob uma nova perspectiva nessa discussão, tendo em vista que muitas vezes, na prática clínica endocrinológica brasileira, esses corpos são vistos como urgência biológica e social. Os resultados obtidos estão expressos na forma de três artigos: o primeiro apresenta uma autoetnografia do autor sobre o cuidado em saúde dispensado a ele, o segundo faz uma revisão narrativa sobre a cirurgia de redesenho genital pela qual essas pessoas passam, e no terceiro esse cuidado em saúde é analisado a partir do olhar bioético da perspectiva dos funcionamentos.

Palavras-chave: intersexualidade; bioética; genital atípico; cuidado em saúde.

ABSTRACT

VIEIRA, Amiel Modesto. **A bioethical autoethnography**: is there health care for the intersex person with atypical genitals? Thesis (PhD in Bioethics, Applied Ethics and Collective Health) – Center for Bioethics and Applied Ethics in Collective Health, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.

Discussing intersexuality is always a challenge, and even more so in bioethics from the point of view of an intersex person. The aim of this thesis was to use autoethnography methodology and a narrative review to discuss health care for an intersex person with atypical genitalia. The aim of the thesis was not only to shed light on the issue, but also to bring bioethics into this discussion from a new perspective, given that these bodies are often seen as a biological and social emergency in Brazilian endocrinological clinical practice. The results obtained are expressed in the form of three articles: the first presents an autoethnography of the author on the health care provided to him; the second is a narrative review of the genital redesign surgery that these people undergo; and the third analyzes this health care from the bioethical perspective of functionings.

Keywords: intersexuality; bioethics; atypical genitalia; health care.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRAI	Associação Brasileira Intersexo
AAP	American Academy of Pediatrics
CFM	Conselho Federal de Medicina
DSD	Distúrbios do Desenvolvimento Sexual
DNV	Declaração de Nascido Vivo
ISNA	Intersex Society of North America
LWPES	Lawson Wilkins Pediatric Endocrinology Society
PdF	Perspectiva dos Funcionamentos
SIPA	Síndrome de Insensibilidade Parcial a Andrógenos
SPSP	Sociedade de Pediatria de São Paulo
SUS	Sistema Único de Saúde
USA	United States of America

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 JUSTIFICATIVA	14
2 OBJETIVOS.....	19
2.1 GERAL	19
2.2 ESPECÍFICOS	19
3 METODOLOGIA	20
4 RESULTADOS.....	24
4.1 UMA JORNADA INTERSEXO DE AUTORRECONHECIMENTO E REFLEXÃO	26
4.1.1 Introdução.....	26
4.1.2 A metodologia de um <i>Eu Intersexo</i>	27
4.1.3 Intersexualizar meu corpo: Um apagar e um silenciar da norma	29
4.1.4 Conclusão do texto, mas não do recomeço... ..	35
4.2 UM PLANO “PERFEITO”: POR UMA SUBJETIVIDADE MÉDICA INTERSEXO.	43
4.2.1 Introdução.....	43
4.2.2 A cirurgia no corpo Intersexo	45
4.2.2.1 O Genital como assinatura.....	47
4.2.2.2 A Racionalidade médica e o sujeito intersexo	48
4.2.3 Conclusão	51
4.3 INTERSEXUALIDADE: SOB O FOCO MORAL E POLÍTICO DA PERSPECTIVA DOS FUNCIONAMENTOS.....	55
4.3.1 Introdução	55
4.3.2 Uma caracterização funcional do que somos.....	56
4.3.3 A pessoa Intersexo: funcionamentos negados/negligenciados	60
4.3.4 O que deveria ser normal?	61
4.3.5 Um movimento incômodo	64
4.3.6 Sobre os Funcionamentos Intersexo.....	69
5 DISCUSSÃO	77
6 CONCLUSÃO	82
REFERÊNCIAS.....	86
APENDICE.....	93
APÊNDICE A – SITES, LISTA DE LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS OU ARTIGOS FEITOS POR PESSOAS INTERSEXO	94

1 INTRODUÇÃO

Este texto foi escrito após um grave acidente, uma recuperação em curso e duas cirurgias. Um texto feito entre pensamentos de desistência de doutorado, de vida e luta. Aqui escreve um sobrevivente da Intersexofobia¹ presente em nossa sociedade, e meu intento é buscar aproximar, mesmo que a uma certa distância, quem lê daquilo que se fala.

A Intersexualidade pode se apresentar de forma visível ou invisível e se torna material através do corpo humano. Ela se manifesta a partir do excesso ou da falta de características sexuais do indivíduo, tais como cromossomos, hormônios, gônadas e genitais. A intersexualidade pode aparecer em corpos na infância à adolescência, e seus efeitos continuam pela idade adulta. Diante desse corpo dissidente, a Intersexofobia se apresenta e em geral é praticada pela medicina que faz o “serviço sujo” de “maquiar”, a partir de cirurgias plásticas genitais e/ou hormonizações induzidas, genitais e corpos nos quais se produziu aquilo que a sociedade não aceita como possível (Carpenter, 2020).

Nossa corporalidade incomoda a norma, e o segredo, o silêncio, a cirurgia e hormonização induzida são armas de uma estrutura que diante da realidade dos estados Intersexo procuram apagar a existência de nossos corpos (Acioly, 2007; Cortez, 2015, 2020; Costa, 2014, 2018; Machado, 2008; Lima, 2014; Pires, 2015, 2021). Mais do que nunca, é importante falar da Endonormatividade² como uma realidade.

Desde minha descoberta, anos atrás, na pesquisa por relatos³ iguais ou próximos aos meus, percebi que o que passei, para a comunidade Intersexo, era uma mutilação, pelo fato de não haver consentimento da criança com genitália atípica para

¹ Nota do autor: “promoção de sentimentos negativos e atitudes expressos diante de pessoas que se acredita conterem traços de intersexualidade no nascimento ou por apresentar uma expressão corporal que não demonstre estar dentro do que se entende por masculino e feminino” Tradução do autor (Costello, 2010).

² A endonormatividade é um conceito que abordado no livro *Transformations in Queer, Trans, and Intersex Health and Aging* (2020). Este conceito aponta para uma norma social que é aplicada pelo poder médico na busca por apagar nos corpos Intersexo quaisquer traços de intersexualidade que o corpo possa ter. Esse apagamento se dá via hormonização induzida ou a cirurgia de redesenho genital, impedindo assim a detecção destes traços que revelariam que aquele é um corpo desviante.

³ Em dezembro de 2015, começou a funcionar a página do Facebook visibilidade Intersexo. Nela, encontram-se relatos traduzidos de várias pessoas Intersexo ao redor do mundo. Logo após minha descoberta, acessei o site da Intersex Society of North America (ISNA), berço de muitas das informações sobre intersexualidade, e uma fundação Intersexo que acabou sendo transformada na Accord Alliance.

ser operada para a retirada dessa genitália. A comunidade Intersexo entende isso como mutilação (Schiavon; Favero; Machado, 2020).

O destino dessas pessoas, consideradas ignóbeis, costuma ser decidido em um acordo entre médicos e responsáveis (Machado, 2008), tornando desprovidos de agência esses sujeitos, normalmente tutelados por uma família que acredita que o correto é dar-lhes um futuro de uma heterossexualidade compulsória⁴ e uma biologia que trabalha para tal fim. Esse acordo ignora a autonomia dessas pessoas para atingir os desejos da medicina e da sociedade. O sujeito, seja qual for o destino acordado entre essas duas instituições sociais, família e medicina, passa então a adquirir uma *identidade cirúrgica* (Guimarães Junior, 2014).

Essa é história de muitas pessoas em estado Intersexo⁵ em que a identidade assumida após a cirurgia muitas vezes é realizada sem a consciência e o entendimento reais do indivíduo. Passa-se a crer numa identidade de gênero e numa orientação sexual osmótica⁶ fruto das armas apontadas mais acima, sem o acesso a sua história pregressa, guardadas pelas estruturas sociais a favor da endonormatividade (Nowakoski; Sumerau; Lampe, 2020).

A trajetória da pesquisa sobre o assunto em ciências humanas e sociais é relativamente recente (Machado, 2014), a hegemonia destes trabalhos procedia do campo médico. Porém, isso começou a mudar na primeira década dos anos 2000 e continua mudando. O que ainda falta – e é o proposto neste trabalho – é uma pessoa Intersexo falar da intersexualidade na academia.

Nesse sentido, esta tese se torna mais um trabalho político e acadêmico. Aqui se pretende um trabalho que irá mostrar um olhar a partir de dentro da realidade de uma pessoa Intersexo. Mais do que um texto que discute com outros sobre o tema, busca-se aqui questionar fatos marcados com carne e sangue numa relação entre

⁴ Apesar de este conceito ser usado no texto de uma intelectual lésbica como Adrienne Rich (2010) com um objetivo específico para uma determinada comunidade, trabalhos em ciências humanas (Morland, 2022; York, 2020) destacam que corpos e sexualidades fora do que a sociedade entende como destino de todos também estão subjugados por essa compulsoriedade

⁵ Lima (2007), Sandrine (2008), Costa (2014, 2018), Pires (2014, 2020).

⁶ “A osmose é a passagem do solvente (água pura) pela membrana semipermeável. Essa reação é realizada até que a pressão osmótica fique estabilizada. Diante disso, a passagem da água ocorre da solução mais diluída (menos concentrada) para a mais concentrada. A osmose ocorre sempre que existe uma diferença de concentração entre o meio externo e interno da célula. A principal função da osmose é permitir os processos de troca de nutrientes das células animais e vegetais, no intuito de estabelecer um equilíbrio.” (Teixeira, 2021, p.12). No texto, a palavra é usada em sentido figurado, significando que, por meio da criação e da educação da criança em um gênero escolhido pelo poder médico, ela acabará por aceitar o gênero que lhe foi imposto, sem nunca questionar.

medicina e sociedade a respeito de práticas mutilatórias que ainda acontecem no Brasil e no mundo.

1.1 JUSTIFICATIVA

Até 2014, eu não sabia o que era intersexualidade, mas inúmeras questões sempre me incomodaram. Eram muitas perguntas sobre, por exemplo, por que eu era tão baixinha e por que devia ir ao hospital toda semana/mês. Apesar de muitas terem sido respondidas com o tempo, algumas permanecem. A partir de 2015, essas perguntas foram tomando forma. Pude, com o desvelar da minha condição biológica, trilhar esse processo de perguntas e respostas. Não foi nada fácil, mas, quando pude me abrir para as perguntas, começou uma trilha nova na minha jornada pela vida.

A primeira “pessoa” a quem perguntei foi a um buscador, o Google[©], e ele me respondeu em espanhol e inglês. Havia coisas em português, mas eram textos acadêmicos que depois passei a ler neste doutorado. Naquele momento, porém queria textos que me respondessem com histórias pessoais, e os primeiros achados mostravam páginas em espanhol no Facebook[©]. Na época, essas respostas estavam relacionadas ao termo que estava numa carta que encontrei naquele ano. A palavra que procurava era Síndrome de Insensibilidade Parcial aos Andrógenos (Sipa), e outra lhe fazia companhia: Intersexo.

Meu primeiro contato com a Intersexualidade foi virtual, ele demorou para se materializar. Isso só aconteceu graças à marcha de mulheres lésbicas e bissexuais de São Paulo, cidade onde morava. Esse encontro ocorreu em 2016, numa palestra sobre Intersexualidade e Lesbianidade. O encontro físico, com um homem trans e uma pessoa não-binária Intersexo, ali vi e percebi que não era o único – impressão muito comum em pessoas sem conexões Intersexo.

Aquele momento marcou meu passado e ainda marca meu presente. A partir dele, coloco meu corpo ainda mais a serviço do ativismo. Antes de contar minha história mais atual, preciso falar daquilo que pouco conhecia: o prontuário médico, que me “voltar a fita” para o começo dessa história.

Tudo começa com promessas de uma vida e um futuro melhores para duas pessoas vindas do Nordeste em São Paulo. Meus pais saíram de Mutuípe e

Valença, na Bahia, e se encontraram no curso de Contabilidade da faculdade Álvares Penteado na capital paulista. Ficaram amigos, a amizade evoluiu, apaixonaram-se e se casaram em 1980. Eles trabalhavam como chaveiro/sapateiro e empregada doméstica.

Minha mãe engravidou e a notícia trouxe muita alegria a eles e os familiares, porém, tornou-se preocupação após o nascimento, quando ouviram: “Nasceu sua criança”. A pergunta que os rondava era: Por que não se falou ou confirmou o sexo da criança? Meu nascimento tornou-se um misto de sentimentos: nervosismo, curiosidade, preocupação. Os médicos informaram ao jovem pai que a criança tinha quase todas as características confirmadas nos últimos exames pré-natais, porém, o genital inspirava paciência, pois fora diagnosticado com genital atípico, ou seja, ainda não era possível identificar o sexo biológico pela genitália.

Seguiram-se exames e consultas na busca de saber o “verdadeiro sexo”⁷ (Foucault, 1982) que aparentemente o genital não revelava. O que se descobriu meses após o nascimento é que a informação genética da criança era de cariótipo ⁸XY (sexo masculino) com um genital de 1 cm de extensão, permanecendo assim até os sete meses, além de hipospadias⁹, o que para os médicos era mais uma preocupação. Os exames diagnosticaram a uretra da criança como do tipo masculino e o fato de ter um genital pequeno após meses de nascido, parecia não aventar um bom futuro para a criança em relação ao ato de urinar (Orr, 2019).

Figura 1 - Diagnóstico da uretra

Foi avaliada pl endócrino antes
período de internação onde
foi feita a hipótese diagnóstica
de Pseudo hermafrodismo mascu-
no
Genitofecia: uretra do tipo masculi-

Fonte: Arquivo pessoal.

⁷ Segundo Foucault (1983) o verdadeiro sexo na época de Herculine era o sexo gonádico, porém hoje com o advento dos hormônios e a genética, será que o sexo dela seria o sexo cravado *pós-mortem*?

⁸ Exame que analisa os cromossomos da criança.

⁹ Impedimento na uretra que, nesse caso específico, faz com a criança urine sentada, já que o genital, em sua formação, não permitiu que a uretra se colocasse no final do membro. como era esperado pelos médicos.

Para a medicina carregada de valores sociais heteronormativos, só havia uma forma de resolver a questão: realizando uma operação de feminilização para adequar a criança ao corpo de uma menina. Segundo o texto registrado no prontuário, ainda havia um último teste a ser feito: passar uma certa quantidade de creme de testosterona durante alguns dias no genital da criança e repetir o feito com o uso de outra dosagem numa nova aplicação por mais alguns dias.

Pelo que comentei com meu atual endocrinologista, o objetivo da aplicação do creme era que o casal observasse alguma diferença cutânea na região genital produzida pelo creme e comunicasse na consulta seguinte. Assim, os pais poderiam ver (ou não) com os próprios olhos¹⁰ e relatar a equipe se houvesse mudanças.

O casal relatou que nada anormal ocorreu após a aplicação¹¹. Os pais foram comunicados que em 14 de março daquele ano¹² a criança seria operada para o feminino. O redesenho cirúrgico ocorreria em duas etapas: a primeira havia sido realizada com uma gonadectomia e plástica da região genital, já a segunda ocorreria após o início da hormonização, com a construção de uma neovagina.

Para todos os envolvidos, parecia que o problema estava resolvido. A orientação da equipe de endocrinologistas que acompanhou o casal e a criança era de que, a partir da cirurgia, seria muito importante uma reafirmação do gênero feminino durante sua criação.

Até completar dez anos, as idas ao consultório de endocrinologia aconteciam de seis em seis meses. Para dar início a segunda parte do que fora planejado foi realizada uma avaliação psicológica da criança e dos pais, buscando confirmar a possibilidade de início da mesma. Foi feita a avaliação e após a sua realização a equipe começou a prescrição de hormônios do crescimento e feminino para a criança, de modo a garantir o desenvolvimento dos caracteres secundários femininos, responsáveis por dar a forma e a aparência que cooperassem com a decisão da cirurgia realizada na tenra infância.

Tudo isso ocorreu no hospital das clínicas de São Paulo, um dos hospitais-referência quando falamos em cuidados em saúde para a intersexualidade no Brasil. Adolescentes vem de vários lugares no país para fazer esta cirurgia de neovagina

¹⁰ Nota do autor: Hoje, parece-me que era esse o objetivo do exame, para que os pais concordassem com a cirurgia de feminilização.

¹¹ Apesar de não haver nada aparente, exames de sangue feitos na criança naquele dia mostraram que o creme dobrou a quantidade de testosterona produzida.

¹² 1983.

ali. Porém o hospital só tem um único e disputado quarto para adolescentes na ginecologia. Equalizar a agenda cirúrgica com esta situação produziu uma espera que durou seis anos, sendo ainda acrescentados mais dois anos devido a uma intercorrência¹³ que impediu a cirurgia.

Durante o período entre 12 e 20 anos, como adolescente e jovem, fui levada a acreditar que parar com o uso contínuo do hormônio feminino poderia me levar à morte, segundo os médicos. O incômodo com a inadequação ao corpo levou-me a acreditar na última cirurgia prevista pelo protocolo, como a resposta para o encaixe no estereótipo de gênero para o qual fui direcionada pela medicina e por meus pais.

Após esse breve relato, o leitor deve se perguntar então, o que justifica esta tese? Durante muitos anos, a intersexualidade esteve sob a égide do poder médico. Materializou-se em artigos e livros no Brasil e no mundo. Depois, tornou-se assunto mais conhecido das ciências humanas, e, na maioria dos livros e publicações existentes, sempre foi pesquisada por pessoas endossexo com suas análises.

Este trabalho é produzido por uma pessoa Intersexo e se utiliza de autores endossexo e Intersexo para trazer com seus atravessamentos mais luz e acrescentar mais perguntas ao tema. Proponho expandir o olhar científico que trabalha a intersexualidade. Assim como defendem Haraway (2009) e Góes (2019),

Donna Haraway [...] propõe a objetividade como visão parcial. Isto significa não um olhar semelhante ao de um deus onipresente, que tudo olha e nada vê, e sim como um olhar que parte de um corpo humano, localizado territorial, social e temporalmente. Assim, Haraway propõe uma visão corporificada, que produz um conhecimento corporificado e, como tal, localizado e parcial. A corporificação do conhecimento implica em se posicionar, ou seja, compreender que o saber é produzido por corpos e reconhecer a localização social e política que estes ocupam na estrutura. A objetividade é, então, um conhecimento localizado (Góes, 2019, p. 4).

Com esta proposição das autoras me percebo como um artífice que convida a quem lê esse trabalho a considerá-lo como um produto autoetnográfico de uma oficina da reflexão sobre a ciência com uso da tecnologia médica que me re-esculpiu

¹³ A cirurgia realizada testava uma técnica nova dividida em duas etapas. Cirurgia que inseriu um expansor de pele que deveria ser enchido com ar por uma seringa, expandindo a pele do abdômen, sendo que a segunda cirurgia seria o uso da pele expandida para fazer a neovagina. Houve rejeição ao expansor, o que fez com que a nova cirurgia, por causa da agenda, ocorresse dois anos depois, utilizando parte da pele da perna direita para a neovagina.

e passa por um revisitar que faço ao longo destas páginas.

Admito buscar nas páginas que se seguem, colocar que a parcialidade de um fazer ciência que sabe da inexistência de uma neutralidade principalmente numa pesquisa que trabalha com autoetnografia e revisão narrativa. Desta forma é importante pontuar que este é um fazer ciência consciente de suas possibilidades de acertos e erros.

Nesse sentido a pedagogia da esperança de Paulo Freire produz naquele que aqui escreve, um esperar-semente. De que esta tese, contribua para enriquecer a pesquisa Intersexo no país e que seja o primeiro de muitos trabalhos sobre o tema. Fica aqui um convite e uma responsabilidade para você que lê, o convite para que seja um semeador deste sonho e venha a contribuir para o reflorestar de uma academia outra, onde o/a/e Intersexo seja fundamento de um falar de si e que não se restrinja só a intersexualidade ou de outros temas.

2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Analisar o cuidado em saúde dedicado à pessoa Intersexo com genital atípico visto como “urgência biológica e social” no país.

2.2 ESPECÍFICOS

- Problematizar a (des)naturalização dos corpos Intersexo pela sociedade, como meio para a (não) promoção da justiça social e reconhecimento de corpos com esses genitais;
- Apresentar através da metodologia da autoetnografia performática os desafios impostos pa intersexualidade de genitália atípica em meu corpo e também a partir de outros relatos de corpos intersexo e discutir as cirurgias estéticas corretivas realizadas em bebês com essa condição;
- Apresentar a perspectiva bioética dos funcionamentos com vistas ao florescimento do ser humano, em especial o indivíduo Intersexo, inclusive as vítimas de mutilação genital Intersexo.

3 METODOLOGIA

Para a realização desta tese, foram considerados vários métodos, pensando as diversas formas de escrever a respeito da intersexualidade. Raimondi *et al.* (2020) contribui para essa reflexão metodológica, tratando da utilização de um tipo específico de pesquisa que nasceu na antropologia, um método científico e uma aposta metodológica que começa a aparecer no campo da saúde.

Este método soma o Eu e a escrita e, nesse sentido, aponta que

[os] estudos de performance [...] compreendem o corpo e suas performances como um local privilegiado para a produção de conhecimento, a autoetnografia performática, um dos tipos possíveis de autoetnografia, apresenta-se como uma estratégia “método+lógica” que promove a quebra de silêncios individuais-coletivos relacionados a sistemas de relações e produção de conhecimento hegemônicos, eurocêtricos, brancos, patriarcais, machistas e cis-heterossexistas (Raimondi *et al.*, 2020, p. 2).

A composição da tese e seus artigos analisa o Eu inserido em uma sociedade (etno) mediado por uma cultura numa proposição de resistência entre o Eu e a Cultura. Nesse sentido, aqui se busca analisar essa relação através da escrita (Grafia) apontando lógicas hegemônicas numa reescrita de si (Foucault, 2006).

Ao mesmo tempo, de modo mais específico, inscrevo-me num grupo social que também é foco deste trabalho: pessoas Intersexo com genital atípico. Isso significa dizer que, apesar dos vários estados podem levar ao surgimento desse genital¹⁴, uma medicina heterocentrada e endossexo procura apagar a existência da intersexualidade desses corpos (Preciado, 2014; Gomes, 2015; Costa, 2016; Cortez, 2015)

Estes corpos são parte de um “teatro” do cotidiano, como apreende-se de Goffman (2013) num ato político de re[ex]istência contínuo. Pois, como coloca Denzin (2003, p. 258, tradução nossa), nesses “espaços discursivos da performatividade não existe qualquer distância entre a performance e a política que encena. As duas estão interligadas, cada uma alimentando a outra, faces opostas da mesma moeda, uma e a mesma coisa¹⁵”.

¹⁴ N.A: Em conversa com uma ginecologista aliada.

¹⁵ No original: In the discursive spaces of performativity there is no distance between the performance

Desse modo, pode-se dizer que o pessoal é político, assim como seu oposto. Procura-se aqui ressaltar a formação de uma identidade que em sua luta anseia por um mundo que desaprenda a prática das opressões na reconstrução de outra sociedade. Uma sociedade onde basta existir para que haja respeito e não se exerçam violências de qualquer tipo, mesmo que desejem “curar” os corpos dissidentes.

Por meio desses artigos entremeados pela autoetnografia performática com meu conhecimento situado (Haraway, 2009), quero tensionar o organismo social, a medicina e a ciência. Procuo mostrar uma reconstrução de si que transcende minha (ex)certidão de nascimento numa retomada do meu território-corpo (Micha, 2022), após anos de silêncio e segredo que, por meio desta e de minha história, estou a reconstruir.

Este texto pode provocar dissenso ou esperança. Um texto em que se busca adotar a perspectiva freireana de ser uma escrita pedagógica aliada a uma sociologia que busca um outro porvir, como a imaginação sociológica de Charles Wright Mills (1982). Aqui se pontuam os males trazidos para os corpos-alvo deste texto, num esperar por mudanças em um futuro diferente (Denzin, 2003).

A metodologia da autoetnografia performativa é também uma metodologia que intervém no mundo. Uma escrita pedagógica com um olhar ético e libertador que revela as opressões que sofrem os corpos Intersexo de genital atípico. Uma pedagogia que pretende nestas linhas contribuir para libertar leitores que tenham tido histórias iguais ou similares a minha.

Este texto se apresenta com outra pedagogia freireana que além de libertar é escrita numa pedagogia do esperar, por meio de uma reflexão bioética utilizando da perspectiva dos funcionamentos (Dias, 2019) em que corpos Intersexo, com seus corpos biológico intocados, possam viver em plenitude. Corpos esses nos quais o ser seja mais importante que o ter.

Aqui se coloca um esperar que não é uma atitude sonhadora simplesmente, ela é questionadora. Numa interrogação do presente, num atrito com uma prática Intersexofóbica na qual a cirurgia como solução primeira é analisada para entender seu propósito, além de suas marcas e resultados (Morland, 2022).

A autoetnografia funciona como vitrine e ferramenta. Ela mostra como cada

um pode ter experiências universais, porém, a singularidade de alguém diante de cada experiência se revela ante esse momento histórico para todos, mas com um significado particular para cada um (Denzin, 2003).

Não só a autoetnografia e a inserção de narrativas permeiam os artigos desta tese. Durante sua elaboração, foi feito um levantamento bibliográfico que resultou numa revisão narrativa, uma metodologia muito utilizada no campo da saúde. Foi realizada uma pesquisa na plataforma Scielo e no Google® acadêmico sobre intersexualidade e autoetnografia. No Scielo, procuraram-se termos em português, e no Google Scholar, em português e inglês.

Após a pesquisa, foi feita pelo autor da tese uma seleção de livros e artigos, utilizando-se essa metodologia, que consiste numa abordagem em que aparece a subjetividade de quem está escrevendo a tese. Nesse sentido, entre o levantamento bibliográfico e a escolha final do material que servirá de suporte para os artigos a escrever, estão critérios específicos do autor/pesquisador que nortearam a construção final dos artigos como destaca o texto a seguir (Grant; Booth, 2009).

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, apropriada para discutir o estado da arte de determinado assunto com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado objetivo. As revisões narrativas não adotam os critérios a priori para a seleção das publicações. [Ocorre aqui]... interpretação da literatura existente de um determinado assunto de acordo com análise crítica pessoal do autor (Cordeiro *et al.*, 2007, p. 2).

Faz-se importante aqui ressaltar o fato de que nem sempre os critérios ou os caminhos que nortearam os artigos ficam explícitos, porém o que se busca fazer é um trabalho contracolonial inclusive em seu método. Utilizo aqui de um método que nasceu na prática médica onde os artigos são produzidos com

uma vasta gama de questões relacionadas com um determinado tópico [...]estabelecer e podem integrar conceitualmente dois campos de investigação campos de investigação independentes, [no caso, a bioética e a saúde] devidamente adaptados às circunstâncias e valores locais (Cook; Mulrow; Haynes, 1997, p. 377-378, tradução nossa).

Porém, numa tese que prega a valorização da subjetividade pelo poder médico, essa valorização vale para o texto também, mesmo que meu corpo e subjetividade coloquem em xeque a parcialidade requerida pela ciência e suas opressões.

Este trabalho transita por uma prática científica que segundo Raimondi *et al.* (2020, p. 10):

[fica nele explícito] uma negociação de fronteiras entre identidades, diferenças, distanciamentos e comprometimentos com a justiça social no próprio corpo, uma vez que este é o primeiro local e o local privilegiado do saber. Com essas ligações, promovem-se “possibilidades de resistência, esperança e liberdade” na pesquisa e escrita, sendo o mundo, assim, “cheio de possibilidades perigosas e fantásticas.

Pode-se argumentar que esta tese perderia seu valor científico por ser um trabalho que se assume como militante, inclusive em seu método. Neste trabalho fica explícito que a vida ativa e em movimento é uma vida muitas vezes movida pela dúvida, a incerteza e o não-lugar. Como Pollock (2006) pontua, ao falar de performance a teoria e nesse caso sua relação com o texto, o que se apreende desta relação é que ela é uma relação de movimento.

Nesse sentido, pode-se pontuar aqui que o movimento advindo dessa relação também é o movimento de uma bioética ativa, crítica e incomodada com as desigualdades e com a injustiça social que assolam este país. Uma bioética do desconforto, preocupada, ativa e fora do gabinete. Saindo do sufocamento do principialismo, oportunizando-se de outras perspectivas para não morrer no esquecimento e mirrada.

4 RESULTADOS

Diante do exposto, faz-se necessário levantar alguns questionamentos. Primeiramente, é preciso apresentar a realidade de corpos Intersexo que possuem genital atípico não só como vítimas do poder médico, mas interpretar esses fatos como Intersexo pesquisador. Convém examinar de modo crítico essas situações a fim de levantar questões e conceitos importantes.

Este trabalho parte do experiencial, mas não pretende se limitar a ele. O que se busca é se basear nos apontamentos relevantes de pessoas com estado Intersexo e endossexo aliados, ativistas, acadêmicos, para tratar de uma luta ainda invisível no país. E, junto a essas pessoas, colocar em xeque o poder médico, a falta de inteligibilidade de sua materialidade e o resultado do domínio sobre eles como um desafio para a luta Intersexo.

A medicina produz a sociedade Intersexofóbica que vivemos, reservando para si o direito de “resolver a questão”, privando a sociedade de discutir o assunto. Trata-se de uma teia de poder que emana da sociedade para a medicina (Foucault, 2008), na qual o cuidado em saúde se coloca sobre o corpo de alguém que tenha nascido fora da ordem do sistema heterocentrado (Preciado, 2014), silenciando uma existência em favor da manutenção desse sistema. Partindo da intersexualidade de genital atípico, procura-se com este trabalho apresentar a necessidade de se perceber o corpo com o “biológico”, mas não se limitando a ele, indo além dos corpos sexualmente atípicos, fora do padrão heteronormativo. Para Preciado, na sociedade, “o corpo só tem sentido como sexuado, [já que] um corpo sem sexo é monstruoso” (Preciado, 2014, p. 131). Além disso, destaca ele que:

a regra de ordenação do corpo [adotada pelos médicos] é visual e não cromossômica. Como se os olhos fossem finalmente os encarregados de estabelecer a verdade do gênero verificando a correspondência entre os órgãos anatômicos e uma ordem sexual ideal binária. Dito de outro modo, nós não somos capazes de visualizar um corpo fora de um sistema de representação sexual heterocentrado (Preciado, 2014, p. 136).

Desse modo, pensando com a socióloga canadense Janik Bastien Charlebois (2017), busca-se aqui refletir sobre conceitos trazidos pelos estudos Intersexo na

discussão sobre o que é ser Intersexo, intersexualizado e a intersexualização dentro de um sistema que é muito mais poderoso e que engloba o patriarcado e as ideias de normatividades ao que chamo de sistema endossexo.

O primeiro artigo tem por objetivo apresentar uma autoetnografia, trazendo questões como a composição do corpo em sua história, a fim de colocar como paradigma o corpo nomeado pela medicina e seu poder de categorizar corpos como “doentes” e saudáveis por meio da intersexualização (Charlebois, 2017). Em seguida, busca questionar como esse corpo dissidente pode se conhecer e se perceber com e para além das categorias médicas. Mais do que apresentar uma história ou contá-la, a autoetnografia performática (Denzin, 2018) como método nos situa diante das ferramentas de percepção e estar no mundo para se reescrever e estar não só no mundo, mas na vida.

O segundo artigo aborda a cirurgia a que pessoas com estado Intersexo de genitália atípica são submetidos. Esse artigo tem por objetivo discutir e analisar o processo pelo qual a medicina e a sociedade se irmanam: uma faz a escrita no corpo Intersexo, a outra vai ler aquele corpo como um corpo não-dissidente. Segundo Iain Morland (2022), mesmo que uma reescrita se destine a apagar a escrita original, na verdade, esta nunca se apaga, ou seja, além de não conseguir o que deseja, torna o redesenho aberrante.

O último artigo tem por premissa colocar a perspectiva bioética dos funcionamentos para orientar a discussão sobre os corpos foco desta tese. Propõe-se aqui analisar o cuidado em saúde dispensado a pessoas com genitália atípica. Faz-se importante, nos arcabouços teóricos apresentados, apresentar um olhar de cuidado em saúde que seja emancipador. Como Dias (2019) pontua, é importante que ele seja localizado priorizando um cuidado dialogado entre o médico e o paciente. Nesse sentido, as histórias são ali apresentadas de forma breve, atentando-se aos funcionamentos essenciais para uma forma específica de intersexualidade, correlacionadas as aproximações e distanciamentos que outras formas de manifestação dela possam ter. O que se pretende aqui é tornar cada vez mais explícito que cuidado em saúde que não apresenta a subjetividade como ingrediente fundamental nessa perspectiva bioética é tratamento e não um cuidado real em saúde (Dias, 2019; Barros, 2020).

Concluimos esta breve apresentação dos textos salientando que, no contexto brasileiro, Cortez (2015) e Guimarães Junior (2014) já forneceram distintas

contribuições à questão da intersexualidade sob o ponto de vista bioético. Lembrando que, muitas vezes, na formação de profissionais da saúde e da medicina, ao se falar em bioética, podem ser lembrados os princípios de autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Pode-se dizer que esta é a teoria bioética mais conhecida nos campos médico e de saúde brasileiro (Diniz; Guilhem, 2002).

Faz-se necessário expandir o olhar restrito ao uso da bioética e ir além na crítica ao principialismo que muitas vezes se esquece de colocar em suas análises que na prática médica são acionados privilégios de gênero, raça e classe que precisam ser considerados. Por isso, será utilizada aqui como aparato teórico e propositivo a perspectiva dos funcionamentos e seu olhar holístico quanto ao florescimento da pessoa com estado Intersexo.

4.1 UMA JORNADA INTERSEXO DE AUTORRECONHECIMENTO E REFLEXÃO

4.1.1 Introdução

O presente artigo nasce do narrar minha história Intersexo. Com uma escrita em primeira pessoa e utilizando da metodologia autoetnográfica abordada por autores como Conquergood (1998), Jones (2005) e Simakawa (2015), o objetivo deste emprego é aproximar o leitor da vida e da história de uma pessoa Intersexo. Esta história começa com a descoberta de um Eu Intersexo e de outras pessoas Intersexo, a fim de, junto com o leitor, aprendermos sobre a intersexualidade e repensarmos nossa relação com a sociedade. A partir disso, estes tópicos serão apresentados e discutidos aqui.

O artigo será dividido em três seções. Na primeira, abordo a metodologia autoetnográfica e, a partir dela, minha descoberta a respeito da intersexualidade. Na segunda seção, falo do meu reencontro com minha própria história e relato a leitura que fiz do prontuário médico, leitura esta que me surpreendeu e ao mesmo tempo me fez passar a entender o processo de nomeação e apagamento do meu corpo pelo poder médico. Por fim, problematizo esses processos para a manutenção e reprodução de uma norma cisgênero, endossexo e heterossexual.

Apesar de já existirem pesquisas nesse campo no Brasil, na medicina e nas ciências humanas, acredito que este é um dos primeiros artigos em primeira pessoa e em português nessa temática. É importante salientar que, enquanto ativista

Intersexo e pesquisador acadêmico em Bioética, este artigo e minha tese comungam da necessidade de fazer uma ponte entre a academia e a sociedade.

Outro ponto a ressaltar é a escolha da área da Bioética como campo de pesquisa. Esse interesse se deu por perceber neste campo multidisciplinar a oportunidade de tensionar e discutir, com acadêmicos e autores das áreas da saúde, medicina, direito e filosofia sobre a mutilação genital de pessoas Intersexo, seus efeitos e consequências na vida desses indivíduos. A partir de agora, o que se segue é um texto que procura condensar, usando a metodologia científica, a vivência e os questionamentos levantados por meu encontro com a intersexualidade, que continuam a reverberar no presente e no futuro.

4.1.2 A metodologia de um *Eu Intersexo*

As variadas situações que vivi são de um indivíduo que, junto a outros, auxiliou a pôr as pedras para começar a construção de um movimento que segue crescendo. Esta é uma autoetnografia em que essa mistura ora se percebe, ora se confunde, como ressalta Butler (1993), asseverada na dissertação de Simakawa (2015, p. 22-23):

Gradualmente, assim, fui sentindo que, para produzir um trabalho acadêmico crítico sobre diversidades corporais e de identidades de gênero, implicar minhas próprias experiências e refletir sobre como minha subjetividade enquanto pesquisadora trans se constituía como requisitos fundamentais, particularmente em um contexto em que exclusões e marginalizações de pessoas trans* e gênero-diversas restringem as complexidades destas existências. Neste sentido, pensar as des+colonizações de corpos e gêneros inconformes requereria trazer meu corpo e minhas vivências, minha “vida corporal que não pode estar ausente da teorização”¹⁶.

Nesse sentido, este trabalho é uma autoetnografia de um corpo que além de ser Intersexo se percebe como trans. Uma pessoa que fora colonizado pela medicina e que até a descoberta da intersexualidade começou a se dar conta e nomear o sentimento intraduzível que o acompanhou por toda sua vida. Depois disso, se permitiu uma descolonização de corpo e gênero. Com essa consciência de si, protagonizou a recusa de uma epistemologia cartesiana, mudando sua percepção

¹⁶ Texto traduzido por Simakawa (2015).

para uma nova, em que as falas de Glória Andalzúa (2000) ecoam: “Não podemos deixar que nos rotulem. Devemos priorizar nossa própria escrita e a das[es] [Trans e pessoas Intersexo] do terceiro mundo”.

Assim, faz-se necessário ressaltar que esta é uma autoetnografia performática, ou seja, uma metodologia com o objetivo de interpelar, interrogar e questionar. Portanto este trabalho busca expor questões e dilemas cotidianos de uma pessoa Intersexo, cujo própria vida esteve sob a orientação de outrem. Aqui há um retomar da posse de si e essa escrita flui como cita Brilhante e Moreira (2016, p. 765):

A autoetnografia é um gênero turvo... uma resposta à chamada... é a criação de uma cena, a contação de uma história, tecendo ligações intrincadas entre vida e arte... fazendo um texto presente... recusando categorizações... acreditando que as palavras importam e escrevendo para o momento em que o ponto de criar textos autoetnográficos seja para mudar o mundo¹⁷.

O nascimento deste trabalho advém da colisão entre teoria e história. Este texto-colisão é produto da mesma metodologia utilizada por Brilhante e Moreira (2016, p. 1100), que a compreendem como:

Autoetnografia performática – um conceito contestado, sem consenso entre os teóricos da área. A autoetnografia escorrega, evita definições simplistas. É a colisão entre as ciências humanas e as artes, as teorias e as emoções, a ‘performatividade’ – o que acontece agora – e a performance – o que já aconteceu (estudo feito) – é a presença do corpo do(a) pesquisador(a) na linha de frente da pesquisa, no momento da criação (texto ou a performance/apresentação).

Como pessoa Intersexo, nessa redescoberta de mim precisei reaprender sobre o meu corpo e sexualidade e, mesmo assim, percebi como sabia pouco sobre mim mesmo. Não obstante esse redescobrir e o processo de processar esses eventos, o fim de 2019 foi entre a vida e a morte após um atropelamento. Esse acidente provocou um novo pacto com o meu corpo, a partir do qual aprendi ainda mais sobre ele e a ressignificá-lo. A recuperação do acidente me pediu maior atenção a um corpo que lutou pela vida e que me dá a oportunidade de poder escrever este artigo.

Por isso, este é um texto de reencontro. Não um reencontro com a técnica médica, suas violências e curas, mas sim um reencontro com a escrita de si de

¹⁷ Texto traduzido por Cláudio Moreira contido no trabalho de Brilhante e Moreira (2016).

Foucault (1992) na busca pela justiça social. Neste artigo, apresento conceitos caros à intersexualidade e busco provocar os leitores, redirecionando seus olhares para o poder biomédico que existe sobre os corpos inclusive os seus próprios. A escrita de uma história social desde o ultrassom invade a todos os seres humanos, porém aqui destaco como essa escrita atinge em especial a pessoa Intersexo como integrante da sociedade humana.

4.1.3 Intersexualizar meu corpo: Um apagar e um silenciar da norma

Qual o meu sexo?

Que Hormônios produz?

Quais Suas Gônadas?

E quais são seus Cromossomos?

A sociedade me enche de perguntas...

Será o sexo do bebê nascido?

Ou sexo do bebê criado?

Será ele minha escolha?

Ou o que a sociedade diz?

Qual peça que falta do quebra-cabeça chamado sexo?

Lembro das minhas primeiras consultas, do médico dizendo que eu era raquítica e precisava crescer, talvez porque era menor que as meninas de dez anos que ele tinha visto até aquele momento. Foi então que apareceram as tais “vitaminas”, remédios para mudar meu corpo. Segundo o doutor: “eu ia espichar, crescer e ficar mais gordinha”, já que pesava, até os meus 15 anos, 32 quilos.

Com 15 anos, veio a notícia de que as doses de vitaminas iriam aumentar. O médico dizia que com essa nova dose de “vitaminas” ia “ficar mocinha”, ou seja, “ter os peitos crescidos”, já desde o início da puberdade era uma tábua. Nessa época minhas colegas de escola já tinham os tais “botõezinhos” começando a aparecer e já falavam de menstruação. Naquele momento, surgiram meus primeiros questionamentos sobre meu corpo.

Minhas dúvidas giravam sobre as diferenças em relação ao meu corpo e o de minhas colegas. Um dia perguntei à minha mãe: “Meus ‘botõezinhos’ ainda não saíram, eu vou poder usar sutiã ou poderei menstruar?” A pergunta pegou minha

mãe de um jeito que nunca tinha visto antes. Encabulada, ela chamou minha irmã e me disse: “Você e a Débora são diferentes, ela tem sistema reprodutor feminino e você não. Ela pode menstruar e ter filhos, você não”.

Aquilo me impactou, finalmente confirmava algo que já especulava: Eu não era como as colegas da quarta série. Falei dos questionamentos que elas me faziam e prontamente ela me aconselhou: “Você vai dizer que menstruou, invente alguma coisa”. Fiz como ela mandou para que não soubessem de nada e não ficassem me enchendo de perguntas. Mas eu continuava me perguntando: por que eu era diferente, e por que ninguém poderia saber?

Aos 33 anos, já era professora de sociologia e recém mestra em Ciências Humanas e Sociais pela UFABC em São Paulo. A secretaria da pós-graduação da universidade requisitou alguns documentos para concluir minha matrícula, não lembro de todos que me pediram, mas um deles era minha certidão de nascimento. A data de meu registro era de março de 1983 e a pulga ficou atrás da orelha já que nasci em agosto do ano anterior.

Enquanto procurava esses documentos, encontrei uma carta enviada pelo Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo em 1996. A carta fez brotar mais pulgas, já que o texto dizia que era portador de Insensibilidade Androgênica Parcial e que tomava hormônios femininos desde os dez anos.

Depois de uma pesquisa e investigar várias páginas de resultados no Google® descobri que sou parte do grupo de pessoas com um dos estados da condição Intersexo, algo até então desconhecido por mim. Procurando por “Insensibilidade Androgênica Parcial”, encontrei nas redes sociais relatos e textos em espanhol que me deram mais informações, já que quase não encontrava materiais em português. Ali começou a aparecer uma resposta a minha pergunta, uma resposta que minha mãe nunca deu.

Intersexo
Insensível
Incompleta
Irreprodutível

Uma peça do grande quebra cabeças da minha vida começara a aparecer. Um nome que apresentava trilhas sobre o meu passado. Uma identificação que o

sociólogo francês Pierre Bourdieu fala sobre seu poder:

deste modo, realizar-se, está em jogo o monopólio do poder de impor o princípio universalmente reconhecido de conhecimento do mundo social, o nomos como princípio universal de visão e de divisão (nemo significa separar, dividir, distribuir), portanto, de distribuição legítima (Bourdieu, 1989, p. 236).

Não era suficiente só uma identificação, achava que era pouco, então resolvi ir atrás do meu prontuário médico e quando finalmente tive acesso a ele se abriu um mundo de descobertas. Constatei que nasci com um pênis com hipospadias, cromossomos XY, e que fui operado com menos de um ano de idade. Na cirurgia, foram retirados o pênis e os testículos e uma reconstrução plástica foi feita para a preparação de um espaço na região próxima ao clitóris para uma futura vagina. Essa reconstrução, portanto, eliminou partes do meu corpo entendido como masculinos e o remodelou cirurgicamente para a feminilidade, com a intenção de que esse corpo assumisse uma vida heterossexual não consentida.

Desde o meu nascimento, ganhei a etiqueta da criança “fora da norma”. Para a biomedicina, algo precisava ser feito para reparar minhas incongruências. Depois de exames e conversas entre pares, decidiram pela minha readequação. Maffia e Cabral (2003) apontam que a reconstrução cirúrgica de pessoa Intersexo é usada como caminho para que ela passe a estar dentro daquilo que se entende como natural e biológico, atestando minha história e a de muitos outros como eu.

O poder médico nos percebe como emergências. Assim declaram o Comitê de Genética da Associação Pediátrica Americana (AAP, 2000) e a normativa 1664 do Conselho Federal de Medicina (CFM, 2003) que nos apontam como “urgência biológica e social”. Crianças e adultos Intersexo seriam, portanto, anomalias do desenvolvimento sexual e corporal.

Isto fica ainda mais explícito quando da realização do consenso de Chicago de 2006. Uma reunião de médicos especialistas em endocrinologia do mundo todo focou suas preocupações no termo “Intersexo”. Além de sua preocupação com as críticas colocadas pelo movimento Intersexo desde 1996 quanto às práticas médicas direcionadas a essa população:

Termos tais como Intersexo, pseudo-hermafroditismo, hermafroditismo, sexo reverso, e gênero baseado em etiquetas diagnósticas são particularmente controversos. Estes termos são

entendidos como potencialmente pejorativos para pacientes, e podem ser confusos para pais e médicos. O termo Distúrbios do Desenvolvimento Sexual (DSD) é proposto, como definido pelas condições congênitas em que o desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal ou anatômico é atípico (Lee *et al.*, 2006, p. 149, tradução nossa).

O novo nome adotado por esses médicos, o DSD, para mim nunca fez sentido. Para a norma, eu e outros tantos não passaríamos de um distúrbio ou uma desordem. Porém eu e a socióloga Intersexo canadense Morgan Holmes optamos por sempre utilizar o termo Intersexo:

Quero pedir emprestado a Steven Angelides para propor que repensemos os estados Intersexo como “posições de sujeito sem fronteiras” (1995: 38). Afinal, até mesmo as diretrizes do [consenso] reconhecem que, para todas as suas garantias, eles não podem realmente prever como as coisas vão acontecer mais tarde (Holmes, p. 398, 2011, tradução nossa).

O uso que fazemos da palavra Intersexo é assumir o termo como alternativa ao poder médico e assim legitimar não mais do que uma condição biológica, também uma identidade política. Pensar novos meios de comunicar a intersexualidade também pede por relatos que apresentem como o olhar da medicina sobre nossos corpos direciona a nossa identificação e como a classificação feita por eles nos afeta.

Ao fazermos isso, subvertemos o olhar para além do biológico, ou seja, uma localização única de que somos parte de um conjunto de doenças, inacabados ou não totalmente desenvolvidos. Muitos pacientes abordados por essa especialidade médica podem acreditar que são uma falha, um erro, e é nesse lugar que a Isna e outras associações Intersexo nos fizeram entender que a doença, na verdade, está no olhar de quem nos classifica.

A luta e o movimento Intersexo nos mostra que somos perfeitos como somos. É importante lembrar que a positivação do termo Intersexo se deve aos primeiros passos dados por Bo Laurent quando escreveu, em 1993, um artigo sob o pseudônimo de Cheryl Chase, à bióloga Ann-Fausto Sterling e assim nasceu a primeira organização Intersexo do mundo. A Intersex Society of North America nasceu em 1993 e foi dissolvida em 2008 para a criação de outra associação em seu lugar (Machado, 2008; Davis; Preves, 2019).

A carta daquele hospital colou em mim uma etiqueta que escondia sérias

questões éticas. Segundo ela a endonormatividade, aqui representada pelo poder médico me identificou como uma criança intersexo fora das métricas e reescreveu com ajuda de endocrinologistas e cirurgiões pediátricos meu futuro. Seu objetivo era apagar a intersexualidade na minha carne, mas para sempre eu seria lembrado por eles como Intersexo.

Para Lena Eckert (2016), o desenvolvimento do corpo fora do que a endocrinologia espera é o que motiva a patologização e a medicalização da intersexualidade, e acaba reconstruindo-a a cada passo como uma sexualidade divergente e, portanto, problemática. Eckert utiliza o termo intersexualização para definir esse processo, termo que faço uso e que é próximo ao utilizado pela socióloga Intersexo Janik Bastien Charlebois¹⁸ (2017). Processo este que pontua a atipicidade na biomedicina com vistas a seu apagamento, ou seja, a eliminação de uma característica do desenvolvimento sexual de um ser e que de maneira nenhuma pode manifestá-lo na sociedade (Machado, 2007).

Dentro de todo esse contexto, faço uma pausa para falar da realidade brasileira. Embora pessoas Intersexo sempre tenham existido, nunca houve um movimento ou período de aglutinação de pessoas intersexo que se tenha notícia até o período de 2014/2015¹⁹, quando os fundadores da página *Visibilidade Intersexo* no facebook resolveram criar um grupo estritamente para pessoas Intersexo.

Desse importante ambiente virtual surgiu a ideia de criar a primeira associação voltada a essa população e um grupo de 7 a 10 pessoas atenderam a esse chamado²⁰. A Associação Brasileira Intersexo (ABRAI) foi criada em 2018 e reconhecida juridicamente como organização não-governamental em 2020.

A intersexualidade com o surgimento da ABRAI começou a aparecer para organizações e eventos LGBT que normalmente se referiam a esta luta e pessoas com o termo intersexual²¹. Referir-se a luta, mas não a conhecer infelizmente é uma realidade quando falamos porque lutamos, muitas vezes se referiam e ainda se referem a nós utilizando o sufixo “al” que é usado para identidade de gênero e

¹⁸ No artigo escrito pela socióloga intersexo o termo original usado no francês é *intersexuation* que numa tradução livre para português o termo seria Intersexação.

¹⁹ O que se sabe antes desse período é que houve uma pessoa trans que era mestre em sexologia no Rio de Janeiro e representou a Organização Internacional Intersexo - OII entre 2006 e 2009 seu nome era Valéria Torres e que através de um blog na Internet divulgava a filial brasileira (Guzzo, 2023). Como um dos fundadores da ABRAI tentou-se estabelecer contato para que pessoas intersexo estivessemos juntos na OII brasileira, porém não houve acordo.

²⁰ Ver Amiel Vieira, Anacely Guimarães Costa, Barbara Gomes Pires, Marina Cortez (2021).

²¹ O Termo é usado no espanhol.

orientações sexuais.

Porém, em consenso do movimento brasileiro com a linguista e pesquisadora de gênero e sexualidade Sara York, ficou decidido que era preciso valorizar este conjunto de condições entendidas como biológicas e potencializar o movimento em nosso país. Essa decisão está documentada num texto de Santos, Martins e York (2018), e sempre a utilizo em meus textos e palestras.

É importante trazer que um recurso usado pela gramática inglesa, nos ampara nesta escrita subversiva que apresenta o corpo Intersexo, como sujeito central, ainda que corporalmente ausente, é (d)escrito em primeira pessoa, como o "I" – Eu na escrita inglesa – logo o Intersexo aqui torna-se sujeito frontal e nome próprio ao pedirmos que sua letra inicial seja maiúscula, em movimento análogo e dialógico à escrita de bell hooks, que desafia a escrita acadêmica (ou academicista) e padrões linguísticos ao apresentar-se como contrarregra ortográfica cujo intento não seria de dar ênfase a sua pessoa, mas em seus escritos (Santos; Martins; York, 2018, p. 1).

Dessa forma, prestigiemos a luta no Brasil, mostrando consenso e uma certa unidade de ação. Constantemente, em grupos e eventos organizados seja de forma virtual ou presencial, questiono sobre o uso do "I" na sigla e pontuo sobre nossa constante invisibilidade. Em espaços e momentos que poderiam ser de visibilidade, reiteradamente, a nossa falta é corriqueira, a luta por nossa presença ser uma realidade nesses espaços, ainda é um grande e longo desafio.

Por mais que o ativismo continue a lutar e agir para que a invisibilidade em breve não seja uma realidade, a sociedade e o poder médico agem para dar um fim aparente aos traços de Intersexualidade de nossos corpos. Fazer parte desse grande desafio me orgulha e possibilita um certo senso de comunidade por conta disso. Talvez por ser um ser social algo que sempre procurei foi fazer parte de um grupo. A intersexualidade foi minha libertação da dúvida, do segredo e do silêncio. Abrindo os olhos para enxergar uma peça importante do quebra-cabeças da minha vida que o acaso decidiu me apresentar

Assim para Charlebois (2017) um sujeito-ator foi inicialmente um sujeito social, antes de ser sujeito existencial e sujeito reflexivo, condição prévia para politização. Aqui entendo que esse sujeito que era passivo como fui, agora age a partir de seus atravessamentos. Percebo-me como alguém que se tornou mais atento ao mundo e disposto a lutar contra questões que atentam contra a justiça social.

Foi assim que, ao saber de minha intersexualidade e tomar conhecimento de uma comunidade de pessoas como eu, passei a lutar contra a mutilação genital a que eu mesmo fui submetido. Acredito na luta de uma comunidade que, ligada a outras do mundo todo, não deseja que outras crianças Intersexo passem pelos mesmos processos de endossesexualização²².

4.1.4 Conclusão do texto, mas não do recomeço...

A palavra endossexo foi usada originalmente em “Intersexualidade, Individualidade, Autoestima e Psicanálise”, de 2016, escrito pela ativista e acadêmica Intersexo alemã Heike Bödeker. E ao contrário do que sempre ocorre, dessa vez o vencido deu nome ao vencedor:

[a sociedade] estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas (Goffman, 1975, p. 11-12).

Segundo Goffman (1975), é a sociedade que estabelece as formas e atributos comuns e naturais, e, conseqüentemente, também os que não o são. E normalmente quem nomeia sempre sai incógnito como se nunca tivesse um nome. Assim aconteceu nas aulas que tive de biologia no colegial, ouvia muito o professor falar das síndromes ligadas à intersexualidade. Síndromes que, segundo o dicionário Priberam, significam um “[Medicina] conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença”. Na época, eu não imaginava que me perguntaria, tempos depois, parafraseando o título do livro de Bel Hooks (2020): Sou uma doença?

Biocidadão
Biocategorias
Biodiversidade?

O nomeador sempre sai ileso. Segundo Thomas Laqueur (2001), a mulher foi vista como um homem imperfeito até o século XVIII. O nomeador nesse caso é o

²² O entendimento destes processos ficou ainda mais nítido ao conversar sobre eles com Sara Wagner York.

patriarcado e a dominação masculina, sob essa ótica o dimorfismo sexual ainda é muito forte em nossa sociedade, mas tem sido cada vez mais tensionado, principalmente pelo feminismo e suas interseccionalidades. Diferentemente do feminismo branco, em que as mulheres brancas saíam às ruas para protestar enquanto as mulheres negras ficavam em suas casas fazendo o trabalho doméstico, o feminismo negro procura a interseccionalidade (Akotirene, 2018) e, portanto, luta contra o racismo e machismo ao mesmo tempo em que busca por equidade.

O surgimento do dimorfismo sexual possibilitou que a mulher branca fosse vista e estudada por uma ciência predominantemente masculina. Essa ciência, segundo Reis (2019), se esconde atrás de aparente neutralidade. Foi ela que, a meu ver, fez com que corpos Intersexo e sua sexualidade fossem vistos como monstros, corpos com dois sexos, reduzidos às suas genitálias e gônadas. Numa lógica que não intersecciona, são corpos sem rostos ou histórias, cujo valor seria apenas de estudo científico.

A sociedade que vê dois sexos biológicos não vê corpos Intersexos como parte de uma biodiversidade humana que, segundo as estimativas da bióloga feminista Ann-Fausto Sterling, está em 1,7% da população. Essa mesma sociedade nunca deixou que a pessoa Intersexo pudesse simplesmente ser. Apesar de “corrigir cosmeticamente” esses corpos, a medicina nunca deixa que esse corpo esqueça que é intersexualizado, pois o ato de Intersexualizar, por meio de exames e operações para que esse corpo passe a ser endossexo, nunca retira dele sua etiqueta.

Intersexo

Intersexualizado

Endocosmeticado

Um monstro maquiado

Monstro humano.

PSIU....

Silêncio

Vamos iludi-lo

Agora ele é

Um monstro humano

No meio da sala...

Na medida em que estou considerando que a escolha dos termos não é aleatória, meu interesse está em considerar as categorias classificatórias utilizadas para identificar o fenômeno – no caso, relativo à definição e manejo de corpos que variam do padrão dicotômico masculino/feminino – como operatórias para pensar sobre o tema e sobre a forma como elas estão envolvidas nas condutas a serem tomadas em relação a esses corpos. É fundamental, para tanto, problematizar a questão da nomenclatura a partir de uma perspectiva horizontal (ou seja, temporal) e vertical (considerando as diferentes esferas sociais envolvidas no momento presente da discussão), a fim de entender como as práticas levadas a cabo nos corpos de crianças com condição Intersexo se inserem em um contexto social mais amplo (Machado, 2007).

Vinda da taxonomia, a palavra “taxar” significa categorizar. Corpos que são taxados são corpos impedidos de viver uma vida plena, que não puderam saber ou entender quem são. A ação biomédica e endocrinológica diante desses corpos responde a um imperativo social, promovendo ação biopolítica que os retira de suas humanidades para que eles não suscitem dúvidas em uma sociedade que aprendeu a olhar a si própria como dividida entre homens e mulheres.

Ao descobrir o gene pelo cariótipo espera-se

XX E XY

se o resultado de um cariótipo é

X0, XXY, XXX

Esse é o cariótipo de um monstro genético?

Ou de uma natureza monstro?

Mauro Cabral (2003) coloca em xeque uma biopolítica que atinge corpos Intersexo em acordo com o sistema jurídico e social. A lei de registros públicos declara que o tempo para expedir certidão de nascimento é de 15 dias em nascimentos próximos a cartórios e de três meses para nascimentos distantes de um cartório de registro civil. No Brasil e em muitos países ainda é obrigatório, para a emissão desse documento, o sexo declaratório da criança.

Quando nasci ainda não havia a opção Intersexo na declaração, logo esse registro era impossível. Apesar de existir essa classificação quanto ao meu corpo para a biomedicina para o cartório não. Assim como Herculine Barbin meu lugar era

de inexistência e de impermanência, como corpos Intersexo na sociedade somos um incômodo para a dicotomia homem/mulher.

Sou só! De minha chegada a Paris data uma nova fase de minha dupla e estranha existência. Criado durante vinte anos entre moças, fui primeiramente camareira. Aos dezesseis anos entrei na qualidade de aluna professora para a escola normal de... Aos dezenove tirei meu diploma de professora; alguns meses depois dirigia um internato renomado na área administrativa de...; saí de lá aos vinte e um anos, durante o mês de abril. No final desse mesmo ano eu estava em Paris na estrada de ferro... (Foucault, 1983, p. 91).

O Não-lugar que sentia a intersexualizada Herculine como pontua os escritos de seu diário resgatados por Foucault (1983) também era o que sentia. Durante muitos anos, o que chamo de Intersexofobia se colocou sobre o meu corpo, inclusive na entrevista para o processo de hormonização. Não sabia quem eu era, apesar da aparência “maquiada” que a cirurgia me deu. Qual é o meu lugar? Eu não tinha como nomear um corpo que, para Alice Dreger (1998), se transformou depois que um consenso falhou em determiná-lo.

Eu era um corpo em estado de deslocamento (Machado, 2007), um corpo que para a biomedicina (Camargo Junior, 2003) e a biologia, havia lugar, mas que fora modificado sem o mínimo cuidado e preparo psicológico para tornar o mundo e sua vida “um lugar habitável”, como diz Butler (2019). Machado (2007) pergunta qual é o destino dos corpos pós-operados. Eu me pergunto o mesmo.

A decisão pela construção de uma genitália feminina se dá pela crença da equipe médica de que, a falta do “pênis funcional” impossibilitaria tanto o desenvolvimento “sadio” da masculinidade, quanto a estabilidade psicossocial da criança (Pires, 2015; Damiani; Guerra-Júnior, 2007 *apud* Silva, 2015, p. 27).

Para esses médicos, a funcionalidade faz parte de uma matriz heterossexual a ser seguida. Viam em mim, nas minhas moléculas e genitália, um futuro não saudável. Essa ideia de futuro em que a endossexualidade vê o corpo como possível de ser “maquiado” esquece que nem a aparência, nem a etiqueta e muito menos o prontuário médico apagam minha intersexualidade. A biopolítica endossexo faz com que não haja reconhecimento civil de pessoas Intersexo e incentiva o encaixe dessa população na matriz heterossexual.

Lena Eckert (2016b) usa os termos “assombroso e assombrando” para falar

do impacto da intersexualidade na medicina. A autora empresta esses termos da obra de Robert Macruer sobre o impacto da deficiência na medicina e na sociedade. Ao me deparar com boa parte da minha história sendo escrita pela endocrinologia em meu prontuário médico, os termos usados por Eckert foram também parte da minha reação ao perceber que no período do ultrassom realizado no período da gravidez de minha mãe, meu corpo era lido como masculino pela medicina e por ela era bem quisto. Após o nascimento passou a ter um novo olhar e as palavras usadas para ele eram inacabado, atípico e inapto para a sociedade. O corpo agora continha uma “imperfeição” que assombrava a leitura do médico e ela deu lugar à certeza de que através de uma correção cirúrgica era possível ele existir.

Depois da adequação cirúrgica feita acreditavam que corpo endossexo nasceu (Carpenter; Dalke; Earp, 2023). Descobrir através da carta essa história Intersexo, me fez nomear esse não-lugar que eu sempre ocupei mesmo sem saber. E se o leitor acha que as descobertas se acabaram, engana-se. Todos os dias descubro algo novo a respeito de mim e a cada descobrir renasço, afinal foram mais de 30 anos sem saber quem era eu. Finalizo com uma única certeza, novos começos me esperam.

*Meu corpo Intersexo
É uma arma de luto e luta
Por muitos que não puderam simplesmente ser
Meu corpo recebeu uma “maquiagem”
A endossexualidade continua nesse fashion eternal days
Um corpo, um coletivo de corpos
Que sonham e lutam pelo fim dos eternal days*

Referências

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2018.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Evaluation of the newborn with developmental anomalies of the external genitalia. Committee on Genetics. **Pediatrics**, v. 106, n. 1 Pt 1, p. 138-142, 2000. DOI: 10.1542/peds.106.1.138.

ANZALDÚA, G. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. **Revista Estudos Feministas**, v. 8, n. 01, p. 229-236, 2000. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/9880/9106>. Acesso em: 30 abr. 2021.

BÖDEKER, H. Intersexualität, Individualität, Selbstbestimmtheit und Psychoanalyse. Ein Besinnungsaufsatz. In: KATZER, M.; HEINZ-JÜRGEN, V. (ed.). **Geschlechtliche, sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung**. [S. l.]: Psychosozial-Verlag, 2016. p. 117-136.

BOURDIEU, P. **O poder simbólico**. São Paulo: Editora Bertrand Brasil, 1989.

BUTLER, J. **Bodies that matter**: on the discursive limits of “sex”. New York: Routledge, 1993.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: a subversão da identidade. São Paulo: Record, 2003.

BUTLER, J. **Vida precária**: os poderes do luto e da violência. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

BRILHANTE, A. V.; MOREIRA, C. Formas, fôrmas e fragmentos: uma exploração performática e autoetnográfica das lacunas, quebras e rachaduras na produção de conhecimento acadêmico. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 20, p. 1099-1113, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622016.0130>.

CABRAL, M.; MAFFIA, D. Los sexos ¿son o se hacen? In: MAFFÍA, D. *et al.* **Sexualidades migrantes género y transgénero**. Buenos Aires: Feminaria, 2003. p. 86-98.

CARPENTER, M.; DALKE, K.; EARP, B. D. Endosex. **Journal of Medical Ethics**, v. 49, n. 3, p. 225-226, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1136/medethics-2022-108317>.

CHARLEBOIS, J. B. Les sujets intersexes peuvent-ils (se) penser? Les empiétements de l'injustice épistémique sur le processus de subjectivation politique des personnes intersex (ué) es. **Socio**, v. 9, p. 143-162, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4000/socio.2945>.

CHASE, C. 'Re: The Five Sexes.' Letter to the Editor, **The Sciences**, July/Aug. 1993. Disponível em: <https://isna.org/articles/chase1995a/>. Acesso em: 21 fev. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.664, de 12 de maio de 2003. Dispõe sobre as normas técnicas necessárias para o tratamento de pacientes portadores de anomalias de diferenciação sexual. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 13 maio 2003.

COLAPINTO, J. **Sexo trocado, a história real do menino criado como menina**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

CONQUERGOOD, D. Beyond the text: Toward a performative cultural politics. *In*: DAILEY, S. J. (ed.). **The future of performance studies**: visions and revisions. New York: National Communication, 1998.

COSTA, A. G. **Fé cega, faca amolada**: reflexões acerca da assistência médico-cirúrgica à intersexualidade na cidade do Rio de Janeiro. 2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

DAMIANI, D.; GUERRA-JÚNIOR, G. As novas definições e classificações dos estados intersexuais: o que o Consenso de Chicago contribui para o estado da arte? **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 51, n. 6, 2007. DOI: 10.1590/S0004-27302007000600018.

DAVIS, G.; PREVES, S. Reflecting on intersex. *In*: VALENTINE, C. G.; TRAUTNER, M. N.; SPADE, J. Z. (ed.). **The kaleidoscope of gender**: prisms, patterns, and possibilities. [S. l.]: Sage, 2019.

DIAMOND, M.; SIGMUNDSON, H. K. Management of intersexuality: guidelines for dealing with persons with ambiguous genitalia. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, v. 151, n. 10, p. 1046-1050, 1997. DOI: 10.1001/archpedi.1997.02170470080015.

DREGER, A. D. Ambiguous sex or ambivalent medicine. **The Hastings Center Report**, v. 28, n. 3, p. 24-35, 1998. DOI: <https://doi.org/10.2307/3528648>.

ECKERT, L. **Intersexualization**: the clinic and the colony. [S. l.]: Taylor & Francis, 2016a.

ECKERT, L. 'Diagnosticism': three cases of medical anthropological research into intersexuality. *In*: HOLMES, M. (ed.). **Critical intersex**. [S. l.]: Routledge, 2016b. p. 41-71.

FOUCAULT, M. **Herculine Barbin**: o diário de um hermafrodita. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983.

GOFFMAN, E. **Estigma**: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

HOOKS, B. **“E eu não sou uma mulher?”**: mulheres negras e feminismo. Tradução: Bhuvi Libanio. 2. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.

HOLMES, M. The intersex enchiridion: naming and knowledge. **Somatechnics**, v. 1, n. 1-2, p. 388-411, 2011.

JONES, S. H. Autoethnography: making the personal political. *In*: DENZIN, N.; LINCOLN, Y. (org.). **The Sage handbook of qualitative research**. Thousand Oaks: Sage, 2005. p. 763-792.

LEE, P. *et al.* (in collaboration with the participants in the International Consensus Conference on Intersex organized by the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology). Consensus Statement on Management of Intersex Disorders. **Pediatrics**, v. 118, n. 2, p. 488-500, 2006. DOI: 10.1542/peds.2006-0738.

MACHADO, P. S. **O sexo dos anjos**: representações e práticas em torno do gerenciamento sociomédico e cotidiano da intersexualidade. 2008. 266 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/14947>. Acesso em: 15 jun. 2021.

MACHADO, P. S. “Anomalia”, “ambigüidade” e outros operadores de diferença: as vicissitudes da nomenclatura e suas implicações regulatórias. *In*: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 31., 2007, Caxambu, MG. **Anais eletrônicos** [...]. Caxambu: ANPOCS, 2007. Disponível em: http://201.48.149.89/anpocs/arquivos/10_10_2007_14_36_45. Acesso em: 13 jun. 2021.

PIRES, B. **Distinções do desenvolvimento sexual**: percursos científicos e atravessamentos políticos em casos de intersexualidade. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. Disponível em: https://minerva.ufrj.br/F/?func=direct&doc_number=000834556&local_base=UFR01. Acesso em: 2 jun. 2021.

REIS, E. Did bioethics matter? A history of autonomy, consent, and intersex genital surgery. **Medical Law Review**, v. 27, n. 4, p. 658-674, 2019. DOI: 10.1093/medlaw/fwz007.

ROSE, N. **A política da própria vida**: biomedicina, poder e subjetividade no século XXI. São Paulo: Paulus, 2013. 396 p.

SANTOS, T. E. C.; GONÇALVES, S. W. P.; MARTINS, R. A. Intersexo: entre a educação e o direito de ser. *In*: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DESFAZENDO GÊNERO, 4., 2019, Recife. **Anais eletrônicos** [...]. Campina Grande: Realize Editora, 2019. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/64145>. Acesso em: 20 jul. 2022.

SILVA, M. R. D. Repensando os cuidados de saúde para a pessoa intersexo. *In*: DIAS, M. B. (coord.). **Intersexo**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 379-404.

SIMAKAWA, V. V. **Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes**: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade. 2015. 244 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/19685>. Acesso em: 18 jun. 2022.

VIEIRA, A. *et al.* Intersexualidade: desafios de gênero. **Revista Periodicus**, v. 1, n. 16, 2021. DOI: <https://doi.org/10.9771/peri.v1i16.45725>.

4.2 UM PLANO “PERFEITO”: POR UMA SUBJETIVIDADE MÉDICA INTERSEXO²³

4.2.1 Introdução

Nas décadas de 1960 e 1970, uma teoria criada pelo psicólogo e sexólogo estadunidense John Money começou a circular no meio médico. Para ele, entre os 18 meses e os dois anos de vida, o bebê estaria sob a égide do que sua teoria denominava por neutralidade de gênero, ou seja, até esse período, a criança não teria um gênero definido, sendo possível uma criação e educação em um gênero determinado por meio da socialização dela (Cortez, 2015; Downing *et al.*, 2015).

Desde os anos 1950, esse psicólogo estudava pessoas Intersexo, e desse estudo ele criou o conceito de papel de gênero²⁴. A partir dessa nova categoria, Money buscava entender como garantir humanidade por meio de uma inteligibilidade heteronormativa (Butler, 2003; Rubin, 2017). Como, por exemplo, no caso de pessoas Intersexo de genitália atípica, já que, para ele, esses corpos não haviam tido um desenvolvimento²⁵ genital finalizado (Downing *et al.*, 2015). Segundo sua teoria com um “direcionamento correto”, a utilização prática dessa teoria poderia ser útil na criação de corpos Intersexo após a aplicação da técnica cirúrgica num gênero determinado pela medicina. O papel educativo dos pais seria essencial para a socialização daquele pequeno ser, seguido de sua hormonização e outras cirurgias²⁶.

Foi através da divulgação dessa teoria em espaços além do ambiente médico como, por exemplo, programas de tv que chegou ao consultório deste profissional uma criança canadense que havia perdido o pênis numa circuncisão. A criança tinha um irmão gêmeo que não havia passado pela desastrada circuncisão. O motivo da procura do psicólogo se pela preocupação da família quanto a seu desenvolvimento psicológico, já que no senso comum essa referência genital contribuiria para sua

²³ Aqui, sempre faremos a escrita da palavra Intersexo com a inicial maiúscula por uma decisão pactuada pelo Movimento Intersexo Brasileiro. Ver Santos, Gonçalves e Aragão (2019).

²⁴ Segundo Money, esse conceito carrega em si dois ambientes: no ambiente privado, há um ideário do que é o gênero, e no público ele se manifesta por meio de manifestações e expressão de gênero (Money, 1995).

²⁵ N.A: Ver a tese de Costa (2018) que traz uma ótima discussão acerca da ideia de desenvolvimento e a discussão Intersexo.

²⁶ N.A: muitas cirurgias podem ocorrer dependendo do caso, por exemplo, se a plástica executada tiver mais reparos do que o previsto ou então, no caso de hispopádia a depender da severidade do caso 1 cirurgia não seja suficiente.

localização no gênero (Colapinto, 2001). Porém, para o psicólogo, a resposta a essa pergunta viria a ser respondida de forma cirúrgica num primeiro momento, criando uma vulva feminina, e depois se somaria a uma criação no gênero feminino, finalizando com uma hormonização feminina para induzir a caracterização corporal conforme o gênero adquirido²⁷ (Corrêa, 2004).

Decidiu-se então aplicar na criança lesionada sua teoria, com o auxílio da técnica cirúrgica. O irmão intocado pela circuncisão se desenvolveria normalmente como menino, tornando-se o oposto da “irmã”, estabelecendo assim um padrão de diferença sexual (Cortez, 2015; Colapinto, 2001). Esse protocolo passou a ser a solução na qual a cirurgia é realizada com um fim cosmético, ou seja, para dar uma aparência mais próxima ao genital Intersexo de um genital masculino ou feminino endossexo (Mouriquand *et al.*, 2016).

É preciso ressaltar o importante papel da teoria de Money como uma resposta para o manejo médico da intersexualidade nos anos que seguiram que se espalhou ao redor do globo, graças a sua habilidade comunicacional que ele tinha e tornando-se a resposta primeira para esses casos. Seja com suas aparições na tv ou as diversas publicações que fez sobre o assunto, não havia uma direção para o que fazer quando esses casos surgiam, pois não havia consenso sobre o que fazer, e cada médico tinha seu modo de agir (Downing *et al.*, 2015). Do ponto de vista biomédico, ele ordenou o caos com uma direção dando início à “era cirúrgica” (Dreger, 2000).

Neste trabalho, busca-se fazer uma leitura interpretativa sobre a cirurgia Intersexo à luz de uma revisão narrativa (Rother, 2007; Elias *et al.*, 2012). Ressaltando que a solução adotada produz uma tentativa de apagamento da intersexualidade com vistas à manutenção da estrutura social e de gênero, apesar de os 40 estados intersexuais descobertos até agora interrogarem se realmente só existem o feminino e o masculino (Morland, 2005; Silva, 2018).

Além disso, o texto também busca entender o que significa saúde para os corpos Intersexo, principalmente aqueles que nascem com genitália atípica. O tema abordado em três seções a seguir: a cirurgia no corpo Intersexo, a saúde e a

²⁷ Não vamos aqui abordar ainda mais essa conhecida história, porém, é preciso que seja pontuado o importante papel da teoria de Money como suporte para o manejo médico da intersexualidade que se espalhou ao redor do globo, tornando-se então uma prática protocolar adotada por médicos e cirurgiões, principalmente no caso de crianças Intersexo com genitais atípicos (Corrêa, 2004; Roen, 2008; Diamond, 1999).

subjetividade, e a relação entre a teoria de Gonzales-Rey e a intersexualidade.

4.2.2 A cirurgia no corpo Intersexo

Durante e após a realização do exame de ultrassom do bebê, a busca pelo genital pode contribuir para criar um corpo humano sexuado e iniciar uma história social para a família, familiares e médicos. A partir desse encontro o profissional que está conduzindo o exame ou fazendo o parto pode interpretar se ali há uma das duas formas possíveis: a típica e a atípica (Chazan, 2007).

A partir da leitura típica feita pelo médico após o exame realizado no período pré-natal e depois do nascimento, o sexo simbolizado nos genitais se mostram de forma conhecida, ou seja, é possível descrever um genital diante de seus aspectos físicos caracterizados socialmente como masculino ou feminino, e na segunda o genital apresenta forma desconhecida, ou seja, atípica. Desse modo, pode-se dizer que o corpo examinado está inscrito em uma ideia binária de normalidade sexuada (Costa, 2018).

A ideia de normalidade binária está atrelada a leitura visual da forma do genital mais bem apreendida após o nascimento seja por sua forma atípica ou típica, com uma definição biomédica ligada ao tamanho do genital, conforme explicitado no consenso de Chicago²⁸. Segundo o consenso (Lee *et al.*, 2006) a ideia de normalidade genital ficou definida com uma classificação pelo tamanho do genital que define o genital típico do atípico. O tamanho esperado para um pênis típico ficou definido entre 2,5 e 3,5 cm, enquanto o tamanho de um clitóris típico foi estabelecido entre 3,3 e 4 mm. Assim, os genitais assumidos como masculino com tamanhos menores ou maiores seriam atípicos; do mesmo modo como um clitóris popularmente visto como exagerado, sendo “necessária” então uma intervenção protocolar cirúrgica (Hughes *et al.*, 2006).

No Brasil diante de uma leitura de genitais atípicos, procede-se a fase de

²⁸ Esse consenso surgiu de uma reunião na cidade de Chicago (EUA) com médicos especialistas em intersexualidade do mundo todo. Ali, várias questões referentes ao diagnóstico e tratamento foram discutidas e pactuadas. Decidiu-se, por exemplo, pela introdução de um novo termo, Distúrbio do Desenvolvimento Sexual (DDS), em substituição a Intersexo, contribuindo também, além da unificação da linguagem, para unificar o tratamento com uma rede global de especialistas (Hughes *et al.*, 2006). Aqui nos deteremos brevemente sobre esse consenso, porém Machado (2008), Cortez (2015, 2020), Pires (2015) e Costa (2014, 2018) falam de modo mais aprofundado sobre este consenso. Este consenso teve um *update* do qual o trabalho Pires (2020), fala mais sobre.

exames para atribuir-se um sexo biológico por meio do cariótipo e acontece então o preenchimento da Declaração de Nascido Vivo. A partir desse documento, é lavrada no cartório a certidão de nascimento da criança, garantindo-se reconhecimento jurídico e cidadania pelo Estado brasileiro.

Desde 2011 (Santos, 2020) o sexo ignorado pode ser marcado na DNV, mas somente a partir de 2018 essa marcação passou a ter um sistema próprio no Ministério da Saúde (Brasil, 2018). Até 2021, apesar de o registro existir num documento estatal, não havia nenhuma regulamentação que viabilizasse essa opção figurar na certidão de nascimento (Brasil, 2012, 2018). Porém esta opção passou a ser reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), junto a Associação Brasileira Intersexo (Abrai), redigiu um provimento ao qual deveriam se submeter todos os cartórios no território nacional a partir de agosto daquele ano (CNJ, 2021).

O bebê Intersexo só pode ser percebido como corpo digno se em primeiro lugar puder pacificar o poder médico como instância social, melhor dizendo, localizando esse corpo infantil dentro da definição binária de gênero. Em segundo lugar, depois de pactuado entre eles, passa a ser legitimar junto a família seu diagnóstico, mesmo sem dar todas as informações relevantes a eles, pois o aval da família é importantíssimo para o próximo passo desse processo. Autorizar assemelhar pela via cirúrgica, depois do sexo definido “em conjunto” (médicos e família).

Em terceiro lugar, no futuro, quando a pessoa tiver consciência de si, espera-se que ao fim dessa jornada haja um reconhecimento da pessoa que teve o genital redesenhado, como também seu sexo “biológico” (Doyle; Roen, 2008; Roen, 2016; Morland, 2005). Em nossa sociedade heterocentrada, espera-se que os corpos sigam um futuro já planejado e escrito para todos, porém, ignora-se a diversidade de escolhas futuras de todos os corpos. Quanto ao corpo Intersexo e esse futuro distante, arma-se uma operação para que a mesma história social e de gênero escrita para todos também o atinja. Ou seja, não existe um futuro de escolhas livres para nenhum corpo (Downing *et al.*, 2015; Preciado, 2014).

Sob a égide das teorias da neutralidade de gênero e da socialização, Money estabeleceu que diante dos casos de genitália atípica, a cirurgia era a opção mais adequada – era fundamental. A solução do psicólogo tornou-se uma realidade hegemônica, graças às suas habilidades de divulgador “científico” (Downing *et al.*,

2015; Germon, 2009).

4.2.2.1 O Genital como assinatura

De acordo com Iain Morland, baseando-se no filósofo franco-argelino Jacques Derrida, a cirurgia seria o ato de redesenhar e inscrever no corpo da criança o genital imaginado pelo cirurgião. Esta inscrição é a de um genital próximo ao conhecido e ocorre para o conforto de todos, médicos pais e sociedade. O novo genital então seria uma testemunha que “confessa com clareza” a que sexo-gênero esse corpo pertence, pois este só se existe quando se reconhece (Morland, 2005, 2022; Roen, 2016; Derrida, 1988; Butler, 2003).

Morland, ainda influenciado pela filosofia derridiana, lembra que o genital redesenhado além de resultado da cirurgia é também uma imitação, assim como uma assinatura é uma “imitação de um original ausente” (Derrida, 1988). Neste sentido, a inscrição genital é a imitação de um ideal anterior à existência do paciente e à imaginação de seu criador, o cirurgião. Pode-se dizer então que o novo genital que passa a existir, nada mais é do que a representação da representação (Morland, 2005).

Esta representação duplicada objetiva produzir o apagamento da intersexualidade, porém, passa a se tornar redesenho indeterminado, produzido como imitação de um genital ideal cujo desenho só existe na cabeça do seu criador. O genital agora passa a ser uma verdadeira aberração no corpo de uma pessoa Intersexo, pois o redesenha a imagem que passa a ser, a assinatura do seu autor que permanecerá por décadas e décadas e mesmo que seu autor já não esteja mais vivo no momento de sua exibição, sua assinatura está lá (Morland, 2005).

Assim a assinatura do cirurgião é uma marca que pode ou não ser apreciada pela pessoa Intersexo. Além disso, outras marcas/consequências podem acompanhar esse procedimento, tais como a dor fantasma na região pélvica e a perda de sensibilidade na região, impossibilitando o gozo sexual do(a) paciente que se tornam resultado desse processo de inscrição e redesenho. Observa-se aqui que a cirurgia é uma prova visual aos pais e/ou responsáveis e à sociedade e anexados a essa prova, ficam seus resultados sensíveis para o paciente de possibilidades mínimas de prazer sexual mediado pelo próprio corpo e uma percepção que pode ou não condizer com as pretensões de seu artífice (Morland, 2005, 2012; Holmes, 2002;

Davis, 2015).

A representação duplicada em que se promete o apagamento da intersexualidade daquele corpo se baseia num diagnóstico que nada mais é do que uma taxonomia médica para rotular corpos. De fato, esse apagamento é uma ilusão, pois o paciente continuará frequentando o ambiente hospitalar e, mesmo diante do silêncio dos médicos e com decisões aparentemente favoráveis a ele(a), porém o diagnóstico continuará gritando e pairando naquele espaço, mas fora dali silente o mundo social o verá como endosseio (Holmes, 2002).

Mesmo que ao ver o genital da criança se veja uma semelhança deste com outros genitais conhecidos, faz-se importante lembrar que o mesmo é redesenhado e inscrito e advém da imaginação do cirurgião daquilo que seria um genital de uma menina ou menino. Este é uma produção de seu artífice do que ela acredita ser a forma assemelhada e será reconhecida por todos – entretanto, da ideia para a materialização destes genitais culturais e seu redesenho é preciso entender que não há uma matriz replicadora, pois, os genitais humanos são diferentes entre si, mesmo que estejam com o tamanho segundo o consenso de Chicago.

Diante dessas imitações que deformam a produção do genital pela natureza. Há uma lição a ser aprendida pela endonormatividade (Nowakowski; Sumerau; Lampe, 2020). Somos parte de uma singularidade diversa, seja na morfologia corporal ou no desafio cotidiano de ree[s]istir, respeitar e aceitar esses corpos metamorfoseantes²⁹ talvez fossem o primeiro passo para uma sociedade outra (Seixas, 1973).

4.2.2.2 A Racionalidade médica e o sujeito intersexo

No caso da intersexualidade, a criança intersexo é vista como um corpo temporal, ou seja, uma emergência que precisa ser consertada a tempo de não alterar tanto seu desenvolvimento corporal (Garland; Travis, 2020). Dessa forma, a cirurgia genital então se resume a técnica e resposta que usa o tempo como borracha para integrar as pessoas Intersexo de genitália atípica a sociedade.

²⁹ N.A.: Cunhei esse termo baseado na música de Raul Seixas para lembrar que em nossa sociedade que não há corpos normais, pois a normalidade exigiria estar dentro de um padrão estático, como se fosse possível aos corpos nunca se modificarem. O verdadeiro padrão dos corpos se faz pela metamorfose, pois é impossível aos corpos não passar por uma transformação ao longo da vida.

Essa resposta é adotada por uma medicina que conforme o entendimento que guia trabalho utiliza-se de uma episteme hegemônica com um olhar dicotomizado e orienta, contribui, influência este saber-poder-fazer (Prado Filho; Trisotto, 2008) cada vez mais fraturado que também vê o homem como vê a si própria.

Uma medicina e prática cada vez mais especializada e que não vê mais o homem como um todo, ou seja, um ser completo e complexo. Esta prática enxerga a doença, investiga e produz o diagnóstico e segundo Luz e Tesser (2002, p. 364) pode “gerar [...] conflito colocando dilemas, expondo limites ou ausências no cuidado médico”.

Porém no caso aqui apresentado o fato do segredo e do silêncio ser uma ferramenta utilizada ao bel prazer do poder médico, essa utilização pode contribuir para alienar os pais como, por exemplo, em minha história. O prontuário médico revela um acordo entre o chefe da equipe de endocrinologia e seu staff para revelar somente o que fosse acertado entre o grupo.

A pesquisadora hoje aposentada Madel Luz, do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), cunhou o conceito de racionalidades médicas adotada como guia para a percepção de como ela orienta a medicina ocidental, além das ayurvédica e chinesa em suas práticas

Esse conceito se deve ao sociólogo Max Weber e que carregam duas nuances: uma metodológica e outra conceitual. Quando olhamos do ponto de vista metodológico, observamos a busca pela coerência, ou seja, por evidências que garantam que o tratamento escolhido é o correto para aquela doença (Luz, 2011).

A sociologia de Weber trabalha com um tipo ideal que nesse caso, por exemplo, busca-se atingir, ou seja, as tomadas de decisão da equipe que objetivam a cura da doença, ou, diante da impossibilidade de cura, a outra possibilidade seria de uma convivência com a doença que produza uma menor sensação de dor e desconforto ao paciente.

A pesquisadora lembra que é muito comum pensarmos a ciência sempre associada à evolução e esquecermos que sua composição também é carregada de ideias antigas e que muitas vezes são relegadas a um passado “que não volta mais”. Porém, sua pesquisa alerta para este nosso entendimento sobre o passado. Seu lembrete postula que as práticas e técnicas passadas não se desvanecem rapidamente, elas podem se agregar às “novas” (Luz, 1997).

Logo passado e presente podem conservar-se em novas teorias ou práticas,

porque elas são exercidas por pessoas que podem ignorar avanços, porque alteram suas práticas, ou simplesmente agregar as antigas às novas. Assim como práticas e técnicas antigas e novas podem ser agregadas ou conservadas, outros elementos que não podem ser esquecidos são relacionados ao contexto histórico e social que também está presente nas práticas médicas quanto ao morrer, viver ou restabelecer (Luz, 1997).

Isso significa que as várias medicinas portam um paradigma transcultural em seu funcionamento, e, no caso específico da medicina ocidental, ela apresenta o paradigma biomecânico associado ao corpo. A cosmologia ocidental se baseia na física dos sistemas, e nossa medicina está assentada sobre a racionalidade (Luz, 1997), que muitas vezes mantêm arraigados preconceitos.

Esses preconceitos estão inscritos numa criação colonial que, no caso brasileiro, remonta à escravização de corpos indígenas e negros e por conta dos quais as mulheres negras eram vistas como sem alma e sem gênero. Seus corpos e mentes foram violados para dar origem a uma nação “pura” branca. Essa ideia supremacista do século XIX não se realizou, e o corpo negro apesar da intensa luta, resiste num país racista (Meyers, 2022; Souza, 2021; Bento, 2022).

Naquela época, esses corpos eram entendidos no Direito, por exemplo, como fungíveis, ou seja, poderiam ser substituídos por outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Riley C. Snorton (2017) acredita que isso também contribuiu para o entendimento social de que sexo e gênero eram coisas permutáveis, assim como os corpos escravizados.

Como exemplo desse olhar, ele cita o tratamento feito por ginecologistas a mulheres brancas e negras daquele tempo. As brancas, ao serem examinadas, eram tratadas com privacidade; já as negras eram atendidas em uma consulta onde seu corpo e cuidado estavam à vista de todos. Havia um pudor quanto ao genital feminino branco; já com o corpo negro, o exame ginecológico era à vista de todos; já a mulher branca, tinha-se pudor e quanto ao corpo racializado não visto como generificado era abertamente examinado.

O que busco dizer aqui é que corpos invisibilizados, como os corpos Intersexo de genitália atípica, desde o século 19, para a medicina e a sociedade não precisavam da espera de sua evolução corporal ou subjetiva para exprimirem suas ideias e vontades sobre seu próprio corpo. As decisões sobre seu presente e futuro ficavam a cargo dessa racionalidade médica onde as fontes de decisão advinham de

exames, do conhecimento subjetivo e do acordo de outros médicos, pais ou responsáveis.

Seus corpos-objeto estavam à mercê de decisões alheias. Desse modo, pode-se dizer que o sexo-gênero deles eram obra da arte cirúrgica, consultados e decididos por um grupo restrito de pessoas. Pode-se inferir aqui que para eles não havia e não há o significado de saúde “completa” como Rey conceitua. Há sim um sentido social de saúde que prescreve o presente e o futuro dessas pessoas.

4.2.3 Conclusão

No ambiente médico e no próprio senso-comum da sociedade, paira a ideia de que um corpo saudável é um corpo sem doenças. Entretanto, para entender nossa relação entre a concepção de saúde e a intersexualidade, é preciso compreender que a pessoa Intersexo não é um sujeito passivo nessa relação, como acontece com muitas pessoas Intersexo de genitália atípica diante da medicina ocidental. Ao contrário: ele deve e precisa ser ator essencial nessa relação.

Por isso, este artigo buscou apresentar um olhar sobre o conceito de saúde que privilegia a agência e a subjetividade desse indivíduo Intersexo específico ou geral. Elegemos então a concepção de saúde cunhada por Gonzales-Rey, que contempla em sua concepção características essenciais que acreditamos trazer à tona o sujeito Intersexo como agente.

Procuramos, de forma breve, observar que a lógica branca e europeia que criou a medicina ocidental como ciência foi a mesma que no passado invisibilizou e ignorou seres por completo ao acreditar que não tinham corpos, almas e racionalidades que os tornassem dignos ou iguais à do branco europeu, sentenciando-os a uma (sub)existência apenas como força de trabalho e mão-de-obra para auxiliar a construir os modos de vida iguais aos do europeu branco.

No caso deste corpo que fala, é um corpo que sempre foi visto como não saudável e cujas decisões sobre seu presente e futuro nunca lhe pertenceram. Diferentemente deles, assim como Rey, observo que a saúde precisa ser holística e passar por história e cultura outras, capazes de nos enxergar a partir de nossa existência como seres cujo direito ao corpo intocado ainda precisa ser real.

Espero com este texto ter sido capaz de transmitir esse desejo como possibilidade e acreditar que algum dia esse sonho seja realidade para quem me lê

como testamento escrito e assinado, mesmo quando minha carne já for ausente da materialidade corpórea. Que haja vida agente, possível e real para os corpos Intersexo, em especial aqueles de genitália atípica.

Referências

BENTO, C. **O pacto da branquitude**. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BRASIL. Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012. Assegura validade nacional à Declaração de Nascido Vivo - DNV, regula sua expedição, altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 6 jun. 2012.

BRASIL. Lei nº 13.685, de 25 de junho de 2018. Altera a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de agravos e eventos em saúde relacionados às neoplasias, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012, para estabelecer a notificação compulsória de malformações congênitas. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2018.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: a subversão da identidade. São Paulo: Record, 2003.

CASSELL, J. Surgeon-warriors? **Science**, v. 253, n. 5021, p. 720-720, 1991.

CASSELL, J. Doing gender, doing surgery: women surgeons in a man's profession. **Human Organization**, v. 56, n. 1, p. 47-52, Spring 1997.

CHAZAN, L. K. **“Meio quilo de gente”**: um estudo antropológico sobre ultrassom obstétrico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.

CORRÊA, M. Não se nasce homem. *In*: ENCONTROS ARRÁBIDA/ENCONTRO MASCULINIDADES/FEMINILIDADES, 2004, Portugal. Disponível em: https://edis.ciplinas.usp.br/pluginfile.php/4413181/mod_resource/content/1/Nao_se_nasce_home_m_-_Mariza_Correa.pdf. Acesso em: 20 jan. 2023.

CORTEZ, M. **Dualidade ou constelação?**: intersexualidade, feminismo e biomedicina: uma análise bioética. 2015. 163 f. Dissertação (Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

COSTA, A. G. **As (im)possibilidades do desenvolvimento**: enquadres da intersexualidade no Brasil contemporâneo. Tese do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ. 2018. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/4808>. Acesso em: 16 fev. 2022.

DAVIS, G. **Contesting intersex**: The dubious diagnosis. New York: NYU Press. 2015.

DERRIDA, J. Signature event context. *In*: DERRIDA, J. **Limited Inc.** Evanston: Northwestern University Press, 1988. p. 1-23.

DREGER, A. D. **Hermaphrodites and the medical invention of sex.** Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.

DOYLE, J.; ROEN, K. Surgery and embodiment: carving out subjects. **Body & Society**, v. 14, n. 1, p. 1-7, 2008. DOI: 10.1177/1357034X07087527.

ELIAS, C. S. R. *et al.* Quando chega o fim? Uma revisão narrativa sobre terminalidade do período escolar para alunos deficientes mentais. **SMAD. Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool Drogas**, v. 8, n. 1, 2012.

GERMON, J. E. Dangerous desires: intersex as subjectivity. *In*: GERMON, J. E. **Gender: a genealogy of an idea.** New York: Palgrave MacMillan, 2009. p.153-183.

HERZLICH, C. Saúde e doença no início do século XXI: entre a experiência privada e a esfera pública. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 14, n. 2, p. 383-394, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312004000200011>.

HOLMES, M. Rethinking the meaning and management of intersexuality. **Sexualities**, v. 5, n. 2, p. 159-180, 2002.

KARKAZIS, K. **Fixing sex:** Intersex, medical authority, and lived experience. Durham: Duke University Press, 2008.

DOWNING, L.; MORLAND, I.; SULLIVAN, N. **Fuckology:** critical essays on John Money's diagnostic concepts. Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

LUZ, M. T. Cultura contemporânea e medicinas alternativas: novos paradigmas em saúde no fim do século XX. **Physis: Revista de saúde Coletiva**, v. 7, n. 1, p. 13-43, 1997. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73311997000100002>.

MEYERS, Q. Strange tensions: legacies of the colonial racial history of trans identities and intersex subjectivities. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 199- 210, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1215/23289252-9612851>.

MOURIQUAND, P. *et al.* Surgery in disorders of sex development (DSD) with a gender issue: If (why), when, and how? **Journal of Pediatric Urology**, v. 12, n. 3, p. 139-149, 2016. DOI: 10.1016/j.jpurol.2016.04.001.

MORLAND, I. Intersexuality is real? **Textual Practice**, v.15, n. 3, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1080/09502360110070439>.

MORLAND, I. 'The glans opens like a book': writing and reading the intersexed body. **Continuum**, v. 19, n. 3, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1080/103043110500176586>.

MORLAND, I. The injured world: Intersex and the phenomenology of feeling. **Differences**, v. 23, n. 2, p. 20-41, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1215/10407391-1629803>.

MORLAND, I. Intersex surgery between the gaze and the subject. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 160-171, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1215/23289252-9612781>.

NOWAKOWSKI, A. C. H. ; SUMERAU, J. E. ; LAMPE, N. **Transformations in queer, trans, and intersex health and aging**. Maryland: Lexington Books, 2020.

PRADO FILHO, K.; TRISOTTO, S. O corpo problematizado de uma perspectiva histórico-política. **Psicologia em Estudo**, v. 13, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-73722008000100014>.

PRECIADO, P. B. **Manifesto contrassexual**: práticas subversivas de identidade sexual. Tradução: Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1, 2014.

REY, F. L. G.; BIZERRIL NETO, J. **Saúde, cultura e subjetividade**: uma referência interdisciplinar. Brasília: UniCEUB, 2015.

ROEN, K. Clinical intervention and embodied subjectivity: atypically sexed children and their parents. In: HOLMES, M. **Critical Intersex**. Farnham: Ashgate, 2016. p. 15-40.

ROTHER, E. T. Revisão sistemática x revisão narrativa. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 20, n. 2, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>.

RUBIN, D. A. **Intersex matters**: Biomedical embodiment, gender regulation, and transnational activism. Albany: Suny Press, 2017.

SANTOS, P. L.; FORONI, P. M.; CHAVES, M. C. F. Atividades físicas e de lazer e seu impacto sobre a cognição no envelhecimento. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 42, n. 1, p. 54-60, 2009. DOI: <https://doi.org/10.11606/issn.2176-7262.v42i1p54-60>.

SANTOS-CAMPOS, T. E. **Educação de crianças e adolescentes intersexo**. 2020, 180 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Marília, 2020.

SEIXAS, R. **Metamorfose Ambulante – O som de Raul Seixas**. São Paulo: Philips, 1988. 1 CD (36 m).

SNORTON, C. Riley. **Black on both sides**: a racial history of trans identity. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2017.

SOUZA, N. S. **Tornar-se negro**: ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

TESSER, C. D.; LUZ, M. T. Uma introdução às contribuições da epistemologia contemporânea para a medicina. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 7, n. 2, p. 363-372, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232002000200015>.

4.3 INTERSEXUALIDADE: SOB O FOCO MORAL E POLÍTICO DA PERSPECTIVA DOS FUNCIONAMENTOS

*Amiel Modesto Vieira*³⁰ e *Maria Clara Dias*³¹

4.3.1 Introdução

A pesquisadora Maria Clara Dias (2018) fala sobre a exclusão social de determinadas parcelas da sociedade:

Há pelo menos 2500 anos a tradição filosófica tem se dedicado a caracterizar o que somos nós: eu, vocês e os indivíduos que de alguma forma julgamos semelhantes a nós. A tradição filosófica acredita que eu, vocês e eles possuímos algo que nos caracteriza e, segundo a tradição, nos distingue e identifica enquanto pessoas. Acredita, por assim dizer, em uma natureza humana, mais ou menos fixa e visivelmente delimitada. Esta forma de interpretar o que somos e, mais particularmente, de caracterizar os que devemos assumir como objeto de nossa consideração moral, como o foco de nossas principais políticas públicas e, finalmente, como aqueles aos quais se reporta o Direito, deixa ao relento um grande número de indivíduos, tradicionalmente, aqueles que de alguma forma desviam de um modelo normativo pré-estabelecido por estruturas de poder socioculturais, biomédicas e jurídicas hegemônicas (Dias, 2018, p. 2505).

Para reverter esse quadro de exclusão que perpassa não somente a episteme, mas toda a estrutura da sociedade vigente, e subverter os padrões biomédicos e socioculturais que têm promovido a perda de autoestima e o sofrimento de muitos indivíduos que fogem à estrutura heteronormativa hegemônica, Dias (2018) sugere a adoção de uma caracterização funcional do que somos, capaz de identificar as características singulares e os funcionamentos básicos de cada indivíduo, a saber, aqueles que integram o núcleo identitário de cada um de nós. Assumindo “que somos todos sistemas funcionais dinâmicos, flexíveis, que se transformam e se moldam, numa tentativa de melhor se harmonizar com seu entorno e alcançar uma realização plena” (Dias, 2016), buscaremos nos servir da perspectiva dos funcionamentos como

³⁰ Doutor em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS-UFRJ) <https://orcid.org/0000-0002-3903-0843>

³¹ Professora Titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do programa de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS-UFRJ) <https://orcid.org/0000-0002-4689-9256>

forma de identificar o que seriam os funcionamentos básicos negados e/ou negligenciados por um grupo específico de indivíduos, a saber, as pessoas Intersexo.

4.3.2 Uma caracterização funcional do que somos³²

A caracterização de indivíduos como sistemas funcionais é própria a uma forma de individuação que pretende dissolver uma série de impasses gerados a partir de uma concepção dualista do que somos. O dualismo, em sua versão tradicional, o dualismo ontológico, concebe os seres humanos como um composto de dois tipos de substâncias: uma substância pensante, uma mente, e uma substância física, um corpo. Entendidos dessa maneira, seria difícil justificar a consciência subjetiva que temos de nossa própria unidade e as razões pelas quais justificamos nossa forma de atuar no mundo. Acreditamos, por exemplo, que as diversas partes que compõem o nosso corpo se movimentam em uma certa direção porque acreditamos e desejamos certas coisas. Acreditamos, também, que nossas pernas, nosso sistema respiratório, assim como nossa memória, nossas crenças e desejos, fazem parte de um todo integrado que nos constitui como um indivíduo. A resposta funcionalista ao problema da interação entre o mental e o físico busca resgatar essa crença bastante trivial de que somos um todo integrado.

De acordo com a perspectiva funcionalista, a forma adequada de individuar uma entidade é por meio de suas propriedades funcionais. Dessa forma, o funcionalismo resgata também a nossa convicção de que alguns processos mentais podem ser realizados em estruturas com propriedades físicas distintas. Eles seriam multiplamente realizáveis. Ao identificar um evento mental por suas propriedades funcionais, estaríamos, assim, reconhecendo o caráter necessário de um componente material, porém, não reduzindo o evento em questão às propriedades físicas da estrutura material que o realiza.

A forma mais usual de exemplificar a concepção funcional é pela construção de modelos ou máquinas programadas para realizar um tipo de funcionamento específico. Nesse caso, as ilustrações vão desde máquinas mais simples, como as

³² A caracterização do que somos como sistemas funcionais e sua consequência para o debate acerca do aprimoramento humano é apresentada por Dias no artigo *Aprimoramento Humano: entre equívocos e desafios*. *Unisinos Journal of Philosophy*. 17 (3): 352-360, 2016. Formas diversas de apresentação do tema estão também presentes em Dias, 2015, 2016 e 2017.

que nos oferecem refrigerantes mediante a introdução de moedas de um determinado valor, até as máquinas conxionistas de tipo PDP (*Parallel Distribution Process*) ou redes neurais. Parece evidente que a complexidade das funções que usualmente realizamos exige que sejamos exemplificados por modelos flexíveis e bastante complexos. Complexos talvez o suficiente para não sermos, ainda, capazes de descrevê-los. Nesse sentido, a proposta funcionalista parece vulnerável a uma objeção de fato, mas, se estivermos corretos, poderá mostrar que, em princípio, nada impede que esta seja a forma mais adequada de descrever o que somos.

Seres humanos, segundo uma descrição funcional, poderiam, assim, operar como um programa flexível composto de vários módulos. No primeiro módulo, estaria um *scanner*, responsável pela recepção dos *inputs*. A partir daí, podemos imaginar vários módulos, entre os quais um módulo avaliador, responsável pela seleção das informações que chegaram à etapa final, qual seja, a produção de um comportamento específico. A peculiaridade desse tipo de programa estaria na sua capacidade de aprender, ou seja, de alterar o produto em função de um novo *input* que incluiria os efeitos produzidos pelo comportamento do agente nas etapas anteriores. Em outras palavras, o *output* gerado promoveria respostas externas que, por sua vez, seriam introduzidas no *input* e avaliadas pelo programa de forma a fornecer um novo resultado. É desse modo que um modelo programado para reconhecer letras, como o que é utilizado com sucesso nos correios, altera, ou melhor, aprimora sua *performance*, na medida em que lhe são oferecidas grafias variadas de uma mesma letra e que o programador responde negativa ou positivamente ao seu reconhecimento ou não de uma letra. Tais modelos são capazes de reordenar os seus dados de forma a passar a reconhecer características anteriormente ignoradas.

Com base na análise funcional de modelos com programa flexível, passaríamos, então, a atender algumas das principais características do modelo humano, como, por exemplo, nossa capacidade de aprender a partir das experiências vividas e de responder de forma diferenciada, inédita, a novas situações. O processo de avaliação dos dados informacionais obtidos e a resposta consecutiva caracterizam a capacidade de deliberar. Nesse sentido, nosso tão proclamado poder de deliberação nada mais expressaria do que a totalidade do processo que envolve a verificação, a seleção e a avaliação de informações e, finalmente, uma resposta comportamental. Do mesmo modo, podemos ainda descrever o que chamamos de liberdade como uma capacidade de conduzir respostas/ações com base na avaliação e na ponderação das

diversas informações obtidas.

Se essa descrição for realmente sustentável, teríamos então que enfrentar suas consequências. Já de partida, vemos esmaecer a ideia de uma base fixa, imutável, detentora do que imaginamos ser a nossa essência propriamente humana. A pergunta acerca da identidade de cada ser deverá ser respondida por referência a uma rede de processos que envolve a *performance* de distintas funções, algumas das quais usualmente descritas por meio de um vocabulário mentalista. Chamaremos essa rede de *Self*. O *Self*, assim entendido, não é uma unidade transcendente que controla todo o sistema, nem uma parte específica dele. É uma rede ou uma conjunção de processos. Enquanto tal, ele está projetado no mundo e em constante processo de transformação. Seu campo informacional é composto de dados oriundos tanto dos limites internos, quanto externos ao próprio corpo. Dentro dessa descrição, nossos limites tornam-se também flexíveis. Nosso *Self* já não pode ser identificado ao cérebro, nem delimitado pelos contornos do nosso corpo físico/biológico.

Se quisermos, por exemplo, pensar a nossa atividade cognitiva segundo o modelo funcional da relação *inputs-outputs* e estados mentais diversos, onde deveríamos estabelecer os limites do processo cognitivo? Segundo a perspectiva funcional, a cognição não poderia ser identificada como uma etapa específica do processo, um estado mental isolado, por exemplo, mas ela seria todo o processo. Nesse caso, ela envolveria necessariamente uma complexa rede de *inputs*, internos e externos, e *outputs*. Os elementos que compõem o processo cognitivo fazem, assim, parte de uma estrutura dinâmica, em que os papéis desempenhados estão em constante permuta. Registros deixados em livros, diários, computadores e no nosso entorno ambiental ocupam um papel tão fundamental em nosso *set* informacional quanto nossas sensações e traços de memórias e as operações realizadas no nosso cérebro.

O papel desempenhado por objetos localizados fora dos limites do nosso corpo, ou ainda por artefatos, no nosso processo cognitivo talvez explique por que nosso raciocínio se vê debilitado quando perdemos nossa agenda ou as informações que guardamos em nossos computadores. Pode explicar também a falência cognitiva de idosos que são afastados do lugar, de pessoas ou objetos que lhes eram familiares. Segundo essa visão, nosso processo cognitivo se estende necessariamente para além do nosso cérebro e dos limites do nosso corpo, pois envolve, como parte constitutiva de seu mecanismo, os *inputs* que compõem o conteúdo de nossos

pensamentos e o que, em vocabulário kantiano, chamaríamos de síntese deles através de conceitos. A linguagem é ela mesma um artefato que incorporamos à nossa estrutura cognitiva e que assume o papel de projetar no mundo parte de nossos conteúdos mentais. A mente ou o *Self*, entidade narrativa à qual reportamos não apenas nossa cognição, mas a totalidade de nossos estados psicológicos, não é uma entidade que se relaciona ou representa o mundo, mas sim uma rede de processos no mundo.

Nosso *Self* não tem como limite o cérebro ou nossa estrutura corporal. Ele incorpora em si objetos e se projeta no mundo. Muitos desses objetos são sistemas acoplados que nos permitem realizar uma série de tarefas e potencializar nossos funcionamentos. Eles abrangem desde objetos como óculos, dentaduras, aparelhos auditivos, bengalas, até próteses mamárias ou genitais, pernas mecânicas, celulares, microcomputadores etc.

Sob o ponto de vista moral, consideramos que uma das principais vantagens dessa visão é que ela retira o estigma que muitos indivíduos carregam de serem pessoas disformes ou “pessoas com deficiência”, amplamente caracterizadas por necessitarem de um complemento dito artificial ou mecânico para realizarem seus funcionamentos básicos e/ou por incorporarem à sua identidade pessoal elementos claramente desviantes dos padrões hegemônicos. O importante aqui é ressaltar que todos os seres humanos possuem sistemas acoplados. Todos possuem objetos que incorporaram como parte constitutiva de sua identidade narrativa. Alguns de nós, contudo, se rendem a um processo de autoilusão que faz com que nos consideremos criaturas genuinamente puras, pertencentes a uma espécie única, que curiosamente se define por oposição aos seres que julgamos pertencer a uma categoria outra, também frequentemente considerada hierarquicamente inferior.

De acordo com o modelo proposto, a ausência ou presença de certos atributos e/ou capacidades não pode ser caracterizada como um desvio/transtorno ou deficiência, pois todos possuímos atributos e capacidades diversas e as exercemos em níveis distintos no decorrer de nossa existência. Isso significa que precisamos estar atentos à diversidade de demandas que cada indivíduo possa vir a possuir em decorrência de sua forma singular de constituição identitária. Um entorno inadequado faz com que o indivíduo não consiga realizar plenamente seus funcionamentos. Uma sociedade incapaz de acolher demandas que não estejam conforme um modelo hegemônico, prefixado socio-culturalmente, gera adoecimento, deficiência, perda de

autoestima e falta de vínculo e de compromisso social.

Indivíduos transexuais ou indivíduos com genitália ditas atípicas, com padrões de conformação física ou comportamental vulgarmente interpretados como destoantes de sua conformação genética, são apenas indivíduos singulares, assim como todos os demais. Sob o ponto de vista político, o estabelecimento de grupos identitários específicos pode representar uma poderosa arma na luta por direitos comuns. Contudo, não podemos esquecer que a fixação de qualquer modelo identitário é uma arma perigosa, pois gera, inevitavelmente, exclusões, indivíduos negativamente caracterizados como desviantes e a invisibilização de demandas singulares, próprias a qualquer indivíduo. Ao forcamos a moralidade e a justiça nos funcionamentos básicos dos diversos sistemas funcionais/indivíduos, pretendemos contribuir para o florescimento de todos aqueles que, à sua própria maneira, buscam garantir uma integridade pessoal e, com ela, a autorrealização. Nesse sentido, a adequação de nossas instituições às demandas mais básicas de todos os indivíduos que a compõem deveria ser o foco privilegiado de políticas públicas comprometidas com um princípio moral, universal, de respeito.

4.3.3 A pessoa Intersexo: funcionamentos negados/negligenciados

Quando falamos em Intersexualidade, falamos no poder da medicina sobre os corpos. Isso posto, é preciso dizer que a intersexualidade é uma invenção médica para enquadrar a biologia do corpo humano que se apresenta fora do padrão que a ciência médica aguarda após o nascimento (Eckert, 2016). Biologia essa que pode tanto manifestar-se entre a infância e a adolescência – pelo desenvolvimento ou subdesenvolvimento de gônadas (ovário e testículo), pela produção de hormônios tais como estrogênio e testosterona, pela falta do ânus etc. – como também na configuração cromossômial (XX e XY).

Assumimos aqui que esses corpos são intersexualizados pela medicina e, a partir dessa intersexualização (Eckert, 2016), produz-se a diferença e/ou estigmatização deles. Conforme Guimarães Junior (2014) e Martin, Spink e Pereira (2018), o diagnóstico ganha força de identidade, e essa identidade é inscrita no corpo da pessoa Intersexo, seja pelo ato de diagnosticar e identificar a pessoa acoplada a sua biologia, seja pelo fato de esse diagnóstico auxiliar na produção de uma outra identidade: a *identidade cirúrgica* (Eckert, 2016a; Guimarães Junior, 2014)

O olhar que primeiro identifica o corpo Intersexo como monstruoso ou como um erro da natureza é o mesmo que sustenta a resolução nº. 1664 do Conselho Federal de Medicina, segundo a qual tais corpos são percebidos como “emergência biológica e social” (CFM, 2003). A ação emergencial sobre o indivíduo Intersexo de genitália atípica é chancelada por essa instituição, que só possibilita duas saídas para esses corpos: a intervenção cirúrgica ou a hormonização induzida.

No Brasil, após 20 anos de sua publicação, a resolução nº. 1664 ainda é válida, ignorando-se outros consensos ocorridos no mundo entre a primeira e a segunda décadas dos anos 2000 (Pires, 2018). Depois de dez anos, ocorreu a reunião de revisão e novas propostas do consenso realizado em Chicago no ano de 2006 (Lee *et al.* 2016). Ali pode se notar uma presença bem mais numerosa e significativa de integrantes do movimento Intersexo internacional. Apesar disso, o resultado do consenso de 2016 ainda mantém um olhar bastante questionável sobre o corpo Intersexo.

Sabemos que a endonormatividade (Nowakowski; Sumerau; Lampe, 2020) busca se impor para apagar, invisibilizar e modificar vidas Intersexo, para que estas vivam uma vida endossexo. Assim, ressaltamos aqui a importância da abordagem proposta pela Perspectiva dos Funcionamentos, que entendemos como modo adequado de individuação de um sistema funcional, e a exigência do respeito ou consideração moral dos diversos sistemas, o que pode contribuir para que um indivíduo Intersexo possa de viver em sociedade com seu corpo e autonomia preservados. A Perspectiva dos Funcionamentos rompe com uma concepção essencialista e fixa do indivíduo e, concomitantemente, o paradigma de normalidade hegemônico, pensado e imposto à revelia do que cada indivíduo entende como sendo sua forma mais satisfatória de ser e estar no mundo.

4.3.4 O que deveria ser normal?

A discussão sobre o que devemos entender como sendo o “normal”, para Amundson (1999, p. 33) está inserida nos âmbitos da biologia e da medicina. Segundo o autor, há uma diferença entre a performance individual e a performance que se deveria atingir. Nesse sentido, haveria uma doutrina que perpassaria essas disciplinas de conhecimento e seria difundida no meio social, induzindo a julgamentos próprios, baseados num ideal social de performance a ser atingida. Tais julgamentos levariam

à não aceitação de indivíduos com variações biológicas supostamente não tão visíveis e comuns em nossa sociedade (*idem, ibidem*).

Cabe adicionar que também o filósofo Michel Foucault, ao abordar a anormalidade atribuída aos corpos denominados hermafroditas, no passado, atualmente ditos Intersexo, destaca o *status* social e biológico deles, atrelando tal tratamento ao surgimento e aprimoramento da medicina (Branco, 2018; Foucault, 2001; Machado, 2008; Dreger, 1998).

Atualmente, abordar a raça como uma anormalidade biológica seria uma atitude interpretada como anticientífica. Contudo, ainda nos deparamos com o fato de que, no meio científico, alguns corpos são classificados como emergências biológicas e sociais, como, por exemplo, os corpos Intersexo, segundo o CFM brasileiro. Tais corpos são utilizados, muitas vezes, como exemplos para discutir os conceitos de saúde, doença e desenvolvimento corporal, negligenciando-se o fato de que a diversidade de corpos e desenvolvimentos é parte da própria biologia (Amudson, 1999; Camargo Junior, 2003; Costa, 2018).

A origem do olhar médico para corpos Intersexo está no psicólogo estadunidense John Money e seu modelo de cuidado em saúde para essa população, centrado no sigilo e na cirurgia. Cortez (2015) destaca que esse modelo estava baseado numa identidade de gênero feminina ou masculina para a qual era imprescindível que o pênis e o clitóris tivessem o tamanho adequado, de acordo com o que hoje se conhece nos estudos Intersexo como falômetro. O falômetro se tornou conhecido como um modelo métrico apresentado por Kessler (1998) e legitimado pelo consenso de 2006 (Lee *et al.*, 2006.)

O genital fora do tamanho do falômetro deve ser redesenhado cirurgicamente até os 18 meses de vida, educando-se a criança no gênero de seu novo genital, pois, para Money até essa idade, a criança estaria sob uma ideia de neutralidade de gênero. Nesse período, seria possível moldar o gênero, e isso deveria ser feito especialmente no caso das crianças nascidas com genitais atípicos. Ainda nesses casos, valeria também a máxima médica segundo a qual “é mais fácil abrir um buraco do que levantar um poste” (Machado, 2008). Essa máxima contém inúmeras questões, mas o que é preciso destacar aqui é que ela se aplica a corpos em que o desenvolvimento corporal e sexual se encontra fora de um padrão métrico, um padrão incapaz de agregar em sua medida a diversidade de corpos – e profetiza, sem titubear, que a futura performance dele é inatingível. (Kessler, 1998)

Por muito tempo, esse modelo foi alardeado ao redor do globo e repercutido pelo mundo médico como símbolo de sucesso e eficácia de sua aplicação. O modelo se difundiu a partir do estudo de caso de um paciente de Money, conhecido pelo nome de David Reimer (Colapinto, 2001). Esse modelo popularizou-se na medicina endocrinológica e na cirurgia pediátrica. Décadas mais tarde, o médico Milton Diamond, principal opositor de Money, trouxe a público a história de David e todo o sofrimento a ele imputado pelo modelo proposto. A partir dos anos 1990, o movimento Intersexo passou a contestá-lo e, desde então, com a divulgação de suas trágicas histórias de vida, representam um contraponto, em nível global, cada vez mais potente ao modelo Money (Davis, 2015; Roen, 2009; Davis, 2015a). Contudo, apesar de todas as manifestações contrárias a esse modelo, ele resiste, sendo até hoje entendido como uma “necessidade” emergencial de adequação e, por conseguinte, sendo aplicado em muitos países, inclusive no Brasil.

É importante lembrar um ponto destacado por Amundson (1999), no tocante ao cuidado médico: ainda permanece uma visão sobre um desenho do corpo humano como algo fixo, logo, aplicável a todos. Negligencia-se a ideia de que cada ser humano é um indivíduo único e que, mesmo havendo cromossomos iguais, cada indivíduo é singular quando focamos nas suas escolhas e/ou na sua forma de ser e estar no mundo.

A intersexualidade pode ser reportada, portanto, como uma ameaça à ideia de uma natureza física fixa do ser humano e como um desafio para uma compreensão de cuidado em saúde acostuada a subtrair as diferenças, em nome de um tratamento universal concedido a seres humanos em abstrato. Um cuidado mais atento às singularidades não olharia a quebra de padrão como uma anormalidade, ainda que a reconhecesse como estando à margem do padrão estatístico.

O que consideramos normal ou adequado não seria um cuidado em saúde comprometido com a ideia de um corpo fixo, mas com uma compreensão da diversidade e da dinâmica que habita cada um de nós. O normal não pode ser: 1) imputar ao outro o rótulo de anormal pela quebra de um padrão estatístico e 2) promover o esquecimento de sua própria singularidade. O normal não deve ler e buscar promover o apagamento da intersexualidade, na busca de fazer do cuidado um dispositivo de controle sobre os corpos.

Para dar voz e visibilidade às pessoas Intersexo e deixar com que falem dos funcionamentos que lhes estão sendo negados, resgataremos no próximo tópico

histórias Intersexo e apresentaremos um breve histórico do movimento Intersexo internacional e nacional. Para além do incômodo que a intersexualidade provoca no meio social, apesar de serem pequenas vitórias até agora alcançadas, é possível vislumbrar alguma mudança na paisagem da vitrine social dos corpos. Para concluir, defenderemos, com a Perspectiva dos Funcionamentos, um cuidado em saúde singular e transparente com vistas ao florescimento dos corpos Intersexo.

4.3.5 Um movimento incômodo

Georgiann Davis e Sharon Preves (2019) abordam os 25 anos do movimento Intersexo, lembrando-nos que o movimento internacional nasce com uma carta-denúncia ao editor da revista *The Sciences*, em 1993, sobre as violações em direitos humanos e cuidados em saúde dessa parcela da população. A carta-denúncia é escrita por Bo Laurent³³, incitado pelo artigo, lançado naquele mesmo ano e revista, da bióloga Ann-Fausto Sterling dizendo que na realidade não teríamos apenas dois sexos, mas cinco, dentre eles, o pseudo-hermafrodita masculino, o feminino e o Intersexo verdadeiro³⁴ (Fausto-Sterling, 1993, 2002).

Na mesma carta-denúncia, Bo deixa registrada sua caixa-postal e recebe vários relatos/contatos de pessoas Intersexo ao redor do mundo, o que leva então o escritor a fundar a primeira associação Intersexo do mundo, a *Intersex Society of North America* (Isna).³⁵ A Isna fundou grupos de apoio nos Estados Unidos, criou uma newsletter que circulou por vários países e, em 26 de outubro de 1996, fez o seu primeiro protesto público em frente à Academia Pediátrica Americana em Boston, nos Estados Unidos. Esse dia ficou eternizado e é celebrado até hoje pela comunidade internacional Intersexo ao redor do globo como o Dia da Visibilidade Intersexo (Preves; Davis, 2019).

Em 2006, ocorreu o consenso de Chicago, para definir ações comuns relativas à intersexualidade, com especialistas do mundo todo, incluindo uma representante da Isna. Dois anos depois, a Isna foi encerrada, dando origem a uma nova associação focada em educação médica, a *Accord Alliance*, e essa associação

³³ Bo usou por muito tempo o pseudônimo de Cheryl Chase.

³⁴ A carta está publicada no Site da Isna, mantido pela Interact. Organização Intersexo americana voltada para jovens. Disponível em: <https://isna.org/articles/chase1995a/>

³⁵ A *Intersex Society of North America* (Isna) tem uma história que merece ser discutida com mais detalhes, mas que não será objeto do presente artigo.

abraçou o consenso de 2006.

Nosso ponto aqui é pinçar partes da história do movimento para que seja conhecido e reconhecido seu poder de auxiliar a esculpir uma identidade política Intersexo baseada em suas propostas de luta e, a partir disso, inspirar pessoas a se compreenderem, a criarem organizações de apoio em seus países, além de atrair aliados endossexo com suporte financeiro. A Isna foi a primeira e, inspirados nela, outras associações/organizações surgiram ao redor do globo.

Um exemplo é organização mexicana Brújula Intersexual, fundada em 27 de outubro de 2013. A ativista Intersexo mexicana Laura Inter fundou a primeira organização mexicana, que se espalhou pelo mundo hispânico e está presente na América Latina e na Espanha. Além dela, é preciso destacar que na América Latina, especificamente na Argentina, o ativista Intersexo e historiador Mauro Cabral, desde o final da década de 1990, tem despontado nos estudos Intersexo. Começou traduzindo textos do inglês para o espanhol e produzindo artigos acadêmicos em espanhol sobre intersexualidade e até hoje é uma referência neste quesito, no plano internacional, tendo sido consultado, escrito e contribuído para os princípios LGBTI+ criados pela ONU.

O passeio sobre o breve histórico do movimento se encerra no Brasil, onde a dinâmica do movimento internacional iniciado há mais de 30 anos agora ocupa um outro lugar, o da rede social virtual. Tudo começa no final de 2015, com a criação da página Visibilidade Intersexo no Facebook, fazendo um trabalho parecido com o feito por Mauro Cabral. A página traduzia textos Intersexo (que na época eram mais comuns na web em inglês) para tornar mais conhecida a questão.

Concomitantemente à criação da página, criou-se uma comunidade no Facebook somente para pessoas Intersexo brasileiras, com o objetivo de agregar, conectar e acolher histórias e pessoas e fornecer o máximo de informação possível sobre os estados intersexuais. Desse grupo, surgiu a ideia de uma organização capaz de pôr em prática os objetivos da comunidade, possibilitando a garantia de direitos e o acolhimento a essas pessoas e tendo como alvo maior o fim da mutilação genital Intersexo no país.

Em 2020, finalmente, a Associação Brasileira Intersexo (Abrai) tem o reconhecimento jurídico do governo brasileiro e torna-se uma realidade materializada em Organização Não-governamental. Hoje, essa associação atende o público Intersexo com o objetivo de acolher esses indivíduos e suas famílias e informar a

comunidade Intersexo e a sociedade sobre a intersexualidade.

O movimento Intersexo conquistou sua primeira vitória após um fórum Intersexo com vários representantes do globo, em Malta, e conseguiu a promulgação de uma lei a fim de acabar com a mutilação genital Intersexo naquele país, em 2015. Hoje, há leis com esse mesmo objetivo em Nova York, Portugal, Grécia, Chile e Quênia. No caso do Brasil, o fim da Mutilação Genital Intersexo ainda é um sonho, porém, já é possível a emissão de certidão de nascimento sinalizando o “sexo ignorado”.

Voltando a falar do movimento internacional, é preciso registrar que dez anos depois do consenso de Chicago, em sua atualização, a presença do movimento no consenso foi bem maior, tanto no texto como numericamente³⁶. Em toda essa breve história aqui relatada, pode-se perceber que, apesar de jovem na sociedade civil internacional e nacional na esfera dos movimentos sociais, houve vitórias esparsas ao redor do globo.

A jornada da intersexualidade em nível global tem muitos desafios. Desafios esses que começam a partir de diversas histórias de dor e mutilação e que, apesar da invisibilidade, são contadas para promover mudanças. Foram elas que tornaram possível a caminhada até aqui do movimento Intersexo nacional e internacional e provavelmente será por meio da sua difusão que esse movimento continuará vivo e lutando (Davis, 2015).

Para não ficarmos apenas na teoria, apresentaremos a seguir três histórias que procuram mostrar a materialidade da intersexualidade. São histórias singulares e diversas, revelando que o florescimento dos funcionamentos básicos da pessoa Intersexo só é possível mediante a transparência no cuidado em saúde, algo extremamente raro quando o foco são pessoas Intersexo.

A primeira história apresentada é a de Sunflower³⁷ foi assignada no feminino ao nascer. Ela teve e ainda possui um clitóris “avantajado” para padrões médicos, padrões esses que são erigidos com vistas ao corpo endossexo, reforçando o que se nomeia por endonormatividade. Ou seja, o poder médico e as instituições sociais a reforçam com o objetivo de apagar experiências Intersexo em nossa sociedade (Nowakowski; Sumerau; Lampe, 2020).

³⁶ Ver mais detalhes em Pires (2020).

³⁷ N.A: Um nome ficcional para preservar a pessoa que conta história. O nome foi escolhido em comum acordo com a pessoa.

Quando estava no ensino médio, Nik teve que ir a uma ginecologista-obstetra, porque, apesar de sua menstruação já ter começado, havia parado tempos depois. Isso ocorreu por causa de problemas relacionados à comida e à prática de cross-country e de corrida no período do colegial. Na consulta, foi-lhe perguntado se havia problemas na família relacionados a gravidez ou no nascimento, porém, ela disse que não. A médica seguiu informando que ele³⁸ não poderia ter filhos e que tinha uma cicatriz em seu clitóris (Nowakowski; Sumerau; Lampe, 2020).

Depois de tentar entender aquela questão, inclusive colocando outras perguntas e tentando provar coisas relacionadas a seu corpo para a médica, ele desistiu. Momentos como esses se somaram a experiências vividas durante sua vida escolar, até a graduação, em contato com pessoas LGBTI+, contando suas diferentes histórias. Já havia naquele momento um entendimento parcial de que Nik era Intersexo, entretanto, isso só se concretizou após duas entrevistas de pessoas Intersexo para sua dissertação, quando sua identificação com aqueles respondentes a fez ir atrás de seu prontuário médico do hospital para entender se era uma pessoa endossexo ou Intersexo.

Com seus registros médicos, Nik pediu ajuda a uma amiga com experiência em sociologia médica e que já havia lido muitos prontuários médicos. Com essa ajuda, descobriu-se que os médicos haviam dito a seus pais que precisavam fazer uma timpanotomia na criança. A timpanotomia é uma cirurgia com “a finalidade de drenagem das efusões, como também de promover a aeração da orelha média e proporcionar a sua drenagem pela tuba auditiva” (SPSP, 2011). Os pais consentiram com a cirurgia. O prontuário dispunha também de uma vaga anotação sobre o fato de Nik ter uma genitália atípica. Para além da cicatriz em seu clitóris, não há rastros de como era seu genital originalmente.

O caso de Nik mostra algo muito cotidiano em histórias Intersexo: a medicina exercendo seu poder sobre esses corpos, muitas vezes mentindo ou ocultando informações de pacientes ou familiares sobre sua condição relacionada à intersexualidade. Nota-se aqui o peso do segredo e do silêncio como estruturantes do cuidado Intersexo, em que muitas vezes a ética médica passa longe e reforça que o “não-lugar” desses corpos precisa ser buscado no poder do diagnóstico e da técnica médica (Karkazis, 2008; Davis, 2015).

³⁸ Sunflower se identifica como pessoa trans Não-binária, por isso utilizamos esse pronome.

A segunda história se refere a Haru, homem trans negro e não-binário da Baixada Fluminense. Nascido em 1996, segundo ele, até o sexto mês de gravidez sua mãe não sabia que estava grávida. Durante o pré-natal, não se sabia qual era seu sexo, mas após um período de incertezas da equipe médica, foi assignado como menina.

Desde os dez anos, foi hormonizado para o feminino, com a mesma explicação médica de que precisava tomar vitaminas para crescer. Seu contato com a intersexualidade se deu em comunidades virtuais – os diversos relatos que lia na rede fez com que percebesse e assumisse sua condição biológica Intersexo (Costa, 2018).

Haru descobriu nessas comunidades que as vitaminas, na realidade, eram estrógenos, hormônios que feminizaram seu corpo. Decidiu então não tomar mais e confrontou sua mãe com relação a sua história. Junto com Cari Rez e Olivia Denardi, amigos que fez nessas comunidades, resolveu criar a página do Facebook Visibilidade Intersexo, a primeira página da internet brasileira a falar da intersexualidade em português.

O terceiro personagem é um dos autores deste texto. Aos 33 anos, descobriu, vendo seu prontuário médico, passando por diversos exames e tentativas de conseguir um diagnóstico para compreender o porquê ter um pênis pouco desenvolvido em comparação a outros bebês, além de sua uretra estar fora do local esperado para uma criança do sexo masculino.

Em março de 1983, após a mutilação que sofreu, foi assignado no sexo feminino. Anos de tratamento médico e cirurgias se passaram, sem ele saber por que passava por tudo aquilo. Fora hormonizado e operado sem saber a causa. Na idade adulta, foi convidado a se retirar do convívio familiar, uma família evangélica, por assumir-se lésbica. Foi vítima de um tratamento médico e social cruel que procurou eliminar na infância sua condição Intersexo.

Somando as histórias acima, percebemos que são histórias que se conectam pela impossibilidade de existir com um corpo Intersexo intocado, seja pela mutilação genital ou a ingestão de hormônios. Assim como em muitas outras histórias Intersexo, a biomedicina os diagnosticou e os nomeou como Intersexo, sem lhes ser permitido viver sua condição presente e assumir, no futuro, a autoria das decisões sobre seu corpo e sua própria identidade (Eckert, 2016).

4.3.6 Sobre os Funcionamentos Intersexo

Até aqui, abordamos questões prementes para a luta e o movimento Intersexo. Gostaríamos agora de dar um passo a mais e apontar as demandas Intersexo como uma questão de justiça. Para tal, recorreremos à Perspectiva dos Funcionamentos, buscando identificar os funcionamentos da pessoa Intersexo que estão sendo violados.

A Perspectiva dos Funcionamentos entende o ser humano como um sistema funcional, composto de diversos sistemas, como, por exemplo, sistema digestivo, reprodutor e outros. Cada sistema tem uma função ou funcionamentos que podem ser compreendidos como básicos, complementares e complexos. Os funcionamentos básicos são identificados por Dias (2018) como aqueles que garantem a integridade, a identidade funcional e a singularidade de cada indivíduo. Tais funcionamentos podem ser diferentes para cada indivíduo e para um mesmo indivíduo em momentos distintos de sua existência. No caso da intersexualidade, gostaríamos de destacar ao menos dois funcionamentos básicos: a corporificação integral e o acesso à informação. Como a perspectiva ressalta e as histórias de vidas Intersexo revelam, cada indivíduo Intersexo tem vivências distintas e por meio delas constitui seu universo de desejos e crenças. A falta de transparência sobre dados de sua história pessoal impede seu processo de construção de uma identidade qualitativa (Dias, 2015) minimamente satisfatória, além de obstruir muitas de suas alternativas e projetos de vida.

Entendemos aqui que a intervenção precoce sobre seu corpo viola não apenas sua integridade física, como também a formação de sua subjetividade e seu poder futuro de deliberação, gerando assim danos psíquicos profundos capazes de comprometer a autoestima e o florescimento do indivíduo (Feinberg, 1992).

Médicos endocrinologistas, por estarem inseridos num modelo de ciência que separa mente e corpo, continuam a encaminhar crianças nascidas com intersexualidade de genital atípico para cirurgias pediátricas. Isso ocorre por acreditarem na construção do indivíduo com base no princípio da socialização que fundamentava o protocolo de cuidado de John Money, como princípio capaz de promover, após a reescrita cirúrgica do corpo e do sexo/gênero da criança, a reinserção dessas pessoas na vida em sociedade como se a intersexualidade fora apagada de seu corpo (Kessler, 1998; Davies *et al.*, 1995).

Pode-se dizer que temos uma existência corporal-subjetiva. Nosso ser corporificado está exposto a relações positivas e negativas. Somos vulneráveis e, segundo Soneghet (2021), a sociologia existencial da subjetividade corporificada busca explorar os mecanismos pelos quais a vulnerabilidade é socialmente moldada, resultando em sua modificação e reconstrução a partir de uma base corporal.

Nesse sentido, o corpo é vulnerável à ação “da violência, carinho, abandono e amor” (Soneghet, 2021, p. 32). Além disso, a vulnerabilidade pode ser ampliada em contextos socioeconômicos e em relações de poder, podendo ainda estarmos sujeitos a diferentes formas socialmente construídas de violência, esquecimento e destruição (Butler, 2019).

Isso implica que as diferenças entre “material e simbólico, agência e estrutura, sujeito e objeto, humano e não humano, devem ser reconsideradas a luz da subjetividade corporificada como um nexo de reversibilidades em relações reversíveis com o mundo” (Soneghet, 2021, p. 32). Estar como sujeito e corpo no mundo é um processo contínuo no qual nossa relação com o outro nunca para de ser trabalhada.

As reversibilidades, são dualidades que subsistem em nossa existência para Soneghet (2021), ou seja, na existência Intersexo podem existir o silêncio do não-saber sobre si, por exemplo, convivendo com um incomodo de ir atrás de sua própria história na tentativa de entender a razão por que este silêncio incomoda tanto. As histórias relatadas neste texto são sinais de como as reversibilidades existentes nesses corpos Intersexo guardam um potencial ou não de mudança. Entretanto, acreditamos que, apesar disso, ao elencarmos como funcionamento básico do indivíduo Intersexo a corporificação integral, tornamos esse potencial não somente uma possibilidade de um acontecimento, mas sim uma realidade.

Esse funcionamento básico se tornaria a prática da liberdade de ser e existir como sujeito corporificado para todas as pessoas Intersexo. Essa existência ocorreria sem quaisquer impedimentos, seja pela medicina ou pelo Estado, com a liberdade do indivíduo de viver e fazer o que acha mais adequado ao seu corpo de acordo com sua subjetividade.

Aqui, surge outra questão fundamental: o papel dos pais diante da presença da intersexualidade. Ao apontar isso, é preciso lembrar que ainda estamos numa sociedade complexa atravessada pelo que Nikki Sullivan (2007) identifica como “ótica branca”, ocidental e que perpassa por gênero, raça e classe. Essa ótica costuma ser adotada por pais, com a justificativa de que desejam fazer o melhor pelo interesse da

criança. Como Archard e Macleod (2002) sugerem, tal tentativa resvala, em muitos casos, quando os filhos são percebidos como uma extensão dos próprios pais, antecipando e depois materializando um interesse ainda não revelado para a criança. Ao pensarmos nos mencionados funcionamentos, o poder parental se coloca como um impedimento a sua realização.

A Constituição de 1988 diz em seu artigo 227 que:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1998, Art. 227).

A partir da resolução do CFM de 2003, a intersexualidade é apresentada pelo poder médico no Brasil como “urgência biológica e social” ou como “anomalia da diferenciação sexual”, necessitando, portanto, de uma cura que deve ocorrer na sala de cirurgia.

Estamos, assim, diante de uma violência curativa (Kim, 2017). Essa violência, para Kim, é a que ocorre através “[d]o exercício da força para apagar as diferenças em prol do suposto melhoramento do Outro” (Kim, 2017, p. 14, tradução nossa). Apesar de a autora focar essa violência no caso de pessoas com deficiência, ela também aponta que ela se aplica no caso do desejo social de “conformidade de gênero e a heterossexualidade” (Kim, 2017, p. 10, tradução nossa).

Esse desejo pela normalidade (Dreger, 1998; Carpenter, 2018) que assola a sociedade ocidental é mais um impedimento para o funcionamento da corporalidade integral. Segundo nossa constituição, tal funcionamento precisa ser garantido e preservado pelos pais e pelo Estado, a fim de proteger as crianças sob sua custódia de qualquer violência. Crianças são sujeitos de direito em desenvolvimento, por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) as classifica como sujeito de direito especial, ou seja, são tuteladas pelos pais ou responsáveis.

O que entendemos aqui é que a violência curativa (Kim, 2017), portanto, beneficia a sociedade e mina a possibilidade de florescimento da pessoa Intersexo e seu projeto de vida. O que podemos inferir a respeito da lógica violenta endossexo para pessoas Intersexo é o fato de que ela está ladeada da ideia de cura. Essa cura

é prometida com o apagamento cirúrgico-cosmético da intersexualidade e não leva em conta que a ideia cosmética da cirurgia não elimina a condição Intersexo, mas a impede de ser vida vivida de acordo com as escolhas do próprio indivíduo (Morland, 2022).

A mudança cosmética e corporal pode ser feita para aliviar o desconforto dos pais com a história social e com seus planos ameaçados. Porém, as cicatrizes na região genital são denúncias sutis e visíveis de que o amor e os planos dos pais eram condicionados à intervenção médica e cirúrgica, tornando essas pessoas “anormais”, mesmo com a aparência de “normalidade” (Morland, 2022; Aspinall, 2006).

Como ressalta Patosalmi (2009), tornar-se pessoa é um processo, processo esse que é mediado por nossas experiências, nosso corpo, nossa interação com o mundo externo e interno. Quando nossos corpos são alterados, nossa percepção também se altera, com tudo que nos rodeia. (Roen, 2009; Soneghet, 2021; Asch, 2006)

A bioética, como campo do saber interdisciplinar, busca em seu repertório falar sobre o humano, o não humano, a justiça distributiva, a saúde dos humanos, dos não humanos e do planeta. Ela é fundamental ao pensarmos sobre os modos de conduta da sociedade e seu entorno, perante as necessidades e garantia de direitos básicos e justiça a todes (Dias, 2017).

Ao falar da intersexualidade, por exemplo, segundo Jordens e Carpenter (2022), os bioeticistas não têm se envolvido com o movimento Intersexo internacional e suas lutas. No entanto, na visão dos autores do texto aqui citado, essa relação deve ser permanente na busca pelo fortalecimento, embasamento e retroalimentação um do outro. Assim, defendemos aqui uma bioética engajada na luta e na contribuição para o movimento social Intersexo, assim como o envolvimento com outras causas e movimentos sociais (Jordens; Carpenter, 2022).

Uma bioética engajada é mais do que necessária: torna-se fundamental estar ao lado dos movimentos que questionam as diversas relações de poder. Acreditamos numa bioética capaz de sair da pesquisa somente com bioeticistas, unindo forças ao movimento Intersexo, questionando também o poder médico na luta por justiça e por direitos. A bioética deve ser capaz de adotar uma perspectiva crítica em relação às estruturas de poder dominantes e de promover o cuidado em saúde, tanto na medicina, como na sociedade.

A Perspectiva dos Funcionamentos fornece um aporte teórico importante para

pensarmos a intersexualidade, os funcionamentos básicos das pessoas Intersexo e a forma adequada de realização deles. Os funcionamentos básicos aqui identificados foram o da corporalidade integral e do acesso à informação (Dias, 2015, 2017).

Ambos foram apontados como fundamentais para o florescimento das pessoas Intersexo, tornando possível que a potência de seus corpos seja vivida por completo, com autonomia e com uma existência livre de quaisquer impedimentos ou restrições. A bioética, em nossa visão, precisa se juntar aos movimentos sociais e não só falar deles em pesquisas e textos, seus estudiosos precisam ser capazes de se desencastelar e serem partes da mudança.

Referências

AMUNDSON, R. Against normal function. **Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences**, v. 31, n. 1, p. 33-53, 2000.

ARCHARD, D.; MACLEOD, C. M. **The moral and political status of children**. [S. l.: s. n.], 2002.

ASCH, A. Appearance-altering surgery, children's sense of self. *In*: PARENS, E. **Surgically shaping children: technology, ethics, and the pursuit of normality**. New York: Johns Hopkins University Press, 2006.

ALVIM, M. B. O lugar do corpo em Gestalt-Terapia: dialogando com Merleau-Ponty. **Revista IGT na Rede**, v. 8, n. 15, p. 227-237, 2011.

ANDRADE, E. B. **Corpo e consciência**: Merleau-Ponty, crítico de Descartes. Porto Alegre: Fi, 2019. 170 p. Disponível em: <https://www.editorafi.org/576eloisa>. Acesso em: 11 mar. 2023.

BRANCO, F. D. **Corpos Intersexo**: borrando fronteiras da norma binária. 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande, 2018.

BRÚJULA INTERSEXUAL. Acerca de. **Brújula Intersexual**, 2023. Disponível em: <https://brujulaintersexual.org/acerca-de/>. Acesso em: 11 mar. 2023.

BUTLER, J. **Vida precária**: os poderes do luto e da violência. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

CAMARGO JUNIOR, K. R. Biomedicina, saber e ciência: uma abordagem crítica. *In*: CAMARGO JUNIOR, K. R. **Biomedicina, saber e ciência**: uma abordagem crítica. 2003.

CARPENTER, M. The “normalization” of intersex bodies and “othering” of intersex identities in Australia. **Journal of Bioethical Inquiry**, v. 15, n. 4, p. 487-495, 2018. DOI: 10.1007/s11673-018-9855-8.

CARPENTER, M.; JORDENS, C. F. When bioethics fails: Intersex, epistemic injustice and advocacy. In: WALKER, M. (ed.). **Interdisciplinary and global perspectives on intersex**. London: Palgrave Macmillan Cham: Springer International Publishing, 2022.

CHASE, C. ‘Re: The Five Sexes.’ Letter to the Editor, **The Sciences**, July/Aug. 1993. Disponível em: <https://isna.org/articles/chase1995a/>. Acesso em: 21 fev. 2023.

COLAPINTO, J. **Sexo trocado, a história real do menino criado como menina**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

CORTEZ, M. **Dualidade ou constelação?: intersexualidade, feminismo e biomedicina: uma análise bioética**. 2015. 163 f. Dissertação (Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução nº 1.664, de 12 de maio de 2003. Dispõe sobre as normas técnicas necessárias para o tratamento de pacientes portadores de anomalias de diferenciação sexual. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 13 maio 2003.

COSTA, A. G. **Fé cega, faca amolada**: reflexões acerca da assistência médico-cirúrgica à intersexualidade na cidade do Rio de Janeiro. 2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.

COSTA, A. G. **As (im)possibilidades do desenvolvimento**: enquadres da intersexualidade no Brasil contemporâneo. 2018. 264 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

DAVIS, G. **Contesting intersex**: the dubious diagnosis. New York: New York University Press, 2015a.

DAVIS, G. Normalizing intersex: the transformative power of stories. **Narrative Inquiry in Bioethics**, v. 5, n. 2, p. 87-89, 2015b. DOI: 10.1353/nib.2015.0055.

DAVIS, G.; PREVES, S. Reflecting on intersex. In: VALENTINE, C. G.; TRAUTNER, M. N.; SPADE, J. Z. (ed.). **The kaleidoscope of gender**: prisms, patterns, and possibilities. [S. l.]: Sage, 2019.

DIAS, M. C. A perspectiva dos funcionamentos: um olhar ecofeminista decolonial. **Revista Direito & Práxis**, v. 9, n. 4, p. 2503-2521, 2018. DOI: 10.1590/2179-8966/2018/37972.

DIAS, M. C. (org). **Bioética**: fundamentos teóricos e aplicações. Curitiba: Appris, 2017.

DIAS, M. C. (ed.). **A perspectiva dos funcionamentos**: em defesa de uma abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015. 226 p.

DOYLE, J.; ROEN, K. Surgery and embodiment: carving out subjects. **Body & Society**, v. 14, n. 1, p. 1-7, 2008. DOI: 10.1177/1357034X07087527.

DREGER, A. D. Ambiguous sex or ambivalent medicine. **The Hastings Center Report**, v. 28, n. 3, p. 24-35, 1998. DOI: <https://doi.org/10.2307/3528648>.

GUIMARÃES JUNIOR, A. R. **Identidade cirúrgica**: o melhor interesse da criança intersexo portadora de genitália ambígua. Uma perspectiva bioética. 2014. 151 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2014.

ECKERT, L. **Intersexualization**: the clinic and the colony. [S. l.]: Taylor & Francis, 2016a.

ECKERT, L. 'Diagnosticism': three cases of medical anthropological research into intersexuality. In: HOLMES, M. (ed.). **Critical intersex**. [S. l.]: Routledge, 2016b. p. 41-71.

FAUSTO-STERLING, A. The five sexes. **The Sciences**, v. 33, n. 2, p. 20-24, 1993.

FAUSTO-STERLING, A. Dualismos em duelo. **Cadernos Pagu**, p. 9-79, 2002.

FEINBERG, J. The child's right to an open future. In: AIKEN, W.; LAFOLLETTE, H. (ed.). **Whose child?**: children's rights, parental authority, and State power. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1980.

FOUCAULT, M. **Os Anormais**: curso no Collège de France (1974-1975) de 22 de janeiro de 1975. São Paulo: Martins Fontes, 2001. (Coleção Tópicos).

KARKAZIS, K. **Fixing sex**: Intersex, medical authority, and lived experience. Durham: Duke University Press, 2008.

KESSLER, S. J. **Lessons from the Intersexed**. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998.

KIM, E. **Curative violence**: rehabilitating disability, gender, and sexuality in modern Korea. Durham: Duke University Press, 2017.

LEE, P. A. *et al.* Global disorders of sex development update since 2006: Perceptions, approach and care. **Hormone Research in Paediatrics**, v. 85, n. 3, p. 158-180, 2016. DOI: 10.1159/000442975.

MACHADO, P. S. **O sexo dos anjos**: representações e práticas em torno do gerenciamento sociomédico e cotidiano da intersexualidade. 2008. 266 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/14947>. Acesso em: 15 jun. 2021.

MARTIN, D.; SPINK, M. J.; PEREIRA, P. P. G. Corpos múltiplos, ontologias políticas e a lógica do cuidado: uma entrevista com Annemarie Mol. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 22, p. 295-305, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/1807-57622017.0171>.

NOWAKOWSKI, A. C. H.; SUMERAU, J. E.; LAMPE, N. **Transformations in queer, trans, and intersex health and aging**. Maryland: Lexington Books, 2020.

PATOSALMI, M. Bodily integrity and conceptions of subjectivity. **Hypatia**, v. 24, n. 2, p. 125-141, 2009.

PIRES, B. G. “Integridade” e “debilidade” como gestão das variações intersexuais no esporte de alto rendimento. *In*: DIAS, M. B. (coord.). **Intersexo**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.p. 557-565.

POMBO, M. **A diferença sexual em mutação**: subversões queer e psicanalíticas. Curitiba: Calligraphie, 2021.

REIS, E. Did bioethics matter? A history of autonomy, consent, and intersex genital surgery. **Medical Law Review**, v. 27, n. 4, p. 658-674, 2019. DOI: [10.1093/medlaw/fwz007](https://doi.org/10.1093/medlaw/fwz007).

ROEN, K. Clinical intervention and embodied subjectivity: atypically sexed children and their parents. *In*: HOLMES, M. **Critical Intersex**. Farnham: Ashgate, 2016. p. 15-40.

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO. Departamentos Científicos SPSP - gestão 2010-2013. **Recomendações Atualização de Condutas em Pediatria Departamentos Científicos SPSP**, n. 58, 2011. Disponível em: https://www.spsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec_58_Timpanotomia.pdf. Acesso em: 22 abr. 2023.

SONEGHET, L. F. A subjetividade corporificada nos marcos da sociologia existencial. **Civitas: Revista de Ciências Sociais**, v. 21, p. 23-34, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.1.38992>.

SULLIVAN, N. The price to pay for our common good: Genital modification and the somatechnologies of cultural (In) Difference. **Social Semiotics**, v. 17, n. 3, p. 395-409, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1080/10350330701448736>.

SYTSMA, S. E. (ed.). **Ethics and intersex**. Dordrecht: Springer, 2006. v. 29.

THREADCRAFT, S. Embodiment. *In*: DISCH, L.; HAWKESWORTH, M. (ed.). **The Oxford handbook of feminist theory**. Oxford: Oxford Academic, 2015. 1089 p.

VERONESE, J. R. P. Os direitos da criança e do adolescente: construindo o conceito de sujeito-cidadão. *In*: WOLKMER, A. C.; LEITE, J. R. M. (org.). **Os 'novos' direitos no Brasil**: natureza e perspectivas: uma visão básica dos novos conflituosidades jurídicas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 380 p.

5 DISCUSSÃO

Em nosso cotidiano, a opressão se constitui como parte da paisagem social e se manifesta, por exemplo, como o racismo, o sexismo e o classismo. Essas opressões se reforçam mutuamente e têm semelhanças com outras opressões humanas, como a Intersexofobia e o naturismo³⁹ (Gaard, 2011).

O desfrutar humano da natureza, segundo Gaard, parte do ponto de que sua existência pode existir para ser dominada, ou seja, para ser destruída em favor da ideia de progresso segundo o desenvolvimentismo colonial e ao mesmo tempo artificializada para deleite e “convivência pacífica” como acontece nos parques das grandes cidades. Aqui reside a ideia de que a natureza serve ao ser humano (Gaard, 2011).

Gaard procura relacionar em seu trabalho a natureza, o humano e o queer. Ao falarmos em diversidade sexual e de gênero, ela nos lembra que há corpos que são observados como fora da hegemonia da hetero[cis]sexualidade. Esses corpos são muitas vezes lidos como aberrantes (Gaard, 2011; Lapoujade, 2015).

Esses corpos, tais como os apresentados neste trabalho, de pessoas Intersexo de genitália atípica, a biomedicina estuda desde o século 19 e ao longo do século 20. A partir desses estudos, uma forma de “cuidados em saúde” é traçada para eles. Um protocolo específico de cuidado foi criado nos anos 1960 e no séc. 21, na busca por artificializar esses corpos, até os mais recentes consensos nos anos de 2006 e 2016 (Germon, 2009; Lee *et al.*, 2006, 2016).

O aporte biológico-científico utilizado pela biomedicina tem sido fundamental para esse “cuidado”, primeiro com uma invenção/nomeação diagnóstica do que ela entende hoje como Desordem/Distúrbio da Diferenciação Sexual (DDS). Depois de nomeado, prossegue-se com um tratamento que pode arrolar cirurgia e hormonização a fim de artificializar e dominar aquele pequeno corpo aberrante (Lapoujade, 2015; Karkazis, 2008).

O que dizemos aqui é que a biologia ou a medicina não são somente ciências do aparecimento da doença ou de estruturas ambientais e animais. Antes de tudo, são frutos de um artesanato social que, depois de construído e institucionalizado (pensando com o texto de Gaard sobre o “cuidado” adotado para a intersexualidade

³⁹ Segundo os tradutores brasileiros do texto de Gaard, o naturismo, para a autora, seria a dominação da natureza pelos humanos e seu pensar sobre ela como algo existente para o desfrutar humano.

de genital atípico), dominam sobre uma ideia de uma natureza aparente que não convém e perturba o dimorfismo sexual (Santos, 2000; Gaard, 2011).

Esses corpos que perturbam a hegemonia da hetero[cis]sexualidade são corpos que estão sob o regime da hegemonia heteronormatividade (Marchia; Sommer, 2019; Carpenter *et al.*, 2022.). Para Butler (2003), esse regime prevê e idealiza como os corpos masculinos e femininos devem ser externamente, além de suas performances, que devem ser reiteradamente executadas.

Acabamos de descrever o que para Nowakowski, Sumerau e Lampe (2020), assim como para esta tese, entendem e nomeiam por endonormatividade. Um regime que produz e nomeia um corpo externa e internamente de acordo com o binário de gênero. Essa regulação normativa corporal também aparece no cuidado em saúde, que, segundo o Dicionário da Educação Profissional em Saúde (Pinheiro, 2009), é operada hegemonicamente a partir de um olhar biomédico.

Não negamos que haja outros modos de se praticar a medicina (Otani; Barros, 2011), porém, aqui partimos da premissa de que a biomedicina hegemônica (Camargo Junior, 2005) é a que mais acessa os corpos Intersexo. E nela o interesse está no diagnóstico e, a partir daí, ela direciona o uso e a forma do cuidado em saúde para este grupo de pessoas (Davis, 2011; Machado, 2008).

O diagnóstico os nomeia como os portadores de uma “doença” que pode ter diversas manifestações nas características sexuais do indivíduo. Entretanto, essa pessoa pode nunca saber o que o(a/e) acomete graças ao protocolo adotado para a intersexualidade, de segredo e silêncio sobre ela (Costa, 2018; Cortez, 2020; Pires, 2020).

Isso ocorre no mesmo país em que o cuidado em saúde deveria proceder pelo princípio da integralidade em saúde que rege o Sistema Único de Saúde (SUS), que se propõe a cuidar do ser humano como um todo (Pinho *et al.*, 2007). Porém, o que se nota no cuidado feito a essas pessoas é que esse cuidado integral em saúde não se realiza.

A endonormatividade procura garantir, por meio do poder biomédico, uma endossexualidade⁴⁰ na qual o ser, com sua subjetividade e sexualidade, é ignorado

⁴⁰ Palavra utilizada pela primeira vez em língua inglesa por Chris Mowat (2022). O significado usado pelo autor em nossa visão é o mesmo de Endosex (2022) é preciso aqui diferenciar para melhor sermos entendidos por quem nos lê. Nesta tese, a endossexualidade está inserida no dispositivo social da endonormatividade e, mais do que uma conformidade sexual que orienta o ordenamento da sociedade, produz um imaginário genital individual e não é homogêneo.

para que a endonormatividade continue a ser a estrutura fundamental que a sociedade e seus membros reiteradamente reproduzem (Nowakowski; Sumerau; Lampe, 2020). Melhor dizendo, sob essa lógica, tudo deve cooperar para que as características sexuais binárias se mantenham sem desvio, seja pela falta delas ou pelos aberrantes excessos delas.

Esse regime normativo preocupa-se com a aparência desses genitais, assim como as interações das características sexuais que as produzem, sejam elas hormonais, cromossômicas ou reprodutivas, a fim de não quebrarem o ciclo de reiteração, leitura e reconhecimento de corpo e gênero feito pelo mundo social (Carpenter *et al.*, 2022)

O surgimento do movimento social Intersexo, primeiramente nos Estados Unidos, em 1993, mudou essa paisagem intranquila, pois procurou promover pela denúncia a desestabilização de um ciclo “virtuoso” que ocorria no poder biomédico a respeito desse e de outros estados de intersexualidade. O poder biomédico no mundo gozou e ainda goza de privilégio nessa e em muitas outras questões; apesar disso, ele tem que lidar atualmente com um mundo em movimento, onde ora seu privilégio permanece, ora é desafiado (Davis; Preves, 2019).

A Isna foi a primeira associação Intersexo no mundo, e outras foram surgindo ao redor do globo. O movimento social Intersexo mundial tem tensionado em favor de um cuidado em saúde mais emancipador (Contatore; Malfitano; Barros, 2019; Barros, 2020), no qual o corpo, a subjetividade e a sexualidade do ser humano sejam ingredientes do processo para se obter saúde plena e não uma figura de uma narrativa passiva biográfica.

Nos artigos que compõem esta tese, buscamos denunciar as ações biomédicas que procuram garantir a continuação desse ciclo que por muito tempo seguiu intocado. Valorizamos o protagonismo da escrita e confecção de si em que muitas delas dividem sua narrativa com a sociedade no objetivo de convidar essas pessoas a saírem do anonimato e, se quiserem, convidar outras. Para isso, temos sugerido dois conceitos importantes criados por uma socióloga Intersexo canadense e adaptados para o contexto brasileiro: Intersexo e Intersexualizados (Charlebois, 2017).

O primeiro coloca a realidade do movimento social e caracteriza as subjetividades ali presentes como pessoas unidas por uma criação diagnóstica. E não somente isso: passam a se comportar ativamente na busca por conhecer e entender

o quadro imposto de forma protocolar pelo poder médico para si e a comunidade (Charlebois, 2017), passando a viver de forma ativa e a protagonizar o conhecimento sobre sua história pregressa, calada pelo pacto social entre o poder médico e a sociedade, ao mesmo tempo em que se integram cada vez mais a comunidade Intersexo. Tornando pública suas vidas e histórias, quebram o segredo e o silêncio imposto, suplantando a antiga realidade e expondo-a de forma crítica a sociedade (Charlebois, 2017).

A partir desse encontro com sua história e com a comunidade, começam a reescrevê-la, decidindo seus novos rumos e tomando as próprias escolhas. Dessa forma, mostra-se que a passividade de antes é possível de ser superada para mudar uma história que parecia ter um roteiro final.

Já o intersexualizado é aquele no qual o roteiro final já está escrito, e a criação diagnóstica funciona. Nele, toda a estrutura clínica protocolar procura produzir um sujeito passivo e sem condições de escrever a própria história (Charlebois, 2017). A biopolítica, em toda sua potência disciplinar, como diz Foucault (2008), procura ordenar esses corpos.

O tratamento busca, por meio da cirurgia, da hormonização e da educação no gênero decidido pelo poder biomédico, disciplinar e assujeitar esses indivíduos (Weinmann, 2006). Entretanto, compreendemos e buscamos demonstrar ao longo da tese que resistir à força desses poderes não é fácil, pode ser algo muito traumático para os que assim o fazem, porém, é possível, como demonstra Charlebois (2017).

As histórias aqui relatadas, como a minha no primeiro artigo e a de pessoas como Nik Lampe e Haru e de muitas outras pessoas Intersexo escondidas e/ou não tão conhecidas ao redor do globo, demonstram ser possível reescrever em cima do que foi escrito (Diamond; Sigmundson, 1997; Correia, 2004).

Uma escrita que não apaga o passado, mas toma as rédeas do presente e do futuro. Uma escrita que não ignora um redesenho assinado pelos médicos que nos tocaram no passado de cirurgia genital e pós-cirurgia, como dissemos no terceiro artigo, porém, assume-se uma reescrita na qual o corpo não é mais objeto abjeto do outro, mas passa a ser de propriedade exclusiva de uma nova assinatura: a da pessoa intersexualizada.

Essa assinatura cirúrgica que registramos e questionamos no segundo artigo, quando tomamos a caneta do passado e resolvemos, depois de muita dor, marcá-lo com nossa própria assinatura e trilhar outra e diferenciada jornada. O corpo que

possuímos tem a marca e a assinatura alheia, passa a ser esculpido por escolhas presentes que interrogam e revisitam o passado para compreender qual foi aquele “cuidado em saúde” executado em seu passado e qual o sentido real desse cuidado que vê no presente e sonha para o futuro.

O reconhecimento feito pela pessoa Intersexo é de que há em seu corpo marcas inesquecíveis, porém, a nova assinatura dessa pessoa, a quem pertence o rumo real do próprio corpo, promete agora um mundo de novas possibilidades, incluindo as marcas criadas pelo próprio sujeito, mais vívidas e menos doloridas (Derrida, 1988; Morland, 2022; Butler, 2003).

Assim, acontece um resgate de nossos funcionamentos, como articulamos no terceiro artigo. Somos um corpo que necessita de funcionamentos básicos para viver e que nos possibilitem ter condições de estarmos nesta sociedade capitalista como a brasileira. Faz-se necessário que para isso seja possível termos garantias como pessoas nascida com estado Intersexo: a garantia da corporalidade integral de nossos corpos e o acesso irrestrito a informação em saúde (Dias, 2015, 2017).

O corpo nascido em estado Intersexo, segundo a perspectiva bioética dos funcionamentos, necessita, para ser e existir como ser humano pleno, que sua corporalidade seja intocada pelo poder médico até sua própria decisão. Isso significa possibilitar um desenvolvimento corporal saudável com a valorização de sua subjetividade (Gonzales Rey, 2015; Barros, 2020).

O cuidado emancipador em saúde, como coloca Barros (2020), é ingrediente fundamental para que esses funcionamentos Intersexo sejam realidade. Nesse sentido, entendemos aqui a necessidade de uma prática em saúde horizontal, subjetiva, decolonial, capaz de tirar as travas trazidas pela colonialidade do ser, saber e poder (Reis, 2022) com vistas a produzir nos futuros corpos Intersexo de genital atípicos, possibilidades outras de fazerem sua própria história.

6 CONCLUSÃO

Após o nascimento e o retorno da criança para casa em nossa sociedade heteronormativa a cor de seu vestuário pode revelar seja para conhecidos ou até mesmo para transeuntes seu sexo. Como destaca Morland (2005), esses momentos muitas vezes se referem muito mais ao futuro do que o presente, pois se visa para o futuro daquele corpo um encaixe na sociedade em que vivemos. Neste sentido, pode-se dizer que o olhar do outro está moldado pela endonorma que costuma aparecer em sua vida cotidiana, ou seja, na ação da pessoa se antevê um certo tipo de performatividade para o futuro daquele pequeno ser (Butler, 2003).

O reconhecimento social binário de todos os corpos sejam eles endossexo ou Intersexo de genitália atípica começam na tenra idade. Para todos esses bebês, apesar de suas roupas esconderem grande parte dos seus corpos, seus genitais culturais estão à mostra. Nesse sentido faz-se necessário registrar que por mais que a identificação do indivíduo no sexo biológico esteja escondida, possivelmente, ela pode ser feita através de uma leitura visual e comportamental da presença do mesmo, ou seja, os genitais são além de biológicos, produtos da cultura. Por isso, genitais deslocados desse mundo não são reconhecidos e precisam se adequar a essa realidade por meio da cirurgia de redesenho genital (Morland, 2001; Grozs, 1995).

Ao submeter genitais Intersexo a uma cirurgia de redesenho, a medicina reforça uma grande parte de sua existência disciplinadora e produz uma materialidade corporal muito específica, submetendo-os a uma cultura restrita como a ocidental e aproximando dos genitais típicos masculinos ou femininos. Com o apagamento dos genitais Intersexo a favor de uma reiteração heteronormativa que não só aparece no corpo como também se mantém na linguagem, o poder médico legitima a estrutura da dicotomia sexual, apesar de a natureza desafiar sempre essa estrutura com a presença “incômoda” da intersexualidade (Morland, 2001).

A realidade no campo do gênero que conhecemos só existe graças à esta construção que permanentemente necessita de uma reiteração para que saibamos disso. Segundo Morland (2001), quando um genital intersexo passa pelo redesenho, na realidade ocorre ali uma desfiguração a partir dessa reiteração cirúrgica. Nesse momento, procura-se demarcar para a sociedade que a única possibilidade de existência dos genitais é endossexo.

Além disso, quando falamos dessa cirurgia genital é preciso lembrar que seu objetivo é impedir o corpo de ser como ele surgiu ou então deseja ser. Submeter-se a esse processo cirúrgico é também se colocar diante de uma dessubjetificação para uma resubjetificação orientada (Milanês, 2021). O Gênero da criança operada agora é conduzido por uma orientação médica visando o “melhor interesse” da mesma. Um interesse que diz ser em favor do outro, mas o exclui das reais decisões a respeito de si.

Tudo isso é graças a um binário de gênero que treme assustado diante da existência desse medonho genital. O diagnóstico do genital Intersexo utiliza a classificação de verdadeiro ou falso genital. E pelo que este trabalho nos lembra, vamos perceber que o real e o falso, na realidade, é uma criação diagnóstica em favor de uma única possibilidade (Kessler, 1998; Morland, 2001, 2022).

Por isso, percebo que a “assombrologia” de Mark Fisher (2022) é essencial para pensarmos a intersexualidade. Nessa toada, é possível dizer que a intersexualidade *não mais* é a monstrosidade indizível fruto de um passado no qual esse indivíduo era sujeito a tomada de decisão pela medicina. Ela ainda está sobre essa sombra e o presente desse *ser intersexo* ainda hoje continua a ser administrado pela muda sociedade ocidental (Fisher, 2022).

Apesar disso, este tempo presente dá novos e esperançosos sinais desde meados dos anos 2000 ao tornar a intersexualidade assunto de discussão nas ciências humanas. Ainda temos pouca produção feita por pessoas Intersexo na América Latina e nesse quesito possuímos o desafio de compreendermos ainda melhor suas manifestações na vida social já que para mim este é o real desafio de gênero que abala as estruturas societárias.

Faz-se urgente resgatar a sociologia existencial da subjetividade proposta por Soneheget (2021), em trabalhos futuros, para refletirmos sobre a subjetividade da pessoa Intersexo com genitália atípica e com outras condições Intersexo. Nesse sentido estamos a caminhar pelas sombras da impossibilidade na busca por brechas e lutas deveras difíceis.

A verdade do sexo teve por um tempo um único lado: da endonormatividade. Sob essa égide, corpos desviantes **como os** Intersexo com genital atípico necessitam ser adequados a norma com uma visita a sala de cirurgia para que só exista uma verdade do sexo e que seja colocada como realidade. Por isso, insisto

que nossa luta é tão necessária e é o real motivo da existência desse trabalho (Pires, 2015; Costa, 2014; Morland, 2001).

Nesse sentido, escrever Intersexo com “I” maiúsculo não é só uma valorização de uma agência pessoal que o protocolo de cuidado deseja tanto solapar, mas procura também ser uma chamada comunitária. Pessoal, no sentido de empenhar toda a força para lutar, sonhar e antever uma realidade outra para essas pessoas, a luta também passa a ser comunitária como uma convocação a sermos escritores e construtores de uma nova história. Essa luta é para mudar uma história que ainda não é como desejamos, mas pode vir a ser (Fisher, 2022; Campos; Gonçalves; Aragão, 2018).

Ainda lutamos contra uma classificação diagnóstica cujo destino de muitos parece certo, principalmente para aqueles com genitália atípica. Porém hoje com o conhecimento que temos a intersexualidade pode se tornar uma possibilidade de subversão. Uma subversão aos ouvidos abertos daqueles dispostos a ver além de certas falácias do poder médico.

Somos uma presença incomoda, pois ao habitar e convivermos em espaços onde a endonormatividade está, nossos corpos transmitem uma mensagem capaz de perturbar a estrutura normalizante. Uma mensagem que segue na busca por corações e mentes disponíveis para entender uma boa notícia. A palavra que conclama a sair da bolha da norma e enxergar estes corpos dissidentes.

Um relato que convida a abrir os olhos para corpos como o meu que tão tenros em idade, em vez da espera pela castração/mutilação não precisarem mais serem retalhados por um bisturi ansioso para adequar sem sequer ter seu consentimento. Os corpos Intersexo esperam ver histórias abordadas aqui serem só passado.

As Histórias de pessoas Intersexo de genitália atípica podem ser outras quando recebem cuidados em saúde de forma emancipadora (Barros, 2021) onde são partes integrantes do processo do cuidar. Um processo em que o tempo presente e o futuro possam apresentar muito mais alternativas para além do controle de suas escritas de si. Possibilitando um olhar médico muito mais ampliado, enxergando corpos múltiplos e capazes de viver além da precariedade mesquinha e servil de escritas de vida orientadas pela medicina. Enxergando no viver desses corpos desejantes o respeito por suas próprias escritas, tendo o poder médico como um aliado para uma vida saudável e feliz. Sabendo que saúde e felicidade só são

possíveis quando a individualidade do ser humano é respeitada, assim como suas decisões.

REFERÊNCIAS

BARROS, N. F. O cuidado emancipador e a simetria de poder. **Revista do Centro de Pesquisa e Formação**, n.10. 2020. Disponível em: https://www.sescsp.org.br/online/artigo/14650_NELSON+FILICE+DE+BARROS. Acessado em: 20 set. 2023.

BUTLER, J. **Problemas de gênero**: a subversão da identidade. São Paulo: Record, 2003

CAMARGO JUNIOR, K. R. A biomedicina. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 15, supl., p. 177-201, 2005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312005000300009>.

CARPENTER, M. Intersex human rights, sexual orientation, gender identity, sex characteristics and the Yogyakarta Principles plus 10. **Culture, Health & Sexuality**, v. 23, n. 4, p. 516-532, 2020. DOI: [10.1080/13691058.2020.1781262](https://doi.org/10.1080/13691058.2020.1781262).

CARPENTER, M.; DALKE, K.; EARP, B. D. Endosex. **Journal of Medical Ethics**, v. 49, n. 3, p. 225-226, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1136/medethics-2022-108317>.

CHARLEBOIS, J. B. Les sujets intersexes peuvent-ils (se) penser? Les empiétements de l'injustice épistémique sur le processus de subjectivation politique des personnes intersex (ué) es. **Socio**, v. 9, p. 143-162, 2017. DOI: <https://doi.org/10.4000/socio.2945>.

CONTATORE, O. A.; MALFITANO, A. P. S.; BARROS, N. F. Por uma sociologia do cuidado: reflexões para além do campo da saúde. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 17, p. e0017507, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00175>.

CORDEIRO, A. M. *et al.* Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do colégio brasileiro de cirurgiões**, v. 34, p. 428-431, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-69912007000600012>.

CORRÊA, M. Não se nasce homem. *In*: ENCONTROS ARRÁBIDA/ENCONTRO MASCULINIDADES/FEMINILIDADES, 2004, Portugal. Disponível em: https://edis.ciplinas.usp.br/pluginfile.php/4413181/mod_resource/content/1/Nao_se_nasce_home_m_-_Mariza_Correa.pdf. Acesso em: 20 jan. 2023.

CORTEZ, M. **Dualidade ou constelação?**: intersexualidade, feminismo e biomedicina: uma análise bioética. 2015. 163 f. Dissertação (Mestrado em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

CORTEZ, M. **In/Visibilia**: deslumbramentos e silenciamentos dos corpos intersexo. 2020. 257 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49001>. Acesso em: 12 fev. 2022.

COSTA, A. G. **Fé cega, faca amolada**: reflexões acerca da assistência médico-cirúrgica à intersexualidade na cidade do Rio de Janeiro. 2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/4276>. Acesso: 14 fev. 2022.

COSTA, A. G. Concepções de gênero e sexualidade na assistência em saúde à intersexualidade. **(SYN)Thesis**, v. 9, n. 1, p. 51-62, 2016. DOI: <https://doi.org/10.12957/synthesis.2016.42254>.

COSTA, A. G. **As (im)possibilidades do desenvolvimento**: enquadres da intersexualidade no Brasil contemporâneo. 2018. 264 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <https://www.bdt.d.uerj.br:8443/handle/1/4808>. Acesso em: 16 fev. 2022.

CRENSHAW, K. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. **Revista Estudos Feministas**, v. 10, p. 171-188, 2002.

DAVIES, R. *et al.* Aspects of socialization. *In*: DAVIES, R.; HOUGHTON, P. **Mastering psychology**. London: Red Globe Press, 1995. p. 16-31.

DAVIS, G. “Dsd is a perfectly fine term”: reasserting medical authority through a shift in intersex terminology. *In*: MCGANN, P. J.; HUTSON, D.; ROTHMAN, B. K. (ed.). **Sociology of diagnosis**. Bingley: Emerald Group Publishing, 2011. Disponível em: [https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1057-6290\(2011\)12](https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1057-6290(2011)12). Acesso em: 5 mar. 2021.

DAVIS, G.; PREVES, S. Reflecting on intersex. *In*: VALENTINE, C. G.; TRAUTNER, M. N.; SPADE, J. Z. (ed.). **The kaleidoscope of gender: prisms, patterns, and possibilities**. [S. l.]: Sage, 2019.

DENZIN, N. K. Performing [auto] ethnography politically. **The Review of Education, Pedagogy & Cultural Studies**, v. 25, n. 3, p. 257-278, 2003. DOI: 10.1080/10714410390225894.

DENZIN, N. K. **Performance autoethnography**: critical pedagogy and the politics of culture. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2018.

DIAMOND, M.; SIGMUNDSON, H. K. Sex reassignment at birth: long-term review and clinical implications. **Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine**, v. 151, n. 3, p. 298-304, 1997. Disponível em: <https://www.cirp.org/library/psych/diamond/>. Acessado em: 13 abr. 2021.

DIAS, M. C. A perspectiva dos funcionamentos: desconstruindo o modelo biomédico, sociocultural e jurídico de identidade pessoal. *In*: CONGRESSO DESCONSTRUINDO O GÊNERO, 2018, Florianópolis. **Anais [...]**. [S. l.: s. n.], 2018.

DIAS, M. C. (org.). **Perspectiva dos funcionamentos**: fundamentos teóricos e aplicações. Rio de Janeiro: Ape'Ku, 2019.

DIOGO, M. **Território-corpo em retomada**: práticas e saberes das plantas na construção de autonomia e cura das dissidências de gênero e sexualidade. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Humanidades) – Instituto de Humanidades e Letras dos Malês, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, São Francisco do Conde, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2977>. Acesso em: 2 dez. 2023.

DINIZ, D.; GUILHEM, D. **O que é bioética**. São Paulo: Brasiliense, 2002. 69 p.

FERNÁNDEZ-CAMACHO, M. Una metodología militante: “Parar para pensar”. **LiminaR**, v. 19, n. 1, p. 15-29, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.29043/liminar.v19i1.790>.

FOUCAULT, M. **Nascimento da biopolítica**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

FOUCAULT, M. A escrita de si. In: FOUCAULT, M. **O que é um autor?** Lisboa: Passagens, 1992.

FOUCAULT, M. O verdadeiro sexo. In: FOUCAULT, M. **Herculine Barbin**: o diário de um hermafrodita. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.

GAARD, G. C. Rumo ao ecofeminismo queer. **Revista Estudos Feministas**, v. 19, p. 197-223, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-026X2011000100015>.

GERMON, J. **Gender**: a genealogy of an idea. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

GÓES, J. Ciência sucessora e a(s) epistemologia(s): saberes localizados. **Revista Estudos Feministas**, v. 27, p. e48373, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n148373>.

GOFFMAN, E. **A representação do eu na vida cotidiana**. Tradução: Maria Célia Santos Raposo. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

GRANT, M. J.; BOOTH, A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. **Health Information & Libraries Journal**, v. 26, n. 2, p. 91-108, 2009. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/26260835_A_typology_of_reviews_An_analysis_of_14_review_types_and_associated_Methologies. Acesso em: 01 nov. 2023.

Grosz, E. **Space, time and perversion**: essays on the politics of bodies. New York: Routledge, 1995.

GUIMARÃES JUNIOR, A. R. **Identidade cirúrgica**: o melhor interesse da criança intersexo portadora de genitália ambígua. Uma perspectiva bioética. 2014. 151 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2014.

HARAWAY, D. Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial. **Cadernos Pagu**, n. 5, p. 7-41, 2009. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773>. Acesso em: 15 dez. 2021.

KARKAZIS, K. **Fixing sex**: intersex, medical authority, and lived experience. Durham: Duke University Press, 2008.

KESSLER, S. J.; MCKENNA, W. **Gender**: an ethnomethodological approach. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

LAPOUJADE, D. **Deleuze, os movimentos aberrantes**. Tradução: Laymert Garcia dos Santos. São Paulo: N-1, 2015. 319 p.

LEE, P. *et al.* (in collaboration with the participants in the International Consensus Conference on Intersex organized by the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society and the European Society for Paediatric Endocrinology). Consensus Statement on Management of Intersex Disorders. **Pediatrics**, v. 118, n. 2, p. 488-500, 2006. DOI: 10.1542/peds.2006-0738.

LEE, P. A. *et al.* Global disorders of sex development update since 2006: Perceptions, approach and care. **Hormone Research in Paediatrics**, v. 85, n. 3, p. 158-180, 2016. DOI: 10.1159/000442975.

LIMA, S. A. M. **Intersexo e (in)visibilidade**: cidadania e saúde na busca do Registro Geral de Identificação (RG). 2014. 103 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/47090>. Acesso em: 23 jun. 2021.

LIMA, S. A. M. **Intersexo e identidade**: história de um corpo reconstruído. 2007. 110 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/PUC_SP-1_3483a48d8621a6db5d9ef096941e3437. Acessado em: 20 jun. 2021.

MACHADO, P. S. **O sexo dos anjos**: representações e práticas em torno do gerenciamento sociomédico e cotidiano da intersexualidade. 2008. 266 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/14947>. Acesso em: 15 jun. 2021.

MACHADO, P. S. (Des) fazer corpo, (re) fazer teoria: um balanço da produção acadêmica nas ciências humanas e sociais sobre intersexualidade e sua articulação com a produção latino-americana. **Cadernos Pagu**, p. 141-158, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-8333201400420141>.

MARCHIA, J.; SOMMER, J. M. (Re)defining heteronormativity. **Sexualities**, v. 22, n. 3, 2019. DOI: 10.1177/1363460717741801.

MEYERS, Q. Strange tensions: legacies of the colonial racial history of trans identities and intersex subjectivities. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 199- 210, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1215/23289252-9612851>.

MILANEZ, N. A noção foucaultiana de dessubjetivação: alicerces, experiências e modos de agir do sujeito. **Policromias-Revista de Estudos do Discurso, Imagem e Som**, v. 6, n. 3, p. 12-39, 2021. DOI: <https://doi.org/10.61358/policromias.v6i3.45050>

MILLS, C. W. **A imaginação sociológica**. Tradução: Waltensir Dutra. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982.

MORLAND, I. Intersexuality is real? **Textual Practice**, v.15, n. 3, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1080/09502360110070439>.

MORLAND, I. Intersex surgery between the gaze and the subject. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 160-171, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1215/23289252-9612781>.

MOWAT, C. A prehistory of intersex, or: the lives and afterlives of the “hermaphrodite”. In: MOORE, K. (ed.). **The Routledge companion to the reception of ancient Greek and Roman gender and sexuality**. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2022. p. 572-592. eBook ISBN: 9781003024378.

NOWAKOWSKI, A. C. H. ; SUMERAU, J. E. ; LAMPE, N. **Transformations in queer, trans, and intersex health and aging**. Maryland: Lexington Books, 2020.

ORR, C. E. Resisting the demand to stand: Boys, bathrooms, hypospadias, and interphobic violence. **Boyhood Studies**, v. 12, n. 2, p. 89-113, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3167/bhs.2019.120206>.

OTANI, M. A. P.; BARROS, N. F. A Medicina Integrativa e a construção de um novo modelo na saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 16, p. 1801-1811, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000300016>.

PINHEIRO, R. Cuidado em saúde. **Dicionário da Educação profissional em Saúde**, c2009. Disponível em: <http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/cuisau.html>. Acessado em: 27 nov. 2023.

PINHO, L. B. *et al.* A integralidade no cuidado em saúde: um resgate de parte da produção científica da área. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 9, n. 3, p. 835-846, 2007. DOI: <https://doi.org/10.5216/ree.v9i3.7511>.

PIRES, B. **Distinções do desenvolvimento sexual**: percursos científicos e atravessamentos políticos em casos de intersexualidade. 2015. 136 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

PIRES, B. **A gestão da Integridade**: corpo, sujeição e regulação das variações intersexuais no esporte de alto rendimento. 2020. 322 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

POLLOCK, D. Part I introduction: performance trouble. *In*: MADISON, D. S.; HAMERA, J. (ed.). **The SAGE handbook of performance studies**. p. 1-8. Thousand Oaks: Sage, 2006. p. 1-8.

PRECIADO, P. B. **Manifesto contrassexual**: práticas subversivas de identidade sexual. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. São Paulo: N-1, 2014, 224 p.

RAIMONDI, G. A. *et al.* A autoetnografia performática e a pesquisa qualitativa na Saúde Coletiva:(des)encontros método+lógicos. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00095320, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-311X000.95320>.

RAIMONDI, G. A.; MOREIRA, C.; BARROS, N. F. O corpo negado pela sua “extrema subjetividade”: expressões da colonialidade do saber na ética em pesquisa. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 23, p. e180434, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.180434>.

REY, F. G.; BIZERRIL, J. (org.). **Saúde, cultura e subjetividade**: uma referência interdisciplinar. Brasília: UniCEUB, 2015. Disponível em: https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/5756/1/Sa%C3%BAde_Cultura_Subjetividade.pdf. Acesso em: 13 fev. 2023.

REIS, D. S. A colonialidade do saber: perspectivas decoloniais para repensar a univers (al) idade. **Educação & Sociedade**, v. 43, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/ES.240967>.

RICH, A. Heterossexualidade compulsória e existência lésbica. **Bagoas – Estudos Gays**: Gêneros e Sexualidades, v. 4, n. 5, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2309>. Acesso em: 12 fev. 2021.

SANTOS, L. H. A Biologia tem uma História que não é Natural. *In*: COSTA, M. V. (org.). **Estudos Culturais em educação**: mídia, arquitetura, brinquedo, biologia, literatura, cinema. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2000.

SCHIAVON, A. A.; FAVERO, S.; MACHADO, P. S. A ciência que vigia o berço: diferentes leituras de “saúde” frente a crianças trans e crianças Intersexo. **Revista Brasileira de Estudos da Homocultura**, v. 3, n. 9, 2020. DOI: 10.31560/2595-3206.2020.9.10553.

SILVA, B. F. **Intersexualidade e corpos “perfeitos”**: uma revisão sobre discursos e produção de estigma. 2019. 52 f. Monografia (Bacharelado em Sociologia) – Universidade Federal fluminense, Niterói, 2019.

SONEGHET, L. F. A subjetividade corporificada nos marcos da sociologia existencial. **Civitas - Revista de Ciências Sociais**, v. 21, p. 23-34, 2021. DOI: <https://doi.org/10.15448/1984-7289.2021.1.38992>.

TEIXEIRA, D. A. **Fisiologia humana**. Teófilo Otoni: Unipac, 2021. cap. 5, p. 36-43.

WALL, S. S. Standing at the intersections: navigating life as a black intersex man. **Narrative Inquiry in Bioethics**, v. 5, n. 2, p. 117-119, 2015. DOI: 10.1353/nib.2015.0046.

WEINMANN, A. O. Dispositivo: um solo para a subjetivação. **Psicologia & Sociedade**, v. 18, p. 16-22, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-71822006000300003>.

APÊNDICE

APÊNDICE A – SITES, LISTA DE LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS OU ARTIGOS FEITOS POR PESSOAS INTERSEXO

CAROLINA IARA RAMOS DE OLIVEIRA

OLIVEIRA, Carolina Iara de. A busca pelo corpo perfeito: uma rápida etnografia e análise interseccional da intersexualidade. In: GOMES, Aguinaldo Rodrigues; LION, Antonio Ricardo Calori de (orgs.). **Corpos em trânsito: existências, subjetividades e representatividades**. Salvador: Editora Devires, 2020.

OLIVEIRA, Carolina Iara de; RICOLDI, Arlene. Sem “Loas” na juventude e aposentadoria em risco: uma autoetnografia sobre o ativismo por direitos em HIV/aids. **Saúde e Sociedade**, v. 31, p. e200460, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sausoc/a/8xgzVf9F36KtVZJ9Dnw3TBR/>

OLIVERA, C.I; FRANCISCO, A.H.S; GONÇALVES, M.L. Identidades sexuais e de gênero e suas relações com a cultura. In: CIASCA, S.V; HERCOWITZ, A.; JUNIOR, A.L. Saúde LGBTQIA+ práticas de cuidado transdisciplinar. Editora Manole; 1ª edição, 2021.

OLIVEIRA, Carolina Iara Ramos .Formas de Matar, Morrer e Resistir: A saúde mental e integral de pessoas trans negras In: CUNHA, N; OLIVEIRA, L; DIAS, J.; PRESTES, C. (Orgs.). Enfrentamento dos efeitos do racismo, cissexismo e transfobia na saúde mental. São Paulo: Ed. Dandara; **Instituto AMMA Psique e Negritude**, 2021. p. 31-48 Disponível em: <https://cleiaprestes.com/wp-content/uploads/2023/12/CUNHA-Neon-et-al.-O-enfrentamento-do-racismo-cissexismo-e-transobia-na-saude-mental.-Organizacao.-Dandara-2021.pdf>

CHERYL CHASE pseudônimo de BO LAURENT

CHASE, Cheryl. Hermaphrodites with attitude: Mapping the emergence of intersex political activism. In: **The Transgender Studies Reader Remix**. Routledge, 2022. p. 572-588. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003206255-60/hermaphrodites-attitude-cheryl-chase>.

HEGARTY, Peter; CHASE, Cheryl. Intersex activism, feminism and psychology. In: **Queer theory**. Palgrave, London, 2005. p. 70-80. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959353500010001014> .

CHASE, Cheryl; DREGER, Alice D.; SOUSA, Aron; GRUPPUSO, Philip A.; FRADER, Joel. Changing the nomenclature/taxonomy for intersex: A scientific and clinical rationale. **Journal of pediatric endocrinology and metabolism**, v. 18, n. 8, p. 729-734, 2005. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/JPEM.2005.18.8.729/html>

CHASE, Cheryl. What is the agenda of the intersex patient advocacy movement?. **The Endocrinologist**, v. 13, n. 3, p. 240-242, 2003. Disponível em: https://journals.lww.com/theendocrinologist/fulltext/2003/05000/what_is_the_agenda_of_the_intersex_patient.21.aspx

CHASE, Cheryl. Affronting reason. **Looking queer: Body image and identity in lesbian, bisexual, gay, and transgender communities**, p. 205-220, 1998. Disponível em: <https://books.google.com/books?hl=pt-BR&lr=&id=OXsd4FmBIA8C&oi=fnd&pg=PA205&dq=Affronting+reason.&ots=atOAibv31m&sig=BRHkZ2cGN-l7b-g8opEtYx-ZjUE>

GEORGIANN DAVIS

DAVIS, Georgiann. Intersexy, but fat: On the selective celebration of bodily differences. In: **Introducing the New Sexuality Studies**. Routledge, 2022. p. 273-281. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003163329-35/intersexy-fat-georgiann-davis>

DAVIS, Georgiann; JIMENEZ, Jonathan. Not Going to the Chapel?: Intersex Youth and an Exploration of Marriage Desires and Expectations. In: **Expanding the Rainbow**. Brill, 2019. p. 247-264. Disponível em: <https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789004414105/BP000034.pdf>

DAVIS, Georgiann; RAY, Ranita. Pediatric participation in a diverse society: accounting for social inequalities in medical decision making. **The American Journal of Bioethics**, v. 18, n. 3, p. 24-26, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2017.1418927>

DAVIS, Georgiann; EVANS, Maddie Jo. Surgically shaping sex: A gender structure analysis of the violation of intersex people's human rights.p. 273-284, 2018. In: RISMAN, B., FROYUM, C., SCARBOROUGH, W. (eds) **Handbook of the Sociology of Gender**. Springer: New York, USA. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-76333-0_20

SIMMONDS, Margaret; O'Brien, Michelle; LIN-SU, Karen; DELIMATA, Natalie; DAVIS, Georgiann; AUCHUS, Richard.. Evaluating the term 'disorders of sex development': A multidisciplinary debate. **Social Medicine**, v. 11, n. 3, p. 98-107, 2018. Disponível em: <https://medicinasocial.info/index.php/socialmedicine/article/view/932>

YERKES, Elizabeth B.; ROSOKLIJA, Ilina; MADONNA, Mary Beth; JOHNSON, Emilie K.; HOLL, Jane L.; FINLAYSON, Courtney; DAVIS, Georgiann; CHENG, Earl Y.; CHEN, Diane; BARATZ, Arlene B. Attitudes towards "disorders of sex development" nomenclature among affected individuals. **Journal of pediatric urology**, v. 13, n. 6, p. 608. e1-608. e8, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477513117301833>

DAVIS, Georgiann; PREVES, Sharon. Intersex and the social construction of sex. **Contexts**, v. 16, n. 1, p. 80-80, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1536504217696082>

DAVIS, Georgiann; PREVES, Sharon; HIGHT, Elena. The Ongoing Fight For Intersex Rights. **Sociological Imagination**, v. 53, n. 1, 2017. Disponível em: <https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Agcd%3A12%3A13736492/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Agcd%3A125403696&crl=c>

DAVIS, Georgiann; WAKEFIELD, Chris. The intersex kids are all right? Diagnosis disclosure and the experiences of intersex youth. In: **Gender, Sex, and Sexuality among Contemporary Youth: Generation Sex**. Emerald Publishing Limited, 2017. p. 43-65. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1537-466120170000023004/full/html>

DAVIS, Georgiann. Intersexuality. **The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies**, p. 1-4, 2016. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118663219.wbegss380>

DAVIS, Georgiann; DEWEY, Jodie M.; MURPHY, Erin L. Giving sex: Deconstructing intersex and trans medicalization practices. **Gender & Society**, v. 30, n. 3, p. 490-514, 2016. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891243215602102>

KARKAZIS, Katrina; DAVIS, Georgiann. Intersex: socio-cultural perspectives. **The International encyclopedia of human sexuality**, p. 609-613, 2015. Disponível em: https://www.academia.edu/download/51393768/G_240.pdf

TAMAR-MATTIS, Anne; SONKSEN, Peter; KIDD, Bruce; FERGUSON-SMITH, Malcolm A.; HOLT, Richard I. G.; EDWARDS, Lisa; COWAN, David A.; CATLIN, Don H.; DAVIS, Georgiann; DAVIS, Paul; BAVINGTON, L. Dawn. Medical and ethical concerns regarding women with hyperandrogenism and elite sport. **The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism**, v. 100, n. 3, p. 825-827, 2015. Disponível em: <https://academic.oup.com/jcem/article/100/3/825/2839044>

DAVIS, Georgiann. **Contesting intersex: The dubious diagnosis**. NYU Press, 2015.

DAVIS, Georgiann. Normalizing intersex: the transformative power of stories. **Narrative Inquiry in Bioethics**, v. 5, n. 2, p. 87-89, 2015. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/article/589203>

DAVIS, Georgiann. The power in a name: Diagnostic terminology and diverse experiences. **Psychology & Sexuality**, v. 5, n. 1, p. 15-27, 2014. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19419899.2013.831212>

DAVIS, Georgiann. The social costs of preempting intersex traits. **The American Journal of Bioethics**, v. 13, n. 10, p. 51-53, 2013. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15265161.2013.828119>

RISMAN, Barbara J.; DAVIS, Georgiann. From sex roles to gender structure. **Current Sociology**, v. 61, n. 5-6, p. 733-755, 2013. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011392113479315>

DAVIS, Georgiann; MURPHY, Erin L. Intersex bodies as states of exception: An empirical explanation for unnecessary surgical modification. **Feminist Formations**, p. 129-152, 2013. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/43860689>

KARKAZIS, Katrina; JORDAN-YOUNG, Rebecca; DAVIS, Georgiann; CAMPORES, Silvia. Out of bounds? A critique of the new policies on hyperandrogenism in female athletes. **The American journal of bioethics**, v. 12, n. 7, p. 3-16, 2012. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15265161.2012.680533>

DAVIS, Georgiann. **Gender Players and Gender Prisoners: When Intersex Activism, Medical Authority, and Terminology Collide**. 2012. Tese de Doutorado. University of Illinois at Chicago. Disponível em: https://indigo.uic.edu/articles/thesis/Gender_Players_and_Gender_Prisoners_When_Intersex_Activism_Medical_Authority_and_Terminology_Collide/10912415

DAVIS, Georgiann. "DSD is a perfectly fine term": Reasserting medical authority through a shift in intersex terminology. In: **Sociology of diagnosis**. Emerald Group Publishing Limited, 2011. p. 155-182. Disponível em: https://www.academia.edu/download/31126636/Davis2011_DSDisPerfectlyFineTerm.pdf.

HANA AOI

LE ROUX, Gabrielle ; MOKOENA, Nthabiseng ; KAGGWA, Julius ; AOI, Hana. Collaborative Portraits for Intersex Justice. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 248-254, 2022. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/9/2/248/312495>

INTER, Laura; AOI, Hana. Circular 7 de 2016: Un paso Atrás en la Lucha por los Derechos Humanos de las Personas Intersexuales en Chile. 2016. Disponível em: <https://brujulaintersexual.org/wp-content/uploads/2017/06/circular-7-laura-y-hana11.pdf>

AOI, H. La importancia del apoyo mutuo y las redes sociales. **Vivir y ser intersex. Espacio de difusión y reflexión en torno a la intersexualidad**, 2017. Disponível em: <https://vivirintersex.org/2017/03/22/la-importancia-del-apoyo-mutuo-y-las-redes-sociales/>

AOI, H. La intersexualidad no es un argumento para la identidad de género: una denuncia. **Vivir y ser intersex. Espacio de difusión y reflexión en torno a la intersexualidad**, 2017. Disponível em: <https://vivirintersex.org/2017/09/02/la-intersexualidad-no-es-un-argumento-para-la-identidad-de-genero-una-denuncia/>

AOI, H. Derechos humanos intersex e intervenciones médicas", **Dfensor. Revista de Derechos Humanos**, núm. 3, p.10-16, 2018. Disponível em: https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2018/07/dfensor_03_2018.pdf

AOI, H. #IntersexDay 2018: Mi testimonio, a dos años de distancia., **Vivir y ser intersex. Espacio de difusión y reflexión en torno a la intersexualidad, 2018.** Disponible em: <https://vivirintersex.org/2018/10/26/intersexday-2018-mi-testimonio-a-dos-anos-de-distancia/>

HIDA VILORIA

VILORIA, Hida; NIETO, Maria. **The spectrum of sex: the science of Male, female, and intersex.** Jessica Kingsley Publishers, 2020.

VILORIA, Hida. **Born both: An intersex life.** Hachette UK, 2017.

VILORIA, Hida. Promoting health and social progress by accepting and depathologizing benign intersex traits. **Narrative Inquiry in Bioethics**, v. 5, n. 2, p. 114-117, 2015. Disponible em: <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/589213/summary>

IAIN MORLAND

MORLAND, Iain. Intersex Surgery between the Gaze and the Subject. **Transgender Studies Quarterly**, v. 9, n. 2, p. 160-171, 2022. Disponible em: <https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/9/2/160/312499>

Morland, I. Afterword: Genitals are history. **Postmedieval** 9, p. 209–215, 2018. Disponible em: <https://link.springer.com/article/10.1057/s41280-018-0083-5>

MORLAND, Iain; WILLOX, Dino. **Queer theory.** Bloomsbury Publishing, 2017.

MORLAND, Iain. Between critique and reform: Ways of reading the intersex controversy. In: **Critical intersex.** Routledge, 2016. p. 191-213. Disponible em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315575018-9/critique-reform-ways-reading-intersex-controversy-ian-morland>

DOWNING, Lisa; MORLAND, Iain; SULLIVAN, Nikki. **Fuckology: critical essays on John Money's diagnostic concepts.** University of Chicago Press, 2015. Disponible em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226186757/html>

MORLAND, Iain. Gender, genitals and the meaning of being human. **Fuckology: Critical essays on John Money's diagnostic concepts**, p. 69-98, 2015. Disponible em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226186757-005/pdf?licenseType=restricted>

MORLAND, Iain. Cybernetic sexology. **Fuckology: Critical essays on John Money's diagnostic concepts**, v. 101, 2015. Disponible em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.7208/9780226186757-006/pdf?licenseType=restricted>

MORLAND, Iain. Intersex. **Transgender Studies Quarterly**, v. 1, n. 1-2, p. 111-115, 2014.

MORLAND, Iain. The injured world: Intersex and the phenomenology of feeling. **differences**, v. 23, n. 2, p. 20-41, 2012. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/differences/article-abstract/23/2/20/60642>

MORLAND, Iain. Intersex treatment and the promise of trauma. **Gender and the science of difference: Cultural politics of contemporary science and medicine**, p. 147-63, 2011. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.36019/9780813550794-009/pdf?licenseType=restricted>

MORLAND, Iain. Why Five Sexes Are Not Enough. In: **The Ashgate Research Companion to Queer Theory**. Routledge, 2009. p. 33-48. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315613482-4/five-sexes-enough-iain-morland>

MORLAND, Iain. Introduction: lessons from the octopus. **GLQ: A journal of lesbian and gay studies**, v. 15, n. 2, p. 191-197, 2009. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/glq/article/15/2/191/34640/INTRODUCTION-LESSONS-FROM-THE-OCTOPUS>

MORLAND, Iain. What can queer theory do for intersex?. **GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies**, v. 15, n. 2, p. 285-312, 2009. Disponível em: <https://read.dukeupress.edu/glq/article-abstract/15/2/285/34653/WHAT-CAN-QUEER-THEORY-DO-FOR-INTERSEX>

MORLAND, Iain. Intimate violations: Intersex and the ethics of bodily integrity. **Feminism & Psychology**, v. 18, n. 3, p. 425-430, 2008. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959353508095926>

MORLAND, Iain. Postmodern intersex. In: **Ethics and intersex**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006. p. 319-332. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/1-4220-4314-7_20.pdf

MORLAND, Iain. The injustice of intersex: feminist science studies and the writing of a wrong. In: **Toward a critique of Guilt: Perspectives from law and the humanities**. Emerald Group Publishing Limited, 2005. p. 53-75. Disponível em: [https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S1059-4337\(05\)36004-2/full/html](https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1016/S1059-4337(05)36004-2/full/html)

MORLAND, Iain. 'The Glans Opens Like a Book': Writing and Reading the Intersexed Body. **Continuum**, v. 19, n. 3, p. 335-348, 2005. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/103043110500176586>

MORLAND, Iain. Feminism and intersexuality: A response to Myra J. Hird's 'Gender's Nature'. **Feminist Theory**, v. 2, n. 3, p. 362-366, 2001. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14647000122229578>

MORLAND, Iain. Management of intersex. Correspondence in **Lancet**, v. 358, n. 9298, p. 2085-2086, 2001. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(01\)07121-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)07121-5/fulltext)

MORLAND, Iain. Is intersexuality real? **Textual Practice**, v. 15, n. 3, p. 527-547, 2001. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502360110070439>

MORLAND, Iain; WILLOX, Dino. Is Germaine Greer a Man? The Politics and Ethics of Queer Feminism. Sem Data. Disponível em: https://www.academia.edu/download/56860607/Is_Germaine_Greer_a_Man_2018.pdf

LAURA INTER

SITE : <https://brujulaintersexual.org/>

INTER, Laura. Finding my compass. **Narrative Inquiry in Bioethics**, v. 5, n. 2, p. 95-98, 2015. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/pub/1/article/589206/summary>

MAURO CABRAL GRINSPAN

AGGLETON, Peter; CARPENTER, Morgan; CROCETTI, Daniela; DAVIS, Georgiann; GARLAND, Fae; GRIFFITHS, David; GRINSPAN, Mauro Cabral; HEGARTY, Peter; TRAVIS, Mitchell. Intersex: cultural and social perspectives. **Culture, Health & Sexuality**, v. 23, n. 4, p. 431-440, 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691058.2021.1899529>

WINTER, Sam; SCHWEND, Amets Suess; SMILEY, Adam; GRINSPAN, Mauro Cabral; CHIAM, Zhan. Depathologising gender diversity in childhood in the process of ICD revision and reform. **Global Public Health**, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17441692.2018.1427274>

CABRAL, Mauro. “Qué es ser intersex: conceptos para derrumbar mitos y prejuicios”. Agencia Presentes Artículo, 26 de octubre de 2018. Disponível em: <https://agenciapresentes.org/2018/10/26/que-es-ser-intersex-conceptos-para-derrumbar-mitos-y-prejuicios/>

GRINSPAN, Mauro Cabral; CARPENTER, Morgan. Gendering the Lens: Critical Reflections on Gender, Hospitality and Torture. **Gender Perspectives on Torture**, 183 p.; 2018. Disponível em: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37936.pdf#page=203>

GRINSPAN, Mauro Cabral. Torture in Medical Healthcare Settings: An Intersex Approach. **The Journal of Sexual Medicine**, v. 14, n. 5, p. e267, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609517307427>

CABRAL, Mauro. No saber—acerca de XXY. **CLAM: Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos**, 2008. Disponível em: <https://www.clam.org.br/uploads/conteudo/artigomauro.pdf>

CABRAL, Mauro. El doble acceso a la identidad. **CLAM: Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos**, 2011. Disponível em: <http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/Dobleaccesoalaidentidad-MauroCabral.pdf>

CABRAL, Mauro (Ed.). Interdicciones. Escrituras de la intersexualidad en castellano. Córdoba: Anarrés Editorial, p. 16-30, 2009. Disponível em: <http://www.mulabilatino.org/Interdicciones2.pdf>

CABRAL, Mauro. En estado de excepción: intersexualidad e intervenciones sociomédicas. In CÁCERES, Carlos F.; CAREAGA, Gloria; FRASCA, Tim; PECHENY, Mario. **Sexualidad, estigma y derechos humanos: desafíos para el acceso a la salud en América Latina**, p. 69-90, Lima: FASPA/UPCH, 2006. Perú. Disponível em: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52889>

CABRAL, Mauro. El cuerpo en el cuerpo: una introducción a las biopolíticas de la intersexualidad. **Orientaciones: Revista de Homosexualidades**, Fundación Triangulo, Madrid, nº 11, p. 47-68, 2006. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3246349>

ROJMAN, Ariel; CABRAL, Mauro. La muerte de un extraño. **Nombres**, n. 19, 2005. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/NOMBRES/article/download/2344/1281>

CABRAL, Mauro; BENZUR, Gabriel. Cuando digo intersex: un diálogo introductorio a la intersexualidad. **cadernos pagu**, p. 283-304, 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cpa/a/BTKLQY9xSMWHqn3t4CqMPzb/?lang=es>

CABRAL, Mauro. Pensar la intersexualidad, hoy. In MAFFIA, Diana (comp.) **Sexualidades migrantes. Género y transgénero**, Buenos Aires: Feminaria Editora. p. 117-126, Argentina, 2003. Disponível em: <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52885>

LIMOR MEODED DANON

DANON, Limor Meoded; SCHWEIZER, Katinka; THIES, Barbara. Opportunities and challenges with the German act for the protection of children with variations of sex development. **International Journal of Impotence Research**, v. 35, n. 1, p. 38-45, 2023. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41443-022-00614-z>

MEODED DANON, Limor. The geneticisation of intersex bodies in Israel. In: **Interdisciplinary and global perspectives on intersex**. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 219-239. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91475-2_13

MEODED DANON, Limor. Temporal sociomedical approaches to intersex* bodies. **History and philosophy of the life sciences**, v. 44, n. 2, p. 28, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40656-022-00511-0>

MEODED DANON, Limor. The parental struggle with the Israeli genital socialization process. **Qualitative Health Research**, v. 31, n. 5, p. 898-912, 2021. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732320984420>

MEODED DANON, L.; SCHWEIZER, K. Psychosocial Approaches and Discursive Gaps in Intersex Healthcare. **European Journal of Public Health**, v. 31, n. Supplement_3. Disponível em: https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab164.319/6405720

DANON, Limor Meoded; SCHWEIZER, Katinka. Psychosocial approaches and discursive gaps in intersex healthcare: findings from an Israeli–German action research study. **Culture, Health & Sexuality**, v. 23, n. 4, p. 441-456, 2020. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13691058.2020.1810779>

DANON, Limor Meoded. Comparing contemporary medical treatment practices aimed at intersex/DSD bodies in Israel and Germany. **Sociology of Health & Illness**, v. 41, n. 1, p. 143-164, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.12812>

DANON, Limor Meoded. Comparing contemporary medical treatment practices aimed at intersex/DSD bodies in Israel and Germany. **Sociology of Health & Illness**, v. 41, n. 1, p. 143-164, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9566.12812>

MEODED DANON, Limor. Moral Equality, Bioethics, and the Child: Claudia Wiesemann, 2016, Springer: Dordrecht, 155pp. 2019. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11673-019-09935-z>

MEODED DANON, Limor. Intersex activists in Israel: Their achievements and the obstacles they face. **Journal of Bioethical Inquiry**, v. 15, n. 4, p. 569-578, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11673-018-9877-2>

DANON, Limor Meoded. Time matters for intersex bodies: Between socio-medical time and somatic time. **Social Science & Medicine**, v. 208, p. 89-97, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618302545>

DANON, Limor Meoded; KRÄMER, Anike. Between concealing and revealing intersexed bodies: Parental strategies. **Qualitative Health Research**, v. 27, n. 10, p. 1562-1574, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1049732317697100>

MEODED-DANON, Limor; YANAY, Niza. Intersexuality: On secret bodies and secrecy. **Studies in gender and sexuality**, v. 17, n. 1, p. 57-72, 2016. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15240657.2016.1135684>

DANON, Limor Meoded. The body/secret dynamic: Life experiences of intersexed people in Israel. **Sage Open**, v. 5, n. 2, p. 2158244015580370, 2015. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244015580370>

DANON, Limor Meoded. The body/secret dynamic: Life experiences of intersexed people in Israel. **Sage Open**, v. 5, n. 2, p. 2158244015580370, 2015. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244015580370>

MORGAN CARPENTER

Ussher, Jane M, Morgan Carpenter, Rosalie Power, Samantha Ryan, Kimberley Allison, Bonnie Hart, Alexandra Hawkey, and Janette Perz. 2024. “I’ve Had Constant Fears That I’ll Get Cancer”: The Construction and Experience of Medical Intervention on Intersex Bodies to Reduce Cancer Risk’. **International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being**. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2024.2356924>

Carpenter, Morgan. 2024. ‘From Harmful Practices and Instrumentalisation, towards Legislative Protections and Community-Owned Healthcare Services: The Context and Goals of the Intersex Movement in Australia’. **Social Sciences** 13 (4): 191. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-0760/13/4/191>

Carpenter, Morgan, Cynthia Kraus, and Brian D. Earp. 2024. ‘Reply to Hadidi’. **Journal of Pediatric Urology**. Disponível em: [https://www.jpuirol.com/article/S1477-5131\(24\)00095-0/abstract](https://www.jpuirol.com/article/S1477-5131(24)00095-0/abstract)

Carpenter, Morgan, Cynthia Kraus, and Brian D. Earp. 2024. “Should We Correct Hypospadias during Childhood?” A Question of Facts and Values’. **Journal of Pediatric Urology**. Disponível em: [https://www.jpuirol.com/article/S1477-5131\(24\)00062-7/abstract](https://www.jpuirol.com/article/S1477-5131(24)00062-7/abstract)

Modra, Lucy J., Alisa M. Higgins, David V. Pilcher, Ada S. Cheung, Morgan N. Carpenter, Michael Bailey, Sav Zwickl, and Rinaldo Bellomo. 2024. ‘Epidemiology of Intensive Care Patients Classified as a Third Sex in Australia and New Zealand’. **CHEST**. Disponível em: [https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692\(23\)05842-7/fulltext](https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(23)05842-7/fulltext)

Carpenter, Morgan. 2024. ‘Fixing Bodies and Shaping Narratives: Epistemic Injustice and the Responses of Medicine and Bioethics to Intersex Human Rights Demands’. *Clinical Ethics*. 19 (1): 3-17. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/14777509231180412?ai=1gvoi&mi=3ricys&af=R>

Carpenter, Morgan. 2023. ‘Protecting Intersex People from Harmful Practices in Medical Settings: A New Benchmark in the Australian Capital Territory’. *Australian Journal of Human Rights* 29 (2): 409-417. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1323238X.2023.2247863>

Carpenter, Morgan, Katharine Dalke, and Brian D. Earp. 2023. ‘Endosex’. *Journal of Medical Ethics* 2023 (49):225-226. Disponível em: <https://jme.bmj.com/content/49/3/225.long>

Carpenter, Morgan. 2023. 'Shaping Bodies and Shaping Narratives: Intersex People, Epistemic Injustice and Human Rights'. PhD thesis, Sydney, Australia: University of Sydney. Disponível em: <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/31944>

Carpenter, Morgan. 2023. 'The Health and Human Rights of People with Intersex Variations' in the *Routledge Handbook on Sexuality, Health and Rights*, 2nd edition, edited by Peter Aggleton, Richard Parker, Rob Cover, Christy Newman and Carmen Logie. Routledge. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003278405-12/health-human-rights-people-intersex-variations-morgan-carpenter>

Carpenter, Morgan. 2022. 'Ambivalent Attention and Indeterminate Outcomes: Constructing Intersex and DSD in Australian Data'. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361524468_Ambivalent_attention_and_indeterminate_outcomes_constructing_intersex_and_DSD_in_Australian_data

Carpenter, Morgan. 2022. 'Intersex Human Rights in a Time of Instrumentalization and Backlash'. In *Human Rights at the Intersections: Transformations through Addressing New Challenges*, edited by Sofia Gruskin, Anthony Tirado Chase, Hussein Banai and Pardis Mahdavi. Bloomsbury. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/365848033_Intersex_Human_Rights_in_a_Time_of_Instrumentalization_and_Backlash

Carpenter, Morgan, and Christopher Jordens. 2022. 'When Bioethics Fails: Intersex, Epistemic Injustice and Advocacy'. In *Interdisciplinary and Global Perspectives on Intersex*, edited by Megan Walker. London: Palgrave Macmillan. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-91475-2_7

Carpenter, Morgan. 2022. 'Global Intersex, an Afterword: Global Medicine, Connected Communities, and Universal Human Rights'. In *Interdisciplinary and Global Perspectives on Intersex*, edited by Megan Walker. London: Palgrave Macmillan. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91475-2>

Carpenter, Morgan. 2021. 'Health Needs of People with Intersex Variations'. General Practice Supervisors Australia. Disponível em: <https://gpsupervisorsaustralia.org.au/product/lgbtqia-health-and-inclusive-healthcare-in-general-practice-an-introduction-to-teaching-and-learning/>

Carpenter, Morgan. 2021. 'Intersex Human Rights, Sexual Orientation, Gender Identity, Sex Characteristics and the Yogyakarta Principles plus 10'. *Culture, Health and Sexuality* 23 (4): 516-532. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32679003/>

Carpenter, Morgan. 2020. 'Caster Semenya's Life and Achievements Are Cause for Celebration, Respect and Inclusion; Her Exclusion Is Consequential'. *Journal of Medical Ethics* 46 (9): 593-4. Disponível em: <https://jme.bmj.com/content/46/9/593>

Carpenter, Morgan. 2020. 'The OHCHR Background Note on Human Rights Violations against Intersex People'. *Sexual and Reproductive Health Matters* 28 (1): 1–4. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26410397.2020.1731298>

Carpenter, Morgan. 2020. 'Intersex'. In *Oxford Bibliographies in Sociology*, edited by Lynette Spillman. New York: Oxford University Press. Disponível em: <https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199756384/obo9780199756384-0232.xml>

Karkazis, Katrina, and Morgan Carpenter. 2018. 'Impossible "Choices": The Inherent Harms of Regulating Women's Testosterone in Sport'. *Journal of Bioethical Inquiry* 15 (4): 579–87. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30117064/>

Carpenter, Morgan. 2018. 'Intersex Variations, Human Rights, and the International Classification of Diseases'. *Health and Human Rights* 20 (2): 205–14. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6293350/>

Carpenter, Morgan. 'The "Normalisation" of Intersex Bodies and "Othering" of Intersex Identities'. In *The Legal Status of Intersex Persons*, edited by Jens Scherpe, Anatol Dutta, and Tobias Helms, 445–514. Cambridge, England: Intersentia, 2018. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/books/abs/legal-status-of-intersex-persons/normalisation-of-intersex-bodies-and-othering-of-intersex-identities/05CE047B705691070D430A0177CDD6D9>

Carpenter, Morgan. 'Torn between Two Worldviews: Intersex People and Marriage Equality'. In *Going Postal: More than 'Yes' or 'No'*, 42–47. Melbourne: Brow Books, 2018. Disponível em: <https://www.theliftebrow.com/going-postal-more-than-yes-or-no>

Carpenter, Morgan, and Dawn Hough. Employers' Guide to Intersex Inclusion. Sydney, Australia: Pride in Diversity and Organisation Intersex International Australia Limited, 2014. Disponível em: <https://ihra.org.au/employer>

Carpenter, Morgan, and Nexus Research Co-operative. The Employment of People with Disabilities in Small and Medium-Sized Enterprises. Dublin, Ireland: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions; 1998. Disponível em: http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/1998/09/en/1/ef9809en.pdf.

SEAN SAIFA WALL

MONRO, Surya; WALL, Sean Saifa; WOOD, Kate. Intersex equality, diversity and inclusion and social policy: Silences, absences, and erasures in Ireland and the UK. **Critical Social Policy**, v. 44, n. 1, p. 3-22, 2024. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/02610183231175055>

SKAGGS, Courtney; WALL, Sean Saifa. Intersex Youth: A Call for Dignity in Mental Health Care. In: **The Palgrave Encyclopedia of Critical Perspectives on Mental Health**. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 1-9. Disponível em: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-030-12852-4_95-1

WALL, Sean Saifa; LAUREANO, Bianca I. Intersex Activism, Movement, and Joy: In Conversation with Sean Saifa Wall. In: **The People's Book of Human Sexuality**. Routledge, 2023. p. 175-190. Disponível em: <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003181927-15/intersex-activism-movement-joy-sean-saifa-wall-bianca-laureano>

WALL, Sean Saifa. 1. Reconceptualising Intersex Embodiment. **Intersex Studies: A Multidisciplinary Exploration**, p. 12 -26. Disponível em: https://intersexnew.co.uk/wp-content/uploads/2024/01/D2.2-D8-INIA-ebook_reduced.pdf#page=12

WALL, Sean Saifa. 39. Intersex. In: **Keywords for Gender and Sexuality Studies**. New York University Press, 2021. p. 133-135. Disponível em: <https://www.degruyter.com/document/doi/10.18574/nyu/9781479808168.003.0043/html>

WALL, Sean Saifa. Standing at the intersections: navigating life as a Black intersex man. **Narrative inquiry in bioethics**, v. 5, n. 2, p. 117-119, 2015. Disponível em: <https://muse.jhu.edu/article/589214>